ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

ASOFAMECh PERFIL V3

TOMO 16 · DE

Manual de

DERMATOLOGÍA

Psoriasis, Cáncer de piel & NET

Módulo 2 · Cirugía y Especialidades · 18 clases

Índice general

01 Semiología Cutánea, Acné, Rosácea & Alopecias 3

16.1. Lesiones Elementales Primarias y Secundarias de la Piel 5
16.2. Acné Vulgar: Escalonamiento Tópico, Oral e Indicaciones de Isotretinoína 9
16.3. Rosácea: Subtipos Clínicos y Manejo Médico 13
16.4. Alopecias: Androgenética, Areata y Efluvio Telógeno 17

02 Dermatosis Inflamatorias, Psoriasis & Eccemas 22

16.5. Psoriasis Vulgar: Fenómeno de Koebner, Auspitz y Terapias Tópicas/Sistémicas 25
16.6. Dermatitis Atópica: Hanifin y Rajka, Corticoides Tópicos e Hidratación 30
16.7. Dermatitis Seborreica vs Dermatitis de Contacto (Alérgica vs Irritativa) 34
16.8. Urticaria Aguda y Crónica: Habones Evanescentes, Angioedema y Antihistamínicos 38

03 Farmacodermias Graves & Enfermedades Ampollares 43

16.9. Reacciones Medicamentosas Graves: Stevens-Johnson (SSJ) y Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET) 45
16.10. Síndrome DRESS: Erupción Medicamentosa con Eosinofilia y Síntomas Sistémicos 49
16.11. Pénfigo Vulgar (Intraepidérmico) vs Penfigoide Ampollar (Subepidérmico) 54
16.12. Eritema Multiforme: Morfología en Diana Clásica y Asociación a Virus Herpes Simple 59

04 Oncología Cutánea, Lesiones Premalignas & Infecciones Cutáneas 65

16.13. Melanoma Maligno: Regla ABCDE, Biopsia Excisional, Índice de Breslow y Márgenes Quirúrgicos 68
16.14. Carcinomas Cutáneos No Melanoma: Carcinoma Basocelular (CBC) vs Carcinoma Espinocelular (CEC) 73
16.15. Lesiones Cutáneas Premalignas: Queratosis Actínica, Cuerno Cutáneo y Nevos Displásicos 77
16.16. Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis 81
16.17. Tumores Benignos de Piel, Hemangiomas Infantiles y Malformaciones Vasculares 86
16.18. Loxoscelismo (Loxosceles laeta): Cuadro Cutáneo y Cutáneo-Visceral, Manejo y Prevención en la Vivienda 91

Solucionario & Justificaciones Razonadas EUNACOM 96

MANUAL EUNACOM DE DERMATOLOGÍA

BLOQUE 01 DE 04 · PERFIL DE CONOCIMIENTOS V3 ASOFAMECH

perfil v3 asofamech
7 CÓDIGOS OFICIALES

01

BLOQUE TEMÁTICO
4 clases

SEMIOLOGÍA CUTÁNEA, ACNÉ, ROSÁCEA & ALOPECIAS

4	3	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
16.1	Lesiones Elementales Primarias y Secundarias de la Piel	5
16.2	Acné Vulgar: Escalonamiento Tópico, Oral e Indicaciones de Isotretinoína	9
16.3	Rosácea: Subtipos Clínicos y Manejo Médico	13
16.4	Alopecias: Androgenética, Areata y Efluvio Telógeno	17

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

7 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
6.01.3.003	Manifestaciones cutáneas de enfermedades sistémicas Tema 16.1		Conocimiento	
6.01.1.009	Eritema nodoso / Eritema indurado de Bazin Tema 16.1	Sospecha	Inicial	Derivar
6.01.1.032	Vitiligo Tema 16.1	Sospecha	Inicial	Derivar
6.01.1.001	Acné Tema 16.2	Específico	Completo	Completo
2.01.1.104	Acné Tema 16.2	Específico	Completo	Derivar
6.01.1.026	Rosácea Tema 16.3	Específico	Inicial	Completo
6.01.1.002	Alopecías Tema 16.4	Sospecha	Inicial	Derivar

BLOQUE 01 · SEMIOLOGÍA CUTÁNEA, ACNÉ, ROSÁCEA & ALOPECIAS

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
3 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

Mácula < 1 cm plana; Mancha > 1 cm plana (ambas sin relieve detectable a la palpación).
Pápula < 1 cm sólida; Placa > 1 cm sólida en meseta (confluye de pápulas).
Nódulo = lesión sólida profunda hipodérmica que se palpa más de lo que se ve.
Habón o roncha = placa edematosa evanescente que dura menos de 24 horas.
Vesícula < 0.5 cm líquida; Ampolla > 0.5 cm líquida.
La erosión compromete solo epidermis y CURA SIN CICATRIZ; la úlcera compromete dermis y DEJA CICATRIZ.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

3 DE 4 TEMAS

Lesiones Elementales Primarias y Secundarias de la Piel	EUNACOM Diciembre 2022 · #42
Rosácea: Subtipos Clínicos y Manejo Médico	EUNACOM Diciembre 2018 · #61
Alopecias: Androgenética, Areata y Efluvio Telógeno	EUNACOM Diciembre 2018 · #151

16.1. Lesiones Elementales Primarias y Secundarias de la Piel

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 6.01.3.003 6.01.1.009 6.01.1.032

¿POR QUÉ?

La dermatología es una especialidad eminentemente visual y morfológica. En el EUNACOM, la descripción exacta de la lesión elemental es la clave que permite identificar instantáneamente la patología en la viñeta clínica. El médico debe diferenciar con precisión mácula de pápula, vesícula de ampolla, y erosión de úlcera.

1. LESIONES ELEMENTALES PRIMARIAS: PLANAS Y LÍQUIDAS

Se desarrollan sobre una piel previamente sana, sin modificaciones previas:

• **Lesiones Planas (Cambio de coloración sin relieve ni depresión detectable a la palpación):**

- **Mácula:** Lesión plana circunscrita con diámetro **menor a 1 cm** (ej. efélides/pecas, léntigos, petequias).
- **Mancha:** Lesión plana con diámetro **mayor a 1 cm** (ej. mancha café con leche, vitíligo, melasma). Si desaparece a la digitopresión (vitropresión positiva), es vascular congestiva (eritema); si no desaparece (vitropresión negativa), es purpúrica por extravasación hemática.

• **Lesiones con Contenido Líquido:**

- **Vesícula:** Colección circunscrita de líquido seroso o hemático en epidermis, con diámetro **menor a 0.5 cm** (ej. herpes simple, herpes zóster, varicela).
- **Ampolla o Flictena:** Colección líquida con diámetro **mayor a 0.5 – 1 cm** (ej. pénfigo, penfigoide, quemaduras de 2.° grado).
- **Pústula:** Colección superficial de contenido **purulento** desde su inicio (ej. acné pustuloso, foliculitis). **(ver Imagen 16.1A, B y C)**

2. LESIONES ELEMENTALES PRIMARIAS SÓLIDAS

• **Pápula:** Elevación sólida circunscrita de la piel con diámetro **menor a 1 cm**, que cura sin dejar cicatriz (ej. verruga plana, liquen plano, molusco contagioso).

• **Placa:** Elevación sólida en meseta con extensión en superficie mayor que en altura, diámetro **mayor a 1 cm**, frecuentemente formada por confluencia de pápulas (ej. psoriasis vulgar).

• **Nódulo:** Lesión redondeada u ovoide sólida, localizada en **dermis profunda o tejido celular subcutáneo (hipodermis)**, con diámetro mayor a 1 cm. **Se palpa más de lo que se ve**; suele ser firme y puede dejar cicatriz (ej. eritema nudoso, lipoma).

• **Habón o Roncha:** Placa edematosa sobreelevada, rosada o blanquecina con halo eritematoso, producida por edema dérmico vasomotor mastocitario. Característica patognomónica: **EVANESCENTE (dura menos de 24 horas y desaparece sin dejar secuela)**.

3. LESIONES ELEMENTALES SECUNDARIAS (DESTINADAS A CICATRIZAR)

Resultan de la evolución natural o agresión externa (rascado, infección) de una lesión primaria previa:

• **Por pérdida de sustancia:**

- **Erosión o Excoriación:** Pérdida superficial circunscrita que compromete **únicamente la epidermis**. **CURA SIN DEJAR CICATRIZ** (ej. ampolla rota, rascado por sarna).
- **Úlcera:** Pérdida de sustancia profunda que destruye la membrana basal y compromete la **dermis o hipodermis**. **SIEMPRE DEJA CICATRIZ** al curar (ej. úlcera venosa, mal perforante plantar).
- **Fisura o Grieta:** Desgarro lineal doloroso de la piel sin pérdida neta de sustancia (ej. quelitis angular, tiña interdigital).

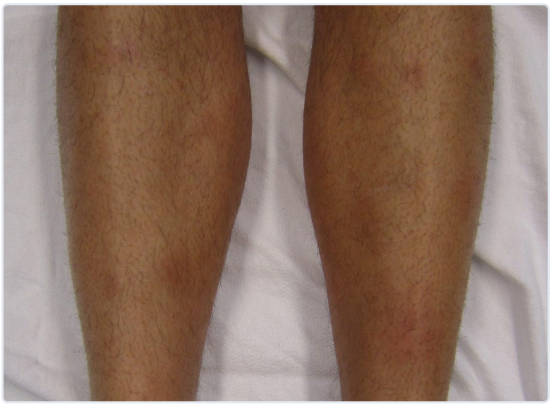
• **Por acumulación o residuo:**

- **Escama:** Laminillas córneas epidérmicas desprendidas en exceso (ej. ictiosis, psoriasis).
- **Costra:** Desecación de exudado seroso (amarillenta), sangre (marrón-rojiza) o pus (costra melicérica en impétigo).
- **Escara:** Tejido necrótico negro y seco delimitado de piel sana (ej. loxoscelismo cutáneo, úlcera por presión).
- **Liquenificación:** Engrosamiento cutáneo reactivo con acentuación exagerada de las cuadrículas normales de la piel, causado por el rascado crónico repetitivo.

4. MANIFESTACIONES CUTÁNEAS DE ENFERMEDADES SISTÉMICAS, ERITEMA NUDOSO Y VITÍLIGO

La piel como ventana de enfermedades internas. Cuando 6.01.3.003 una lesión no calza con una dermatosis primaria, la semiología elemental orienta a buscar una enfermedad sistémica: **acantosis nigricans** (placas pardas aterciopeladas en cuello y axilas) = resistencia a la insulina o diabetes y, si es de inicio brusco en un adulto mayor, neoplasia visceral (gástrica); **eritema malar con fotosensibilidad** = lupus eritematoso; **pápulas de Gottron y heliotropo** = dermatomiositis (en adultos, buscar neoplasia); **púrpura palpable** en piernas = vasculitis (púrpura de Schönlein-Henoch en niños); **eritema nudoso** = sarcoidosis, tuberculosis, estreptococo o enfermedad inflamatoria intestinal; **pioderma gangrenoso** (úlcera de borde violáceo y socavado) = enfermedad inflamatoria intestinal o artritis reumatoide; **xantelasmas y xantomas** = dislipidemia; **hiperpigmentación generalizada** = insuficiencia suprarrenal o hemocromatosis; **livedo reticular** = síndrome antifosfolípido; **prurito generalizado sin lesiones primarias** = colestasis, uremia, alteración tiroidea o linfoma; **vitíligo** = autoinmunidad tiroidea. La conducta es buscar activamente la enfermedad de fondo (hemograma, glicemia, función hepática, renal y tiroidea, anticuerpos antinucleares según sospecha) y tratar la causa más que la lesión.

Eritema nudoso y eritema indurado de Bazin (sospecha, tratamiento inicial y derivación). 6.01.1.009 El **eritema nudoso** es una paniculitis septal: nódulos rojos, calientes y dolorosos de 1 a 5 cm, **bilaterales en la cara anterior de las piernas (pretibiales)**, más frecuentes en mujeres de 20 a 40 años, que no se ulceran, no dejan cicatriz y evolucionan en 2 a 6 semanas con cambio de color «contusiforme» (rojo, violáceo, verdoso, amarillo). Puede acompañarse de fiebre, malestar y artralgias de tobillos. Sus causas son: **infección estreptocócica** (la más frecuente en niños), **tuberculosis**, **sarcoidosis** (síndrome de Löfgren: eritema nudoso, adenopatías hiliares bilaterales y artritis de tobillos), enfermedad inflamatoria intestinal, fármacos (anticonceptivos orales, penicilinas, sulfas), embarazo y lepra (eritema nudoso leproso). Estudio inicial: hemograma, VHS y PCR, cultivo faríngeo y ASO, **radiografía de tórax**, PPD y test de embarazo. Tratamiento inicial: reposo con piernas elevadas, AINE y tratar la causa; los casos refractarios o sin causa se derivan. El **eritema indurado de Bazin** (vasculitis nodular) se diferencia porque los nódulos se ubican en la **cara posterior de las pantorrillas**, en mujeres jóvenes, con curso crónico y recidivante, **tienden a ulcerarse y dejar cicatriz** y se asocian a tuberculosis (tuberculide): exige biopsia, estudio de tuberculosis y derivación.



Eritema nudoso

Vitíligo (sospecha, tratamiento inicial y derivación). Es una 6.01.1.032 enfermedad autoinmune que destruye los melanocitos y produce **manchas acrómicas (blanco tiza), de bordes netos, sin descamación ni atrofia**, en cara (periorificial), dorso de manos y dedos, codos, rodillas y genitales; afecta al 0,5 a 1% de la población, con fenómeno de Koeb-

ner positivo y a veces pelo blanco (leucotriquia) dentro de la mancha. Se asocia a otras enfermedades autoinmunes: **tiroiditis de Hashimoto**, diabetes tipo 1, anemia perniciosa, enfermedad de Addison y alopecia areata, por lo que se pide TSH y anticuerpos antiperoxidasa y glicemia. El diagnóstico es clínico y la lámpara de Wood acentúa el color blanco-lechoso. Diferenciar de pitiriasis alba y de pitiriasis versicolor (esta descama y se tiñe con el KOH), nevo acrómico, hipopigmentación posinflamatoria y lepra tuberculoide (hipoestésica). Tratamiento inicial: **fotoprotección estricta** (la piel sin melanina se quema con facilidad), corticoide tópico de alta potencia en zonas pequeñas por 2 a 3 meses o inhibidor tópico de calcineurina (tacrolimus) en cara y pliegues; se deriva para **fototerapia UVB de banda estrecha** o cirugía de injertos en casos estables, junto con apoyo psicológico por su impacto estético.



A. MANCHA CAFÉ CON LECHE



B. VESÍCULAS (VARICELA)



C. EXANTEMA MACULOPAPULAR

Imagen 16.1

FIGURA 16.1 · ÁRBOL TAXONÓMICO DE LESIONES ELEMENTALES PRIMARIAS



TABLA 16.1 · RESUMEN TAXONÓMICO DE LESIONES ELEMENTALES PRIMARIAS VS SECUNDARIAS

6.01.3.003, 6.01.1.009, 6.01.1.032

LESIÓN	TIPO / CONTENIDO	TAMAÑO DE CORTE	NIVEL ANATÓMICO	EJEMPLO CLÍNICO TÍPICO
Mácula	Plana (cambio color)	< 1.0 cm	Epidérmica / Dérmica	Efélide (peca), petequia
Mancha	Plana (cambio color)	> 1.0 cm	Epidérmica / Dérmica	Vitíligo, mancha mongólica
Pápula	Sólida sobreelevada	< 1.0 cm	Epidermis / Dermis superficial	Acné pápula, liquen plano
Placa	Sólida en meseta	> 1.0 cm	Epidermis / Dermis	Psoriasis en placas
Nódulo	Sólido circunscrito	> 1.0 cm	Dermis profunda / Hipodermis	Eritema nudoso
Habón / Roncha	Edema dérmico evanescente	Variable	Dermis papilar/reticular	Urticaria aguda (< 24 horas)
Vesícula	Líquido seroso/hemático	< 0.5 cm	Intra / Subepidérmico	Herpes simple, varicela
Ampolla	Líquido seroso/hemático	> 0.5 – 1.0 cm	Intra / Subepidérmico	Penfigoide ampollar, quemadura
Erosión	Pérdida superficial	Variable	Solo Epidermis (SIN cicatriz)	Ampolla desnudada
Úlcera	Pérdida profunda	Variable	Llega a Dermis (CON cicatriz)	Úlcera varicosa venosa

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 16.1

Hombre de 32 años consulta por lesiones pruriginosas en los codos. Al examen físico se aprecian lesiones sobreelevadas sólidas eritematosas que miden entre 3 y 5 cm de diámetro, con superficie aplanada en meseta y cubiertas por abundantes escamas plateadas que confluyen formando áreas extensas.

Conducta oficial. La lesión descrita es una Placa (elevación sólida circunscrita de la piel con diámetro mayor a 1 cm y extensión en superficie que supera su grosor). La coexistencia de eritema sobreelevado en meseta con descamación laminar plateada sobre las superficies de extensión es la lesión elemental clásica y diagnóstica de la Psoriasis Vulgar en placas.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Mácula < 1 cm plana; Mancha > 1 cm plana (ambas sin relieve detectable a la palpación).
- Pápula < 1 cm sólida; Placa > 1 cm sólida en meseta (confluye de pápulas).
- Nódulo = lesión sólida profunda hipodérmica que se palpa más de lo que se ve.
- Habón o roncha = placa edematosa evanescente que dura menos de 24 horas.
- Vesícula < 0.5 cm líquida; Ampolla > 0.5 cm líquida.
- La erosión compromete solo epidermis y CURA SIN CICATRIZ; la úlcera compromete dermis y DEJA CICATRIZ.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 16.1

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.3.003

1. Una paciente de 25 años consulta por una erupción cutánea diseminada. El médico describe lesiones circunscritas de contenido líquido claro seroso, de 2 a 3 milímetros de diámetro, agrupadas en racimo sobre una base eritematosa en el labio superior. ¿Cuál es el nombre semiológico exacto de esta lesión elemental primaria?

A) Pústula
B) Vesícula
C) Ampolla
D) Pápula
E) Erosión

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.3.003

2. ¿Cuál es la diferencia semiológica e histológica fundamental entre una erosión y una úlcera cutánea?

A) La erosión compromete solo la epidermis y cura sin dejar cicatriz, mientras que la úlcera compromete la dermis o hipodermis y cura dejando cicatriz
B) La erosión es siempre de origen infeccioso bacteriano y la úlcera es de origen autoinmune
C) La erosión es una lesión primaria y la úlcera es una lesión terciaria
D) La úlcera es indolora mientras que la erosión cursa con dolor lancinante
E) La erosión es mayor a 5 cm y la úlcera es menor a 1 cm

Más preguntas online de Lesiones Elementales Primarias y Secundarias de la Piel →

16.2. Acné Vulgar: Escalonamiento Tópico, Oral e Indicaciones de Isotretinoína

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 6.01.1.001 2.01.1.104

¿POR QUÉ?

El acné vulgar es la enfermedad inflamatoria cutánea más frecuente de la adolescencia y juventud. Afecta la unidad pilosebácea y su fisiopatología tetrafactorial define el tratamiento. El médico debe dominar el escalamiento desde retinoides tópicos hasta tetraciclinas orales, y conocer con exactitud las indicaciones y precauciones vitales de la isotretinoína oral.

1. FISIOPATOLOGÍA TETRAFACTORIAL Y CLASIFICACIÓN CLÍNICA

El acné involucra cuatro pilares patogénicos concatenados: 6.01.1.001 2.01.1.104

1. **Hiperqueratinización folicular del infundíbulo:** Tapón queratínico que ocluye el ostium folicular formando la lesión elemental primaria: el **COMEDÓN**.
2. **Hipersecreción sebácea:** Estimulada por andrógenos en la pubertad.
3. **Proliferación de *Cutibacterium acnes*** (antes *Propionibacterium acnes*): Bacteria anaerobia comensal que degrada triglicéridos a ácidos grasos libres proinflamatorios.
4. **Inflamación y respuesta inmune local:** Quimiotaxis de neutrófilos con rotura folicular hacia la dermis.

• **Clasificación Clínica:**

- *Acné Comedoniano (No inflamatorio):* Comedones abiertos ("puntos negros" por oxidación de la melanina y queratina) y comedones cerrados ("puntos blancos").
- *Acné Pápulo-pustuloso (Inflamatorio leve a moderado):* Pápulas eritematosas inflamatorias y pústulas superficiales.
- *Acné Nódulo-quístico o Severo:* Nódulos profundos, dolorosos, abscesos y fístulas con alto riesgo de **cicatrices atróficas ("en picahielo") o hipertróficas/queloideas**. **(ver Imagen 16.2A, B y C)**

2. ESCALAMIENTO TERAPÉUTICO TÓPICO Y ORAL

• **1. Acné Comedoniano Puro:** Fármaco de elección: **Retinoides tópicos** (**Adapaleno al 0.1%**, Tretinoína al 0.025-0.05%). 6.01.1.001 2.01.1.104 Normalizan la descamación del epitelio folicular y disuelven los comedones. Se aplican de noche. Pueden asociarse a **Peróxido de Benzoilo al 2.5-5%** (queratolítico y bactericida potente sin generar resistencia).

• **2. Acné Pápulo-pustuloso Leve a Moderado:** Combinación de **Peróxido de Benzoilo + Retinoide tópico ± Antibiótico tópico (Clindamicina 1%)**.

Regla de oro de examen: NUNCA prescribir antibióticos tópicos (clindamicina o eritromicina) en monoterapia, ya que inducen resistencia bacteriana en semanas. Deben asociarse siempre al peróxido de benzoilo.

• **3. Acné Moderado-Severo o Extenso (Cara + Tronco): Antibióticos orales: Tetraciclinas (Doxiciclina 100 mg/día o Minociclina 50-100 mg/día)** por 8 a 12 semanas, asociado a terapia tópica con peróxido de benzoilo. Efectos adversos: fotosensibilidad, esofagitis (tomar con vaso lleno de agua y no acostarse). Contraindicadas en embarazadas y niños < 8 años por tinción dental.

3. ISOTRETINOÍNA ORAL: INDICACIONES Y REGLAS VITALES

La isotretinoína (ácido 13-cis-retinoico) es el fármaco más eficaz: atrofia las glándulas sebáceas en un 90%, frena la queratinización, disminuye C. acnes y la inflamación. 6.01.1.001 2.01.1.104

• **Indicaciones formales de examen:**

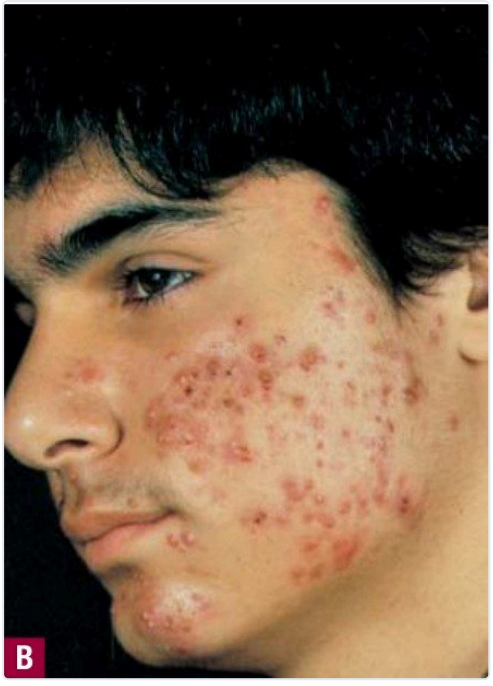
1. Acné nódulo-quístico o conglobata severo.
2. Acné con cicatrización activa o deformante.
3. Acné moderado refractario a tratamiento completo con antibióticos orales por 3 meses.
4. Gran impacto psicológico o dismorfofobia.

• **Reglas de Oro y Seguridad:**

- **TERATOGENICIDAD EXTREMA:** Malformaciones fetales mayores craneofaciales, cardíacas y del SNC. En mujeres en edad fértil exige **doble método anticonceptivo eficaz** iniciado 1 mes antes, durante todo el tratamiento y hasta 1 mes después de suspender el fármaco, con 2 test de embarazo negativos previos y mensuales.
- **Monitorización hepática y lipídica:** Perfil lipídico (triglicéridos/colesterol) y pruebas hepáticas (GOT/GPT) basales y de control.
- **Efecto adverso universal predecible: QUEILITIS DESCAMATIVA SEVERA Y SEQUEDAD MUCOCUTÁNEA (xerosis)**. Si el paciente no tiene labios partidos, no está tomando el fármaco.



A. COMEDONES



B. ACNÉ PÁPULO-PUSTULOSO



C. ACNÉ NÓDULO-QUÍSTICO

Imagen 16.2

FIGURA 16.2 · ALGORITMO ESCALONADO DE MANEJO DEL ACNÉ VULGAR

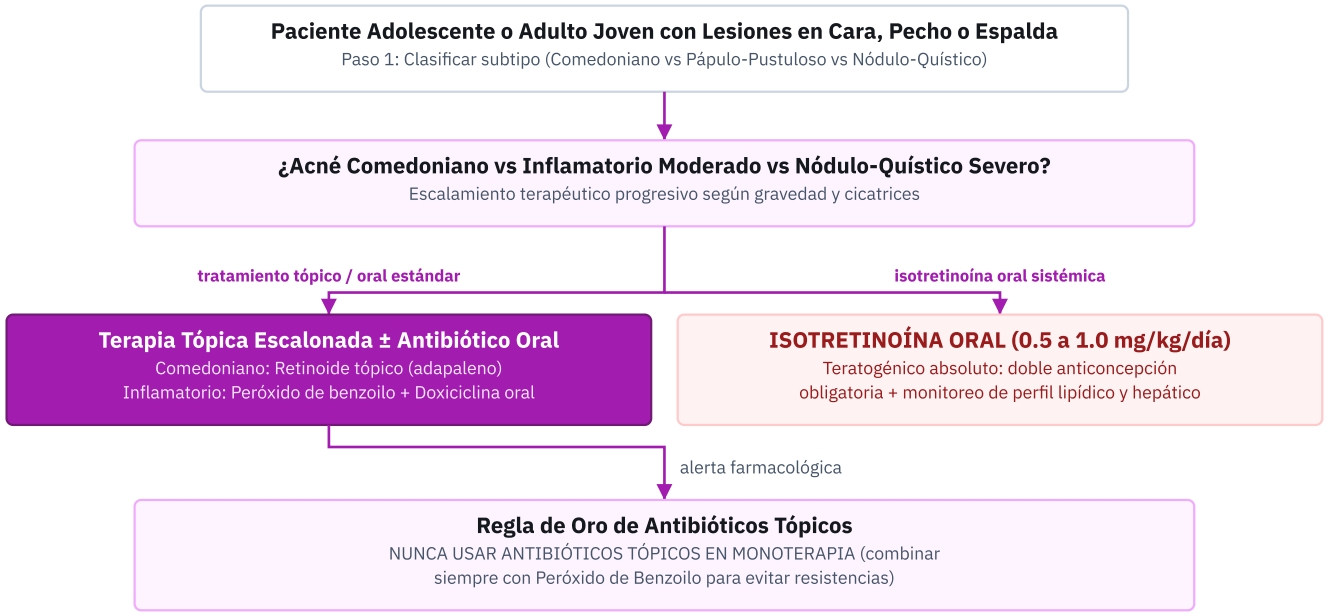


TABLA 16.2 · ALGORITMO ESCALONADO DE TRATAMIENTO DEL ACNÉ VULGAR `6.01.1.001, 2.01.1.104`

GRADO / SEVERIDAD	LESIONES PREDOMINANTES	TERAPIA DE PRIMERA LÍNEA	ALTERNATIVA / COADYUVANTE
Acné Comedoniano	Comedones abiertos y cerrados	Retinoide tópico (Adapaleno 0.1%) nocturno	Peróxido de benzoilo 2.5-5% / Ácido azelaico
Acné Pápulo-pustuloso Leve	Comedones + pápulas inflamatorias	Peróxido de benzoilo + Retinoide tópico	Asociar Clindamicina tópica 1% combinada
Acné Pápulo-pustuloso Moderado	Pápulas y pústulas numerosas en cara/espalda	Doxiciclina oral 100 mg/día + Peróxido de benzoilo	Minociclina oral / Terapia combinada tópica
Acné Severo / Nódulo-quístico	Nódulos profundos, quistes, cicatrices	ISOTRETINOÍNA ORAL (0.5 a 1.0 mg/kg/día)	Doble anticoncepción + monitoreo lipídico/hepático

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 16.2

Joven de 17 años consulta por lesiones faciales de 6 meses de evolución que le generan profunda angustia social. Al examen físico se aprecian abundantes comedones abiertos y cerrados en frente y mejillas, acompañados de escasas pápulas eritematosas no confluentes, sin nódulos, quistes ni cicatrices.

Conducta oficial. El paciente presenta un Acné Comedoniano predominante (no inflamatorio). La lesión etiopatogénica central es el comedón por hiperqueratinización infundibular. El tratamiento de primera línea de elección es un retinoide tópico, específicamente Adapaleno al 0.1% en gel aplicado por la noche, que puede combinarse con Peróxido de Benzoilo al 2.5% por la mañana. No están indicados los antibióticos orales ni la isotretinoína en este estadio.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- El comedón es la lesión elemental obligatoria que define al acné vulgar.
- Acné comedoniano = Retinoide tópico de elección (Adapaleno o Tretinoína).
- NUNCA usar antibióticos tópicos en monoterapia; asociar siempre a Peróxido de Benzoilo.
- Acné inflamatorio moderado-severo = Tetraciclinas orales (Doxiciclina 100 mg/día) por 8 a 12 semanas.
- La Isotretinoína oral se indica en acné nódulo-quístico severo, cicatrizante o refractario.
- La Isotretinoína es teratogénica absoluta: exige doble anticoncepción y control lipídico/hepático.
- El efecto secundario universal de la isotretinoína es la queilitis descamativa y sequedad mucocutánea.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 16.2

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.1.001

1. Un joven de 16 años presenta acné moderado con abundantes pápulas y pústulas en rostro y tercio superior del tórax. El médico decide iniciar tratamiento con un antibiótico tópico. ¿Cuál es el principio farmacológico obligatorio que debe respetarse para evitar la rápida aparición de cepas resistentes de Cutibacterium acnes?

A) Prescribir clindamicina tópica en monoterapia por al menos 6 meses continuos
B) Combinar siempre el antibiótico tópico con peróxido de benzoilo o un retinoide tópico, evitando la monoterapia
C) Alternar ciprofloxacino tópico y vancomicina en días sucesivos
D) Usar dosis ultrabajas de penicilina tópica en crema
E) Indicar corticoide tópico de alta potencia junto con el antibiótico

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.1.001

2. Una mujer de 22 años con acné nódulo-quístico severo y cicatrizal refractario a múltiples ciclos de doxiciclina oral es evaluada para inicio de isotretinoína oral. ¿Cuál de las siguientes condiciones es un REQUISITO OBLIGATORIO ABSOLUTO antes y durante la prescripción de este medicamento?

A) Demostrar niveles séricos indetectables de andrógenos suprarrenales
B) Doble método anticonceptivo eficaz, dos pruebas de embarazo negativas previas y monitorización mensual del perfil lipídico y pruebas hepáticas
C) Realizar biopsia cutánea previa de un nódulo activo
D) Indicar tratamiento concomitante con tetraciclinas orales a dosis altas
E) Dieta hipercalórica rica en grasas saturadas para favorecer la absorción

Más preguntas online de Acné Vulgar →

16.3. Rosácea: Subtipos Clínicos y Manejo Médico

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 6.01.1.026

¿POR QUÉ?

La rosácea es una dermatosis inflamatoria crónica común del área centrofacial que afecta preferentemente a mujeres adultas de piel clara. En el examen, la perla semiológica cardinal e indiscutible es que la rosácea NUNCA TIENE COMEDONES. El uso de corticoides tópicos es un error médico gravísimo que desencadena una rosácea esteroidal de difícil control.

1. FACTORES DESENCADENANTES Y DIFERENCIACIÓN CON ACNÉ

La rosácea combina disregulación vascular (hiperreactividad endotelial), alteración de la inmunidad innata (aumento de catelicidina LL-37) y colonización por el ácaro *Demodex folliculorum*. 6.01.1.026

• **Desencadenantes cardinales de crisis ("Flushing" o bochornos faciales):** Exposición solar (radiación UV), calor ambiental, ingesta de alcohol, comidas picantes/condimentadas, bebidas calientes, cambios bruscos de temperatura y estrés emocional.

• **REGLA DE ORO DE EXAMEN: LA ROSÁCEA NO TIENE COMEDONES**. La presencia de comedones abiertos o cerrados certifica el diagnóstico de Acné y excluye Rosácea. **(ver Imagen 16.3A)**

2. LOS CUATRO SUBTIPOS CLÍNICOS CLÁSICOS

1. **Subtipo 1: Eritematotelangiectásica:** Eritema persistente centrofacial (mejillas, nariz, frente y mentón) con episodios de flushing y **telangiectasias finas visibles**. Sensación de ardor o quemazón. 6.01.1.026
2. **Subtipo 2: Pápulo-pustulosa:** Pápulas eritematosas inflamatorias y pequeñas pústulas sobre una base de eritema centrofacial persistente, **sin comedones**. Típica en mujeres de 30 a 50 años.
3. **Subtipo 3: Fimatosa:** Engrosamiento cutáneo con hipertrofia de glándulas sebáceas y fibrosis, produciendo nódulos dérmicos lobulados. Típica en varones en la nariz: **RINOFIMA** (nariz globulosa, bulbosa y deformada).
4. **Subtipo 4: Ocular (hasta en 50% de los pacientes):** Blefaritis, inyección conjuntival, sensación de arenilla/cuerpo extraño, chalazión recurrente y telangiectasias en el borde palpebral. **(ver Imagen 16.3C)**

3. MANEJO MÉDICO ESCALONADO Y LA "ROSÁCEA ESTEROIDEA"

• **Medidas Generales Mandatorias: Fotoprotección solar FPS 50+ diaria** de amplio espectro, emolientes suaves, evitar desencadenantes (alcohol, picantes, calor). 6.01.1.026

• **Tratamiento Médico por Subtipo:**

- *Flushing y eritema vascular:* Brimonidina tópica (agonista alfa-2 que produce vasoconstricción temporal) o láser vascular/IPL.
- *Pápulo-pustulosa leve:* **Metronidazol tópico al 0.75% o 1%** en gel/crema, o **Ivermectina tópica al 1%** (antiparasitario frente a *Demodex* y antiinflamatorio), o Ácido azelaico 15%.
- *Pápulo-pustulosa moderada-severa o refractaria:* **Doxiciclina oral a dosis antiinflamatoria (40 a 100 mg/día por 8 a 12 semanas)**.
- *Rinofima avanzado:* No responde a fármacos; requiere resección quirúrgica con bisturí, electrocirugía o láser ablativo de CO_2.

• **TRAMPA GRAVE DE EXAMEN: CONTRAINDICACIÓN DE CORTICOIDES TÓPICOS**. Los corticoides tópicos producen vasoconstricción inicial que blanquea falsamente la piel, pero al retirarlos desencadenan un efecto rebote severo ("rosácea esteroidal" o dermatitis perioral) con telangiectasias monstruosas, atrofia cutánea y brote pustuloso masivo. **(ver Imagen 16.3B)**



A. ROSÁCEA



B. ROSÁCEA PÁPULO-PUSTULOSA



C. RINOFIMA

Imagen 16.3

FIGURA 16.3 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA ROSÁCEA

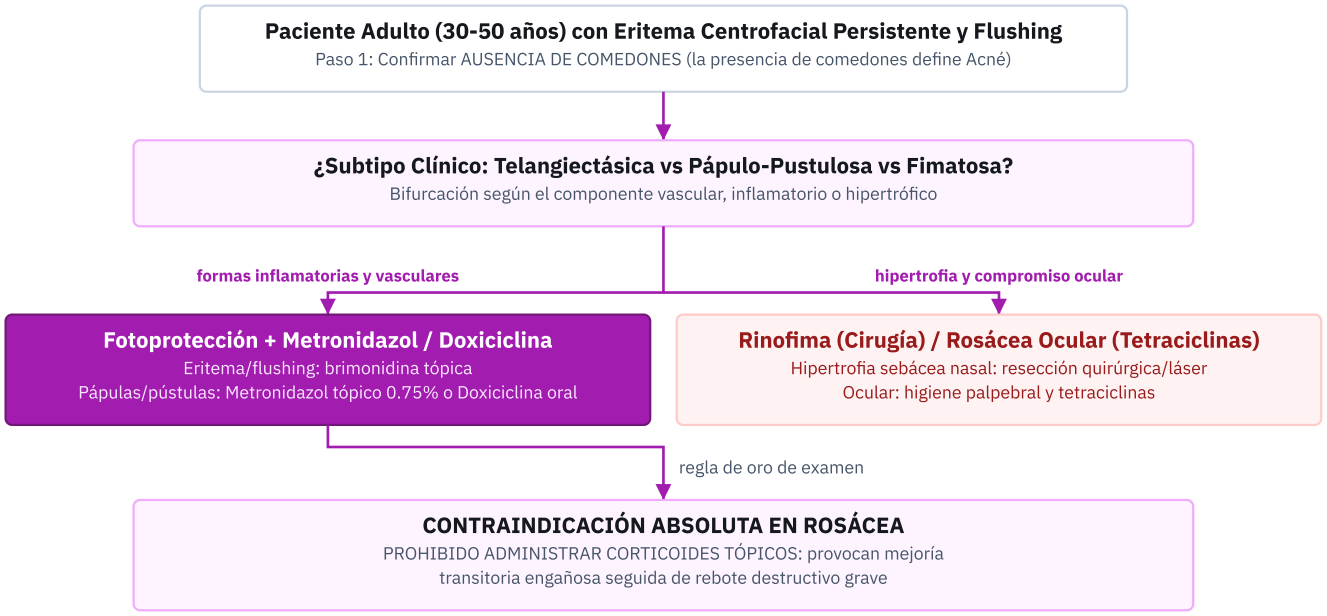


TABLA 16.3 · SUBTIPOS CLÍNICOS DE ROSÁCEA Y TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA 6.01.1.026

SUBTIPO	HALLAZGO CLÍNICO PREDOMINANTE	TRATAMIENTO TÓPICO	TRATAMIENTO ORAL / PROCEDIMIENTO
1. Eritematotelangiectásica	Eritema centrofacial fijo + flushing + telangiectasias	Brimonidina tópica / Fotoprotector 50+	Láser vascular / Luz Pulsada Intensa (IPL)
2. Pápulo-pustulosa	Pápulas y pústulas centrofaciales SIN comedones	Metronidazol 0.75% / Ivermectina 1% tópica	Doxiciclina oral 100 mg/día (8 a 12 semanas)
3. Fimatosa (Rinofima)	Engrosamiento nasal bulboso, poros dilatados	Ineficaz en estadios fibrosos avanzados	Resección quirúrgica / Láser CO_2 ablativo
4. Ocular	Blefaritis, ardor, ojo seco, chalazión recurrente	Higiene de párpados + lágrimas artificiales	Doxiciclina oral a dosis bajas por 6 semanas

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 16.3

Mujer de 38 años de tez clara consulta por enrojecimiento persistente en mejillas y nariz de 1 año de evolución que empeora notoriamente al tomar café caliente, beber vino tinto o salir al sol. En el último mes han aparecido múltiples lesiones solevantadas en las mejillas. Al examen físico se aprecian telangiectasias centrofaciales, pápulas eritematosas y pústulas milimétricas en mejillas y dorso nasal. No se identifican comedones en ninguna zona del rostro.

Conducta oficial. La presencia de eritema centrofacial persistente exacerbado por desencadenantes térmicos y dietéticos (calor, alcohol), con telangiectasias y lesiones pápulo-pustulosas, en ausencia estricta de comedones, establece el diagnóstico definitivo de Rosácea Pápulo-pustulosa (Subtipo 2). La conducta terapéutica de primera línea en atención primaria consiste en fotoprotección solar estricta, evitar desencadenantes y prescribir tratamiento tópico con Metronidazol al 0.75% en gel o Ivermectina tópica al 1% (o Doxiciclina oral si el cuadro es moderado a severo). Los corticoides tópicos están formalmente contraindicados.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- La rosácea NUNCA TIENE COMEDONES (la presencia de comedones define acné).
- Desencadenantes clásicos: sol, calor, alcohol, comidas picantes y estrés.
- Subtipo 1 = eritema y telangiectasias; Subtipo 2 = pápulas y pústulas; Subtipo 3 = Rinofima.
- El tratamiento tópico de primera línea en la rosácea pápulo-pustulosa es Metronidazol o Ivermectina.
- Si es moderada-severa, se indica Doxiciclina oral a dosis antiinflamatorias.
- PROHIBICIÓN ABSOLUTA: JAMÁS usar corticoides tópicos en rosácea (inducen rosácea esteroidal severa).

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 16.3

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.1.026

1. Una mujer de 44 años consulta por un cuadro de 8 meses de evolución caracterizado por enrojecimiento de mejillas y nariz que empeora al ingerir alimentos calientes o tras exponerse al sol. Al examen físico se constatan telangiectasias centrofaciales y múltiples pápulas y pústulas inflamatorias dispersas sobre ambas mejillas. No se observan comedones abiertos ni cerrados. ¿Cuál es el tratamiento tópico de primera línea más adecuado?

A) Clobetasol crema al 0.05% cada 12 horas
B) Metronidazol en gel al 0.75% o ivermectina tópica al 1%
C) Adapaleno gel al 0.1% en monoterapia
D) Mupirocina ungüento al 2%
E) Ácido salicílico al 10% en solución alcohólica

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.1.026

2. ¿Cuál de los siguientes hallazgos al examen físico cutáneo permite DESCARTAR con mayor certeza el diagnóstico de rosácea y orientar definitivamente hacia acné vulgar?

A) Presencia de eritema en la región malar
B) Presencia de comedones abiertos ("puntos negros") o cerrados
C) Presencia de pústulas foliculares confluentes
D) Presencia de telangiectasias centrofaciales
E) Empeoramiento de las lesiones con la ingesta de alcohol

Más preguntas online de Rosácea →

16.4. Alopecias: Androgenética, Areata y Efluvio Telógeno

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 6.01.1.002

¿POR QUÉ?

La alopecia es un motivo de gran preocupación para los pacientes. La primera tarea del médico es verificar si la piel del cuero cabelludo conserva los orificios foliculares (alopecia no cicatricial, potencialmente recuperable) o si hay atrofia y fibrosis (alopecia cicatricial irreversible). Entre las no cicatriciales, la androgenética, la areata y el efluvio telógeno dominan la práctica.

1. CICATRICIALES VS NO CICATRICIALES: LA GRAN DIVISIÓN

• **Alopecias Cicatriciales (Destructivas e Irreversibles):** 6.01.1.002 Existe un proceso inflamatorio destructivo que arrasa el folículo piloso y sus células madre de la protuberancia, reemplazándolo por tejido fibroso cicatrizal. Al examen: **piel lisa, brillante, atrófica, con DESAPARICIÓN TOTAL DE LOS ORIFICIOS FOLICULARES**. El pelo perdido nunca vuelve a crecer. Causas: **Lupus eritematoso discoide**, Liquen plano pilar, foliculitis decalvante. Requieren biopsia y tratamiento inmunosupresor precoz.

• **Alopecias No Cicatriciales (Potencialmente Reversibles):** El folículo piloso permanece vivo e íntegro dentro de la dermis; **los orificios foliculares están CONSERVADOS**. El pelo puede volver a crecer si se elimina el factor causal.

2. ALOPECIA ANDROGENÉTICA (CALVICIE COMÚN)

Es la causa más prevalente en ambos sexos. Se debe a una predisposición genética poligénica combinada con la acción de los andrógenos, específicamente la **Dihidrotestosterona (DHT)**, sintetizada por la enzima **5-alfa reductasa tipo 2**. 6.01.1.002

• La DHT acorta la fase de anágeno y produce la **miniaturización progresiva de los folículos**, transformando pelos terminales gruesos en vellos finos y despigmentados.

• **Patrón masculino (escala de Hamilton-Norwood):** Retroceso de la línea de implantación frontotemporal ("entradas") y pérdida en la coronilla (vértice).

• **Patrón femenino (escala de Ludwig):** Pérdida difusa de densidad en el vértex con ensanchamiento de la raya central ("signo del árbol de navidad"), **respetando la línea de implantación frontal anterior**.

• **Tratamiento Médico de Primera Línea:**

- **Minoxidil tópico al 2% o 5%** (solución o espuma): Vasodilatador que estimula la fase de anágeno y aumenta el calibre folicular.

- **Finasteride oral 1 mg/día** (o Dutasteride): Inhibidor de la 5-alfa reductasa que reduce los niveles de DHT en un 70%. Frena la caída y recupera cabello en más del 80% de los varones. **CONTRAINDICACIÓN:** Mujeres en edad fértil por riesgo de feminización de fetos masculinos (teratogenicidad). **(ver Imagen 16.4A)**

3. ALOPECIA AREATA Y EFLUVIO TELÓGENO

• **Alopecia Areata:** Enfermedad autoinmune mediada por linfocitos T CD8+ que atacan los folículos en fase de anágeno. 6.01.1.002

- *Clínica patognomónica:* Una o múltiples **placas alopécicas redondeadas u ovales, lisas, de piel completamente normal sin descamación ni eritema**.

- *Signo patognomónico:* **PELOS EN SIGNO DE EXCLAMACIÓN ("pelos caducos")** en el borde activo de la placa (pelos cortos fracturados más delgados en su base).

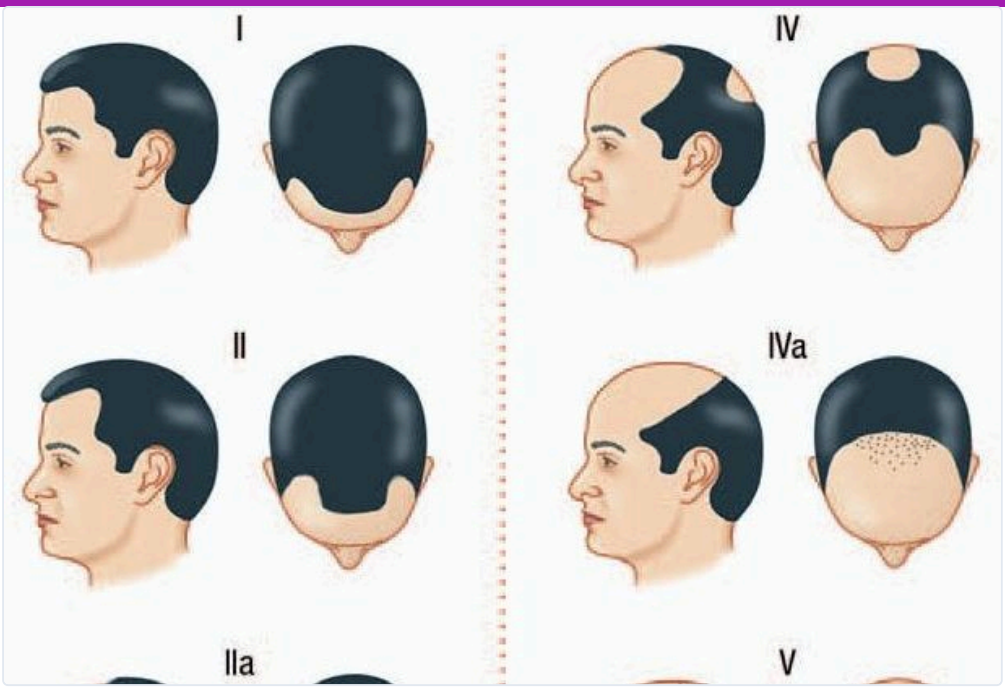
- Formas severas: Alopecia total (pérdida de todo el cabello del cuero cabelludo) y Alopecia universal (pérdida de todo el vello corporal: cejas, pestañas, axilar y púbico). Frecuentemente asociada a tiroiditis autoinmune o vitíligo.

- *Tratamiento:* **Corticoides intralesionales (acetónido de triamcinolona)** infiltrados en la placa, corticoides tópicos de alta potencia o inhibidores de JAK sistémicos (baricitinib).

• **Efluvio Telógeno Agudo:** Paso prematuro y sincrónico de gran cantidad de folículos anágenos a la fase de telógeno (fase de caída).

- *Gatillante:* Aparece **2 a 3 meses después de un estresor fisiológico intenso** (parto puerperal, cirugía mayor, sepsis, infección febril grave como COVID-19, pérdida de peso brusca o déficit férrico severo).

- *Clínica:* **Caída masiva y difusa de cabello al peinarse o lavarse**, con prueba de tracción ("pull test") fuertemente positiva en todo el cuero cabelludo. Es completamente benigno y autolimitado; se resuelve espontáneamente en 6 meses al cesar la causa. **(ver Imagen 16.4B y C)**



A. ESCALA DE HAMILTON-NORWOOD (GRADOS I A V)



B. ALOPECIA AREATA



C. PLACA SIN PELO

Imagen 16.4

FIGURA 16.4 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y DIFERENCIAL DE LAS ALOPECIAS EN APS

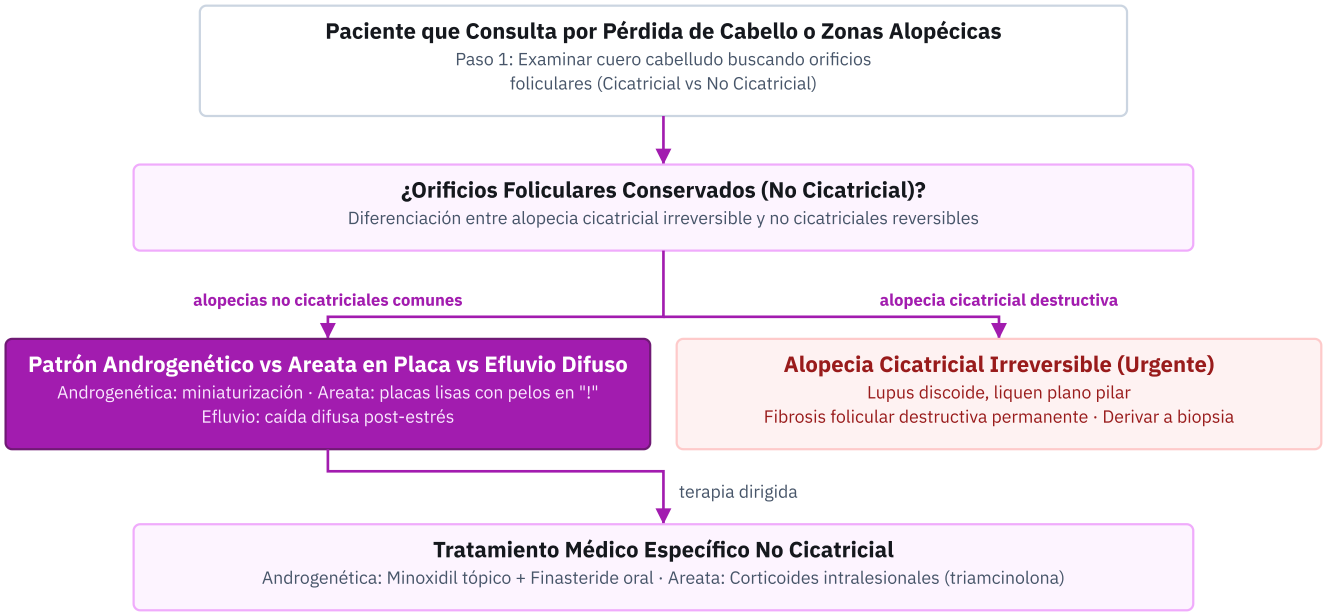


TABLA 16.4 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: ALOPECIA ANDROGENÉTICA VS AREATA VS EFLUVIO TELÓGENO 6.01.1.002

CARACTERÍSTICA	ALOPECIA ANDROGENÉTICA	ALOPECIA AREATA	EFLUVIO TELÓGENO
Mecanismo fisiopatológico	Miniaturización folicular por Dihidrotestosterona	Ataque autoinmune mediado por linfocitos T	Paso sincrónico a telógeno tras estrés agudo
Patrón de distribución	Entradas frontotemporales y coronilla (Ludwig fem)	Placas alopécicas redondeadas bien delimitadas	Caída DIFUSA de todo el cuero cabelludo
Aspecto de la piel	Normal, con orificios foliculares y vellos finos	Piel completamente lisa, limpia, sin escama	Normal, sin placas circunscritas
Signo semiológico clave	Miniaturización progresiva en dermoscopía	PELOS EN SIGNO DE EXCLAMACIÓN en el borde	Pull test positivo difuso (> 10 pelos con bulbo)
Asociación sistémica	Síndrome metabólico, herencia poligénica	Tiroiditis de Hashimoto, vitíligo, atopia	Parto, cirugía, fiebre alta 2-3 meses antes
Tratamiento de elección	Minoxidil tópico 5% + Finasteride oral 1 mg	Corticoides intralesionales (Triamcinolona)	Tranquilizar al paciente; resolución espontánea

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 16.4

Hombre de 28 años consulta muy alarmado porque hace 2 semanas descubrió mientras se peinaba una zona sin pelo en la región parietal derecha. Al examen físico se aprecia una placa alopécica circular única de 4 cm de diámetro, con piel completamente lisa, sin eritema, descamación ni cicatrización. Al traccionar suavemente en los bordes de la lesión se desprenden varios pelos cortos adelgazados en su extremo proximal que adoptan forma de signo de exclamación.

Conducta oficial. La presencia de una placa alopécica redondeada solitaria de piel lisa sin signos inflamatorios ni descamación, con pelos caducos en "signo de exclamación" en la periferia activa, es diagnóstica de Alopecia Areata. Es una enfermedad autoinmune con indemnidad del folículo piloso (no cicatricial). La conducta terapéutica de primera línea en atención primaria para placas localizadas es la infiltración intralesional de corticoides (acetónido de triamcinolona) o la aplicación de corticoides tópicos de muy alta potencia (clobetasol), junto con tamizaje de tiroiditis autoinmune asociada.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Alopecia no cicatricial = orificios foliculares conservados (potencialmente reversible).
- Alopecia cicatricial = piel lisa y brillante sin orificios foliculares (irreversible de por vida).
- Alopecia androgenética = miniaturización mediada por dihidrotestosterona; responde a Finasteride y Minoxidil.
- El Finasteride está contraindicado en mujeres en edad fértil por teratogenicidad (feminización fetal).
- Alopecia areata = placas alopécicas redondas con pelos en "signo de exclamación"; responde a corticoides intralesionales.
- Efluvio telógeno = caída difusa 2 a 3 meses post-estrés (parto, fiebre alta, cirugía); se resuelve solo.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 16.4

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.1.002

1. Un hombre de 24 años consulta por caída progresiva de cabello en las regiones temporales y en la coronilla desde hace 2 años, con patrón idéntico al de su padre. Al examen se constata retroceso de la línea de implantación frontotemporal y adelgazamiento marcado del cabello en el vértex, observándose pelos muy finos y cortos junto a los orificios foliculares conservados. ¿Cuál es el fármaco oral de elección para frenar la progresión y su mecanismo de acción?

A) Prednisona oral; inmunosupresión de linfocitos T periféricos
B) Finasteride oral; inhibición de la enzima 5-alfa reductasa tipo 2 disminuyendo la síntesis de dihidrotestosterona
C) Ketoconazol oral; inhibición de la síntesis de ergosterol
D) Espironolactona oral en dosis altas
E) Metotrexato oral semanal

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.1.002

2. Una mujer de 30 años consulta muy angustiada porque desde hace 3 semanas se le cae el cabello en forma masiva cada vez que se peina o ducha, encontrando puñados de pelos en la almohada. Refiere que hace 3 meses dio a luz a su primer hijo por cesárea sin incidentes. Al examen físico no se aprecian placas alopécicas circunscritas; el cuero cabelludo es normal y la prueba de tracción ("pull test") es positiva difusa en toda la cabeza, desprendiéndose pelos con bulbo telógeno intacto. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta médica indicada?

A) Alopecia areata universal incipiente; hospitalizar para pulsos de metilprednisolona
B) Efluvio telógeno agudo puerperal; tranquilizar a la paciente y explicar que el cuadro es transitorio y se recuperará espontáneamente
C) Tiña del cuero cabelludo (Tinea capitis); indicar griseofulvina oral
D) Lupus discoide cutáneo; indicar biopsia en sacabocados urgente
E) Alopecia androgenética femenina severa; indicar finasteride oral inmediato

Más preguntas online de Alopecias →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 1.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 16.1 A 16.4

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Lesiones Elementales Primarias y Secundarias de la Piel	Mácula 1 cm plana (ambas sin relieve detectable a la palpación).	**Pápula 1 cm sólida en meseta (confluye de pápulas).**	—
Acné Vulgar: Escalonamiento Tópico, Oral e Indicaciones de Isotretinoína	El comedón es la lesión elemental obligatoria que define al acné vulgar.	**Acné comedoniano = Retinoide tópico de elección (Adapaleno o Tretinoína).**	NUNCA usar antibióticos tópicos en monoterapia; asociar siempre a Peróxido de Benzoilo.
Rosácea: Subtipos Clínicos y Manejo Médico	La rosácea NUNCA TIENE COMEDONES (la presencia de comedones define acné).	**Desencadenantes clásicos: sol, calor, alcohol, comidas picantes y estrés.**	PROHIBICIÓN ABSOLUTA: JAMÁS usar corticoides tópicos en rosácea (inducen rosácea...
Alopecias: Androgenética, Areata y Efluvio Telógeno	Alopecia no cicatricial = orificios foliculares conservados (potencialmente reversible).	**Alopecia cicatricial = piel lisa y brillante sin orificios foliculares (irreversible de...**	El Finasteride está contraindicado en mujeres en edad fértil por teratogenicidad...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

Mácula 1 cm plana (ambas sin relieve detectable a la palpación).

Pápula 1 cm sólida en meseta (confluye de pápulas).

Nódulo = lesión sólida profunda hipodérmica que se palpa más de lo que se ve.

Habón o roncha = placa edematosa evanescente que dura menos de 24 horas.

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- Pápula < 1 cm sólida; Placa > 1 cm sólida en meseta (confluye de pápulas).
- Nódulo = lesión sólida profunda hipodérmica que se palpa más de lo que se ve.
- Acné comedoniano = Retinoide tópico de elección (Adapaleno o Tretinoína).
- NUNCA usar antibióticos tópicos en monoterapia; asociar siempre a Peróxido de Benzoilo.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

Mácula 1 cm plana (ambas sin relieve detectable a la palpación).	Tema 16.1 →
El comedón es la lesión elemental obligatoria que define al acné vulgar.	Tema 16.2 →
La rosácea NUNCA TIENE COMEDONES (la presencia de comedones define acné).	Tema 16.3 →
Alopecia no cicatricial = orificios foliculares conservados (potencialmente reversible).	Tema 16.4 →

MANUAL EUNACOM DE DERMATOLOGÍA

BLOQUE 02 DE 04 · PERFIL DE CONOCIMIENTOS V3 ASOFAMECH

perfil v3 asofamech
16 CÓDIGOS OFICIALES

02

BLOQUE TEMÁTICO
4 clases

DERMATOSIS INFLAMATORIAS, PSORIASIS & ECCEMAS

4	14	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE — PÁGINA

16.5 Psoriasis Vulgar: Fenómeno de Koebner, Auspitz y Terapias Tópicas/Sistémicas 25

16.6 Dermatitis Atópica: Hanifin y Rajka, Corticoides Tópicos e Hidratación 30

16.7 Dermatitis Seborreica vs Dermatitis de Contacto (Alérgica vs Irritativa) 34

16.8 Urticaria Aguda y Crónica: Habones Evanescentes, Angioedema y Antihistamínicos 38

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM — 16 CÓDIGOS

Este bloque cubre **16 códigos oficiales** (16 situaciones). La tabla completa, con el nivel exigido de cada uno, está en la página siguiente.

BLOQUE 02 · DERMATOSIS INFLAMATORIAS, PSORIASIS & ECCEMAS

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3

perfil v3 asofamech
16 CÓDIGOS OFICIALES

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

16 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
6.01.1.024	Psoriasis Tema 16.5	Específico	Inicial	Completo
1.11.1.001	Artritis psoriática Tema 16.5	Sospecha	Inicial	Derivar
6.01.1.015	Líquen plano Tema 16.5	Sospecha	Inicial	Derivar
6.01.2.004	Eritrodermia Tema 16.5	Sospecha	Inicial	Derivar
6.01.1.004	Dermatitis atópica Tema 16.6	Específico	Completo	Derivar
2.01.1.107	Dermatitis atópica Tema 16.6	Específico	Completo	Completo
6.01.1.006	Dermatitis seborreica infantil y del adulto Tema 16.7	Específico	Completo	Completo
6.01.1.007	Dermitis de contacto Tema 16.7	Específico	Completo	Completo
6.01.4.005	Patch test Tema 16.7	Interpreta y emplea		
6.01.1.005	Dermatitis del pañal Tema 16.7	Específico	Completo	Completo
6.01.1.011	Fotodermatosis Tema 16.7	Sospecha	Inicial	Completo
2.01.1.108	Dermatitis del pañal y de contacto Tema 16.7	Específico	Completo	Completo
6.01.1.030	Urticaria aguda Tema 16.8	Específico	Completo	Completo
6.01.2.001	Angioedema de Quinque Tema 16.8	Sospecha	Inicial	Derivar
2.01.1.055	Alergias Tema 16.8	Específico	Completo	Completo
6.01.2.016	Urticaria y angioedema Tema 16.8	Específico	Completo	Completo

BLOQUE 02 · DERMATOSIS INFLAMATORIAS, PSORIASIS & ECCEMAS

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
14 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- El raspado metódico de Brocq culmina en el Signo de Auspitz (rocío sangrante patognomónico).
- El fenómeno de Koebner es la aparición de lesiones psoriásicas típicas sobre piel sana traumatizada.
- La psoriasis en placas típica se ubica en superficies de extensión: codos, rodillas y región lumbosacra.
- La psoriasis en gotas ocurre en jóvenes tras una faringoamigdalitis estreptocócica.
- El tratamiento tópico de elección es la combinación fija de Corticoide potente + Calcipotriol.
- La psoriasis moderada-grave ingresa a garantías GES N° 84 (fototerapia, metotrexato y biológicos).

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

4 DE 4 TEMAS

Psoriasis Vulgar: Fenómeno de Koebner, Auspitz y Terapias Tópicas/Sistémicas	EUNACOM Julio 2025 · #120 · EUNACOM Diciembre 2025 · #111 · EUNACOM Diciembre 2019 · #129 · EUNACOM Diciembre 2018 · #29
Dermatitis Atópica: Hanifin y Rajka, Corticoides Tópicos e Hidratación	EUNACOM Diciembre 2025 · #79 · EUNACOM Julio 2016 · #12
Dermatitis Seborreica vs Dermatitis de Contacto	EUNACOM Diciembre 2025 · #106 · EUNACOM Diciembre 2024 · #65 · EUNACOM Enero 2023 · #118 · EUNACOM Diciembre 2022 · #143
Urticaria Aguda y Crónica: Habones Evanescentes, Angioedema y Antihistamínicos	EUNACOM Julio 2025 · #20 · EUNACOM Julio 2025 · #91 · EUNACOM Diciembre 2024 · #84 · EUNACOM Enero 2023 · #178

16.5. Psoriasis Vulgar: Fenómeno de Koebner, Auspitz y Terapias Tópicas/Sistémicas

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 6.01.1.024 | 1.11.1.001 | 6.01.1.015 | 6.01.2.004

¿POR QUÉ?

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria sistémica inmunomediada crónica caracterizada por hiperproliferación epidérmica acelerada. En el examen se evalúan tres áreas esenciales: la semiología del raspado metódico de Brocq con el signo de Auspitz, el fenómeno de Koebner, y la prohibición estricta de prescribir corticoides sistémicos.

1. FISIOPATOLOGÍA INMUNE Y RECAMBIO CELULAR

Es una afección poligénica con fuerte asociación al antígeno **HLA-Cw6**. El eje patogénico central involucra la activación de linfocitos T colaboradores (Th1 y Th17) estimulados por **IL-23** que producen **IL-17, IL-22 y TNF-alfa**. 6.01.1.024

• Esta cascada citoquínica provoca una hiperplasia epidérmica masiva con **aceleración del recambio celular de queratinocitos de 28 días a solo 3 a 4 días**.

• Como las células ascienden demasiado rápido, conservan sus núcleos en el estrato córneo (**paraqueratosis**) y no logran sintetizar queratohialina (agranulosis), formando las típicas escamas gruesas plateadas.

2. SEMIOLOGÍA CLÁSICA: RASPADO DE BROCQ, KOEBNER Y COMPROMISO UNGUEAL

• **Placa Típica:** Placa eritematosa viva, bien delimitada, cubierta por gruesas escamas blanco-nacaradas o plateadas no grasosas. Localización clásica bilateral y simétrica en **superficies de extensión: codos, rodillas, región lumbosacra y cuero cabelludo**. 6.01.1.024

• **Raspado Metódico de Brocq (curetaje con cucharilla):**

1. *Signo de la bujía o mancha de cera:* Al raspar la placa se desprenden virutas blanquecinas semejantes a raspar una vela de cera.
2. *Signo de la película despegable (membrana de Duncan-Dulck):* Se desprende una fina película epidérmica transparente continua.
3. **SIGNO DE AUSPITZ O DEL ROCÍO SANGRANTE (PATOGNOMÓNICO):** Al retirar la membrana transparente, quedan al descubierto las papilas dérmicas elongadas con capilares dilatados, produciéndose un punteado hemorrágico fino en gotitas diminutas.

• **Fenómeno Isomórfico de Koebner:** Aparición de lesiones psoriásicas típicas sobre áreas de piel sana que han sufrido un traumatismo mecánico, herida quirúrgica, roce o rascado (típico también en vitíligo y liquen plano).

• **Compromiso Ungueal (Psoriasis ungueal en 50%): Pitting o piqueteado ungueal en dedal** (pequeñas depresiones cupuliformes), mancha en "gota de aceite" (decoloración amarronada subungueal), hiperqueratosis subungueal y onicolisis distolateral. **(ver Imagen 16.5A, B y C)**



Líquen plano oral erosivo

TABLA 16.5.A · FORMAS CLÍNICAS DE PSORIASIS Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 6.01.1.024, 1.11.1.001, 6.01.1.015, 6.01.2.004

FORMA CLÍNICA	LOCALIZACIÓN / LESIÓN ELEMENTAL	DESENCADENANTE TÍPICO	CONDUCTA TERAPÉUTICA
En Placas (Vulgar, 85%)	Placas eritematosas con escamas nacaradas en codos/rodillas	Trauma local (Koebner), estrés, tabaco	Tópicos (Clobetasol + Calcipotriol) / MTX
En Gotas (Guttata)	Pápulas descamativas en gotas en tronco de niños/jóvenes	Infección estreptocócica faríngea previa	Amoxicilina/Penicilina + Fototerapia UVB
Invertida	Placas rojas lisas SIN escamas en axilas/ingles	Fricción y maceración en pliegues	Inhibidores de calcineurina / corticoides suaves
Pustulosa Generalizada	Pústulas estériles confluentes + fiebre alta	SUSPENSIÓN DE CORTICOIDES ORALES	Hospitalización urgente + Acitretina / Infliximab
Artropatía Psoriásica	Dactilitis ("dedo en salchicha") + artritis IFD	Antígeno HLA-B27, factor reumatoide (-)	Metotrexato o Biológicos anti-TNF / anti-IL17

16.5. Psoriasis Vulgar: Fenómeno de Koebner, Auspitz y Terapias Tópicas/Sistémicas — Enfrentamiento Diagnóstico

3. FORMAS CLÍNICAS ESPECIALES Y ARTRITIS PSORIÁSICA

• **Psoriasis en Gotas o Guttata:** Erupción brusca de pápulas milimétricas descamativas generalizadas ("en gotas de lluvia") en niños o adultos jóvenes, **desencadenada 1 a 2 semanas después de una faringoamigdalitis estreptocócica**. Responde a antibióticos y fototerapia; excelente pronóstico. 6.01.1.024 1.11.1.001 6.01.2.004

• **Psoriasis Invertida:** Afecta los grandes pliegues (axilas, ingles, submamario, interglúteo). Por la maceración y sudor, **las placas carecen de escamas** y se ven rojas brillantes y húmedas (confundible con intertrigo candidiásico).

• **Eritrodermia Psoriásica y Psoriasis Pustulosa Generalizada (von Zumbusch):** Formas graves potencialmente letales con compromiso hemodinámico, hipotermia y sepsis.

• **Artritis Psoriásica (10% a 30% de los pacientes):** Asociada a HLA-B27, seronegativa (Factor Reumatoide negativo). Afecta articulaciones interfalángicas distales (IFD), cursa con **dactilitis ("dedo en salchicha")** y entesitis.



Psoriasis pustulosa generalizada



Dactilitis («dedos en salchicha») y distrofia ungueal en las manos de un paciente con artritis psoriásica



A. PLACAS PSORIÁSICAS



B. KOEBNER SOBRE CICATRIZ



C. PITTING UNGUEAL

Imagen 16.5

FIGURA 16.5 · ALGORITMO DE MANEJO Y ESCALAMIENTO DE PSORIASIS VULGAR

Paciente con Placas Eritematodescamativas Nacaradas en Codos, Rodillas o Cuero Cabelludo
Paso 1: Evaluar Signo de Auspitz (rocío sangrante), Koebner y Porcentaje de Superficie Corporal (BSA)

¿Psoriasis Leve (< 5-10% BSA) vs Moderada-Grave (> 10% BSA / Artritis / PASI > 10)?
Estratificación de gravedad clínica para definir terapia tópica vs sistémica/biológica

manejo ambulatorio tópico

fármacos sistémicos ges

Terapia Tópica Combinada de Primera Línea
Corticoide tópico de alta potencia (Clobetasol 0.05%) + Análogo de Vitamina D (Calcipotriol)

Terapia Sistémica y Biológicos (GES N° 84)
Fototerapia UVB de banda estrecha · Metotrexato oral
Terapia Biológica anti-IL17/IL23/TNF

trampa mortal de examen

CONTRAINDICACIÓN FATAL ABSOLUTA EN PSORIASIS
NUNCA ADMINISTRAR CORTICOIDES ORALES O PARENTERALES: al suspenderlos provocan rebote a Psoriasis Pustulosa Generalizada o Eritrodermia letal

TABLA 16.5.B · ESTRATIFICACIÓN DE SEVERIDAD Y CRITERIOS DE INGRESO A GES N° 84 — CRITERIOS DE GRAVEDAD

ESTRATO DE GRAVEDAD	CRITERIOS CUANTITATIVOS (BSA / PASI / DLQI)	IMPACTO EN CALIDAD DE VIDA	LÍNEA TERAPÉUTICA INDICADA
Psoriasis Leve	BSA < 10%, PASI < 10 y DLQI ≤ 10	Bajo a moderado; localizada en codos/rodillas	Tratamiento tópico exclusivo
Psoriasis Moderada a Grave	BSA ≥ 10% O PASI ≥ 10 O DLQI > 10	Severo; afectación extensa de tronco y extremidades	Fototerapia UVB / Metotrexato oral (GES)
Psoriasis en Sitios Especiales	Palmas, plantas, cara, genitales o cuero cabelludo severo	Gran discapacidad funcional/laboral aun con BSA baja	Terapia sistémica precoz
Psoriasis Refractaria	Falla a Metotrexato y Fototerapia en dosis plenas	Persistencia de PASI > 50% de la basal	Terapia Biológica anti-IL17/IL23/TNF (GES)

16.5. Psoriasis Vulgar: Fenómeno de Koebner, Auspitz y Terapias Tópicas/Sistémicas — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. ESCALONAMIENTO TERAPÉUTICO Y GARANTÍA GES N° 84

• **Psoriasis Leve (< 5% a 10% de superficie corporal, PASI < 10):** 6.01.1.024

Tratamiento de elección: **Terapia tópica combinada fija de Corticoide de alta potencia (Dipropionato de Betametasona o Clobetasol) + Análogo de Vitamina D (Calcipotriol)** en ungüento/espuma. El calcipotriol frena la proliferación y el corticoide frena la inflamación con sinergia y menor atrofia.

• **Psoriasis Moderada a Grave (> 10% superficie o compromiso ungueal/articular extenso):**

- **Fototerapia:** Radiación ultravioleta B de banda estrecha (UVB-NB) o PUVA.
- **Fármacos Sistémicos Clásicos: Metotrexato oral (15 a 25 mg una vez por semana + ácido fólico)** como fármaco de primera línea; Acitretina oral (retinoide sistémico); Ciclosporina A oral.
- **Terapias Biológicas (Garantía GES N° 84):** Anticuerpos monoclonales anti-TNF (Adalimumab, Infliximab), anti-IL-17 (Secukinumab, Ixekizumab) y anti-IL-23 (Ustekinumab, Guselkumab).

• **REGLA DE ORO VITAL: LOS CORTICOIDES SISTÉMICOS (ORALES O ENDOVENOSOS) ESTÁN ESTRICTAMENTE CONTRAINDICADOS.**

Aunque aclaran las placas rápidamente, su suspensión desencadena invariablemente un rebote violento hacia Psoriasis Pustulosa Generalizada o Eritrodermia de alta mortalidad.

5. ARTRITIS PSORIÁSICA, ERITRODERMIA Y LÍQUEN PLANO: SOSPECHA Y DERIVACIÓN

Artritis psoriásica (sospecha, tratamiento inicial y derivación). 1.11.1.001 Aparece en el 10 a 30% de los pacientes con psoriasis, casi siempre años después de la piel (en cerca del 15% la precede), y se asocia a la psoriasis ungueal. Se sospecha ante todo psoriásico con **dolor y rigidez articular de más de 30 minutos en la mañana, dactilitis o entesitis** (talón de Aquiles, fascia plantar). Los patrones son: oligoartritis asimétrica (el más frecuente), poliartritis simétrica parecida a la artritis reumatoide pero con **factor reumatoide y anti-CCP negativos**, compromiso de interfalángicas distales, artritis mutilante y espondilitis o sacroileítis (HLA-B27). La radiografía muestra erosiones con proliferación ósea y la imagen «en lápiz en copa»; VHS y PCR suelen estar elevadas. Se aplican los criterios CASPAR. El daño articular es erosivo e irreversible, por lo que el médico general inicia un AINE y **deriva precozmente a reumatología** (metotrexato y biológicos anti-TNF o anti-IL-17); los corticoides sistémicos están contraindicados por el riesgo de rebote pustuloso.

Eritrodermia (sospecha, tratamiento inicial y derivación). 6.01.2.004 Es el eritema con descamación de **más del 90% de la superficie corporal**. Las causas más frecuentes son la psoriasis y la dermatitis atópica o eccema que se generaliza, las toxidermias (alopurinol, carbamazepina, sulfas, vancomicina), el linfoma cutáneo de células T (síndrome de Sézary), la pitiriasis rubra pilaris y la idiopática. Por la pérdida de la barrera cutánea se produce **hipotermia, pérdida de líquidos y proteínas con hipoalbuminemia, taquicardia con riesgo de insuficiencia cardíaca de alto gasto y sepsis estafilocócica**; hay linfadenopatías reactivas. Es una urgencia dermatológica: se hospitaliza, se mantiene un ambiente cálido, hidratación endovenosa, emolientes y compresas, corticoide tópico de potencia media, control de electrolitos, albúmina y hemocultivos, se suspenden los fármacos sospechosos y se hace biopsia para precisar la causa. Si la causa es psoriasis, el tratamiento sistémico lo define el dermatólogo (metotrexato, ciclosporina o biológicos), nunca corticoides orales.

Líquen plano (sospecha, tratamiento inicial y derivación). 6.01.1.015 Dermatosis inflamatoria mediada por linfocitos T, cuya semiología se resume en las «seis P»: **pápulas poligonales, pruriginosas, planas, de color violáceo (púrpura)** que forman placas. Sobre las pápulas se ve una fina red blanquecina, las **estrías de Wickham**, y hay **fenómeno de Koebner**. Se ubica en la cara flexora de muñecas y antebrazos, región lumbar y tobillos; en la **mucosa oral** se ve un encaje blanquecino reticulado en la cara interna de las mejillas; en las uñas hay adelgazamiento, surcos longitudinales y pterigión, y en el cuero cabelludo el líquen planopilaris produce alopecia cicatricial. Se asocia a **hepatitis C** (pedir serología) y a fármacos liquenoides (IECA, tiazidas, betabloqueadores, antimaláricos). La biopsia muestra dermatitis de interfase en banda. Tratamiento inicial: **clobetasol 0,05% tópico** y antihistamínico para el prurito; en formas extensas se usan ciclos cortos de corticoide oral por indicación del especialista. La mayoría remite en 1 a 2 años; el líquen oral erosivo tiene riesgo (cerca de 1%) de transformarse en carcinoma espinocelular, por lo que se deriva y se controla.

TABLA 16.5.C · PROTOCOLO TERAPÉUTICO ESCALONADO EN PSORIASIS VULGAR — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

ESCALÓN	FÁRMACO / MODALIDAD	MECANISMO DE ACCIÓN	PRECAUCIÓN DE SEGURIDAD
1. Tópico	Calcipotriol + Dipropionato de Betametasona ungüento	Sinergia antiproliferativa y antiinflamatoria	No exceder 100 g/semana por riesgo de hipercalcemia
2. Fototerapia	Radiación Ultravioleta B de banda estrecha (UVB-NB)	Inmunomodulación dérmica y apoptosis linfocitaria	Contraindicado en melanoma previo o lupus
3. Sistémico clásico	Metotrexato 15-25 mg oral 1 vez por semana + Ácido fólico	Antagonista de folatos; frena replicación celular	Hepatotoxicidad, mielosupresión; pedir hemograma y perfil
4. Sistémico oral 2	Acitretina 25-50 mg/día oral (retinoide)	Regula la diferenciación epidérmica en pustulosa	TERATOGÉNICO: prohibido embarazo por 3 años post-uso
5. Biológico	Anti-IL-17 (Secukinumab) o Anti-IL-23 (Ustekinumab)	Bloqueo selectivo de la cascada citoquínica Th17	Descartar Tuberculosis latente (PPD/QuantiFERON) previa

16.5. Psoriasis Vulgar: Fenómeno de Koebner, Auspitz y Terapias Tópicas/Sistémicas — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (PSORIASIS VULGAR)

- El raspado metódico de Brocq culmina en el Signo de Auspitz (rocío sangrante patognomónico).
- La psoriasis en placas típica se ubica en superficies de extensión: codos, rodillas y región lumbosacra.
- El tratamiento tópico de elección es la combinación fija de Corticoide potente + Calcipotriol.
- CONTRAINDICACIÓN FATAL: NUNCA usar corticoides orales o parenterales (causan rebote a psoriasis pustulosa letal).
- El fenómeno de Koebner es la aparición de lesiones psoriásicas típicas sobre piel sana traumatizada.
- La psoriasis en gotas ocurre en jóvenes tras una faringoamigdalitis estreptocócica.
- La psoriasis moderada-grave ingresa a garantías GES N° 84 (fototerapia, metotrexato y biológicos).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

16.5

Hombre de 42 años consulta por placas eritematosas pruriginosas en ambos codos, región sacra y cuero cabelludo desde hace 2 años. Al examen físico se aprecian placas eritematosas solevantadas de 4 a 6 cm de diámetro, muy bien delimitadas, cubiertas por escamas gruesas blanco-nacaradas. Al realizar el curetaje metódico con un abatelenguas, las escamas se desprenden en virutas blanquecinas, luego se levanta una membrana transparente continua y finalmente brota un punteado hemorrágico fino en gotitas rojas sobre la superficie desnudada.

Conducta oficial razonada. El raspado metódico de Brocq con visualización sucesiva del signo de la bujía, membrana despegable y la aparición del Signo de Auspitz o rocío sangrante patognomónico confirma el diagnóstico de Psoriasis Vulgar en placas. El rocío hemorrágico se produce al decaptar los capilares dilatados de las papilas dérmicas elongadas que llegan muy cerca de la superficie por la paraqueratosis y agranulosis epidérmica. La conducta terapéutica inicial de primera línea para placas localizadas es la combinación tópica de un corticoide potente (clobetasol o betametasona) con un análogo de la vitamina D (calcipotriol).

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 16.5 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.1.024

1. Un hombre de 36 años con antecedente de psoriasis en placas bien controlada sufre una herida cortante lineal en el antebrazo izquierdo durante un trabajo de carpintería. Tres semanas después, observa con sorpresa que sobre la cicatriz lineal de la herida se ha desarrollado una placa eritematosa idéntica a sus lesiones de psoriasis, cubierta de escamas plateadas nacaradas. ¿Cómo se denomina este fenómeno semiológico?

A) Signo de Darier
B) Fenómeno isomórfico de Koebner
C) Signo de Nikolsky
D) Fenómeno de patergia
E) Signo de Auspitz

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.1.024

2. Un escolar de 10 años, que presentó una faringoamigdalitis purulenta tratada con paracetamol hace dos semanas, es traído por su madre por la aparición súbita y eruptiva de múltiples pápulas eritematosas pequeñas de 3 a 5 mm, cubiertas por una fina escama blanquecina, diseminadas en todo el tronco y raíz de extremidades. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Pitiriasis rosada de Gibert
B) Psoriasis en gotas (guttata)
C) Exantema súbito por herpesvirus 6
D) Sífilis secundaria (roseola sifilítica)
E) Escabiosis complicada

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.1.024

3. ¿Cuál de los siguientes tratamientos está FORMALMENTE CONTRAINDICADO en un paciente con psoriasis vulgar debido al altísimo riesgo de desencadenar un rebote potencialmente mortal hacia psoriasis pustulosa generalizada o eritrodermia al suspenderlo?

A) Calcipotriol tópico en ungüento
B) Corticoides orales o sistémicos (como prednisona o betametasona parenteral)
C) Metotrexato oral semanal con suplemento de ácido fólico
D) Fototerapia con radiación ultravioleta B de banda estrecha
E) Anticuerpos monoclonales anti-interleucina 17 (secukinumab)

Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.001

4. Un hombre de 45 años con psoriasis en placas severa que compromete el 25% de su superficie corporal consulta además por dolor e inflamación tumefacta marcada en el segundo dedo de la mano derecha y en el tercer dedo del pie izquierdo, los cuales lucen completamente engrosados y tumefactos en toda su longitud, semejando un embutido. El factor reumatoide es negativo y la radiografía muestra erosiones en las articulaciones interfalángicas distales. ¿Cómo se denomina este signo inflamatorio característico?

A) Nódulos de Heberden
B) Dactilitis o "dedo en salchicha"
C) Tofos gotosos periarticulares
D) Tenosinovitis infecciosa flexora
E) Eritema nudoso digital

Más preguntas online de Psoriasis Vulgar →

16.6. Dermatitis Atópica: Hanifin y Rajka, Corticoides Tópicos e Hidratación

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 6.01.1.004 2.01.1.107

¿POR QUÉ?

La dermatitis atópica es la dermatosis inflamatoria más frecuente de la infancia y forma parte de la marcha atópica (junto con alergias alimentarias, asma y rinitis). El prurito intenso es el síntoma mandatorio y la hidratación cutánea con emolientes es la piedra angular que repara la barrera cutánea deficiente por mutaciones en la filagrina.

1. FISIOPATOLOGÍA DE LA BARRERA CUTÁNEA Y MARCHA ATÓPICA

La dermatitis atópica resulta de la interacción de dos anomalías primarias: 6.01.1.004 2.01.1.107

1. **Defecto de la barrera epidérmica:** Mutaciones con pérdida de función en el gen de la **filagrina** (proteína clave en la compactación de queratina y síntesis de factores humectantes naturales), lo que provoca pérdida transepidérmica de agua (piel seca o xerosis extrema) y penetración facilitada de alérgenos.
2. **Desregulación inmunológica Th2:** Sobreproducción de IgE e hiperreactividad frente a antígenos ambientales.

• **Marcha Atópica:** Secuencia temporal típica en niños con predisposición: Dermatitis Atópica en lactante → Alergia alimentaria → Asma bronquial infantil → Rinitis alérgica. **(ver Imagen 16.6A)**

2. CRITERIOS DE HANIFIN Y RAJKA Y DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA EDAD

Para el diagnóstico se exige el cumplimiento de **3 o más criterios mayores** y 3 menores. **Criterio cardinal indispensable: PRURITO INTENSO**. 6.01.1.004 2.01.1.107

• **Topografía según la edad del paciente (pregunta típica de examen):**

- **Fase del Lactante (menores de 2 años):** Afecta predominantemente las **mejillas (respetando el triángulo nasogeniano perioral)**, cuero cabelludo y las caras extensoras de extremidades. Las lesiones son eccematosas agudas y exudativas con costras. **SIGNO CLAVE DE EXAMEN: RESPETA ESTRICTAMENTE LA ZONA CUBIERTA POR EL PAÑAL** (el microclima húmedo del pañal previene la sequedad atópica).
- **Fase Infantil (2 a 12 años):** Las lesiones se trasladan a los **pliegues flexurales**: fosas antecubitales (pliegue del codo) y fosas poplíteas (hueco detrás de la rodilla), muñecas, tobillos y cuello. Lesiones subagudas con inicio de liquenificación.
- **Fase del Adulto (> 12 años):** Compromete pliegues de flexión, cuello, cara y dorso de manos, con **liquenificación marcada** (piel engrosada con pliegues acentuados por rascado crónico). **(ver Imagen 16.6B)**

3. TRATAMIENTO ESCALONADO Y COMPLICACIONES INFECCIOSAS

• **Tratamiento de Mantenimiento de Base (Pilar Fundamental):**

- **Emolientes e hidratantes abundantes a diario** aplicados inmediatamente tras el baño ("técnica soak and seal"). 6.01.1.004
- Baños cortos (5 a 10 min) con agua tibia (no caliente) y jabones syndet (sin detergentes agresivos). Ropa 100% de algodón. 2.01.1.107

• **Manejo del Brote Agudo: Corticoides Tópicos**.

Fármaco de elección adaptando la potencia al sitio anatómico:

- *Cara, párpados y pliegues:* Corticoides de **baja potencia (Hidrocortisona al 1%)** o inhibidores de la calcineurina tópicos (**Tacrolimus 0.03-0.1%**, Pimecrolimus) para evitar atrofia cutánea y estrías.
- *Tronco y extremidades:* Corticoides de **mediana a alta potencia (Betametasona, Mometasona)** por 7 a 14 días.

• **Complicaciones Infecciosas:**

- *Impetiginización bacteriana secundaria (S. aureus):* Costras melicéricas mielosas amarillentas; requiere antibióticos tópicos (mupirocina) u orales (cefadroxilo).
- **Eccema Herpético de Kaposi:** Infección viral diseminada por VHS sobre la piel atópica dañada; brote agudo de vesículas umbilicadas dolorosas generalizadas con fiebre. **EMERGENCIA MÉDICA: Requiere ACICLOVIR ENDOVENOSO urgente**. **(ver Imagen 16.6C)**



Eccema herpético de Kaposi



A. LACTANTE



B. ECCEMA CON RASCADO



C. COSTRAS MELICÉRICAS

Imagen 16.6

FIGURA 16.6 · ALGORITMO DE FASES CLÍNICAS Y MANEJO DE DERMATITIS ATÓPICA

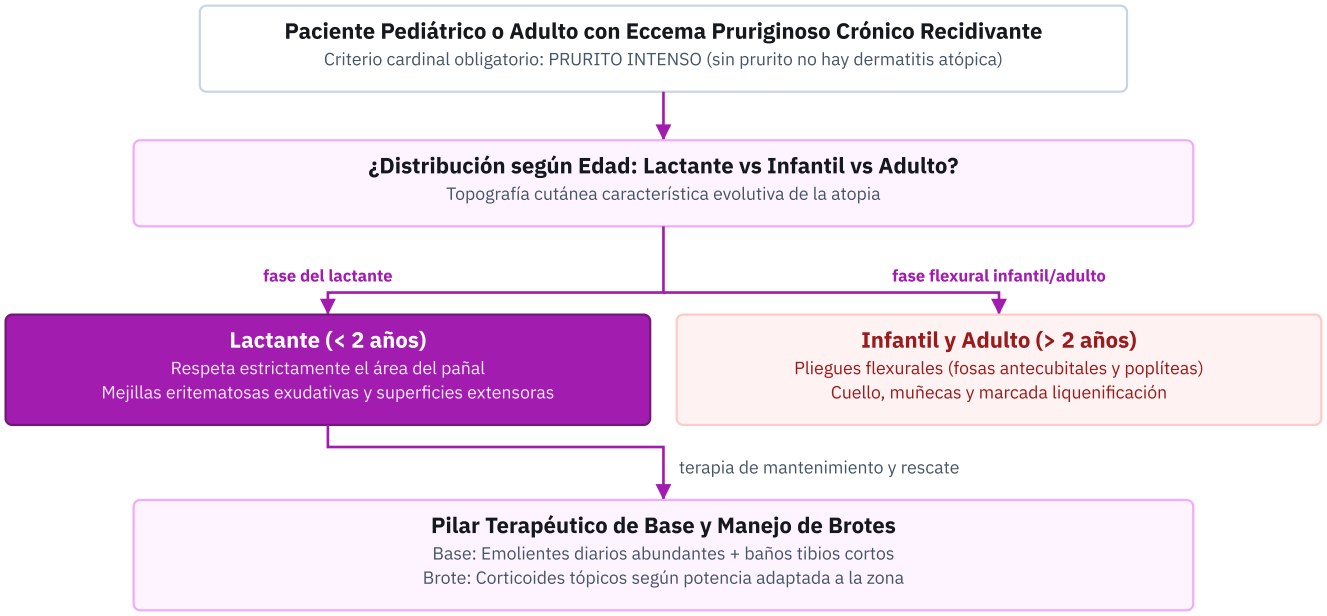


TABLA 16.6 · TOPOGRAFÍA DE LA DERMATITIS ATÓPICA SEGÚN GRUPO ETARIO 6.01.1.004, 2.01.1.107

ETAPA ETARIA	LOCALIZACIÓN CUTÁNEA CLÁSICA	TIPO DE LESIÓN PREDOMINANTE	ZONA RESPETADA TÍPICA
Lactante (< 2 años)	Mejillas, cuero cabelludo, caras extensoras	Eccema agudo exudativo, eritema y costras	RESPETA EL ÁREA DEL PAÑAL y triángulo perioral
Infantil (2 a 12 años)	Pliegues flexurales (fosa antecubital y poplítea)	Pápulas descamativas, liquenificación leve	Menor compromiso facial que en lactantes
Adulto (> 12 años)	Pliegues de flexión, cuello, manos y párpados	Placas liquenificadas secas por rascado crónico	Tronco suele estar menos afectado

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 16.6

Lactante de 7 meses es traído por su madre por presentar lesiones rojas muy pruriginosas en ambas mejillas que le impiden dormir. Al examen físico se aprecia eritema brillante exudativo con pequeñas vesículas y costras en ambas mejillas, respetando el área perioral, y lesiones similares en las caras extensoras de brazos y piernas. Al desvestirlo para cambiar el pañal, la piel de toda la región glútea e inguinal cubierta por el pañal se encuentra completamente sana y sin lesiones.

Conducta oficial. La presencia de eccema agudo exudativo pruriginoso en mejillas y superficies de extensión en un lactante menor, con el signo cardinal patognomónico de respeto absoluto de la zona del pañal, establece el diagnóstico definitivo de Dermatitis Atópica en fase del lactante. La zona del pañal no se afecta porque la oclusión y humedad natural del pañal impiden la xerosis epidérmica atópica. La conducta médica correcta consiste en indicar cuidados generales de la piel (baños cortos tibios con sustitutos de jabón syndet, emolientes tópicos sin perfume post-baño) y prescribir un corticoide tópico de baja potencia (hidrocortisona al 1% en crema) aplicado dos veces al día por pocos días en las mejillas.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- El PRURITO INTENSO es el criterio diagnóstico cardinal obligatorio de dermatitis atópica.
- En el lactante afecta mejillas y convexidades, y RESPETA ESTRICTAMENTE el área del pañal.
- En niños mayores y adultos se localiza en los PLIEGUES FLEXURALES (fosas antecubitales y poplíteas).
- La base terapéutica de por vida son los emolientes e hidratantes diarios ("soak and seal").
- En brotes se usan corticoides tópicos (baja potencia en cara/pliegues como hidrocortisona; alta en cuerpo).
- El Eccema herpético de Kaposi (vesículas umbilicadas + fiebre) requiere Aciclovir EV urgente.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 16.6

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.1.004

1. Un lactante de 8 meses presenta lesiones eccematosas eritematosas, exudativas y muy pruriginosas en ambas mejillas y caras de extensión de los miembros inferiores desde hace 2 meses. Al retirar el pañal, la piel de la zona genitoinguinal y perianal se encuentra perfectamente íntegra y sin eritema ni descamación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Dermatitis del pañal candidiásica
B) Dermatitis atópica del lactante
C) Psoriasis vulgar infantil
D) Dermatitis seborreica del lactante
E) Acrodermatitis enteropática

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.1.004

2. Un niño de 5 años con antecedentes de dermatitis atópica severa presenta bruscamente un empeoramiento clínico con fiebre de 38.9 °C, malestar general y la aparición de múltiples vesículas umbilicadas agrupadas y pústulas dolorosas que rápidamente se erosionan formando costras en sacabocados sobre las áreas de eccema en cuello y flexuras. ¿Cuál es el diagnóstico de esta complicación y el tratamiento específico de urgencia?

A) Impétigo ampollar; indicar cefadroxilo oral
B) Eccema herpético de Kaposi (erupción variceliforme); hospitalizar e iniciar aciclovir endovenoso
C) Sepsis por Pseudomonas; iniciar ceftazidima endovenosa
D) Reacción adversa a corticoides tópicos; suspender todo tratamiento y observar
E) Molusco contagioso diseminado; realizar curetaje de las lesiones

Más preguntas online de Dermatitis Atópica →

16.7. Dermatitis Seborreica vs Dermatitis de Contacto (Alérgica vs Irritativa)

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 6.01.1.006 6.01.1.007 6.01.4.005 6.01.1.005 6.01.1.011 2.01.1.108

¿POR QUÉ?

Los eccemas comprenden un grupo heterogéneo de dermatosis inflamatorias con prurito y espongiosis epidérmica. El médico general debe distinguir con certeza la dermatitis seborreica (dependiente de Malassezia en áreas sebáceas) de la dermatitis de contacto irritativa (frecuente en dueñas de casa y trabajadores manuales) y de la dermatitis de contacto alérgica mediada por inmunidad celular frente a metales como el níquel.

1. DERMATITIS SEBORREICA: CLÍNICA Y POBLACIONES DE RIESGO

Dermatosis eritematoescamosa crónica, muy prevalente, mediada por una respuesta inflamatoria anormal a levaduras del género *Malassezia* (*Pityrosporum ovale*) que colonizan el sebo cutáneo. 6.01.1.006

• **Clínica en el Adulto:** Placas eritematosas cubiertas por **escamas grasosas, untuosas y amarillentas** en áreas de alta densidad sebácea: **cuero cabelludo (pitiriasis capitis o "caspa"), surcos nasogenianos, entrecejo, conducto auditivo externo, pestañas (blefaritis) y región esternal media**. Prurito leve o moderado.

• **Poblaciones Especiales de Alerta:**

- **Lactantes:** "Costra láctea" en cuero cabelludo y dermatitis en pliegues; cuadro benigno autolimitado.

- **Pacientes con VIH/SIDA o Enfermedad de Parkinson:** La dermatitis seborreica es extraordinariamente severa, extensa, confluente y refractaria a tratamiento convencional. Un brote atípico explosivo en un adulto joven obliga a solicitar test de VIH.

• **Tratamiento:** Champú antifúngico con **Ketoconazol al 2%** o sulfuro de selenio / piritionato de zinc 2 a 3 veces por semana + Corticoides tópicos de baja potencia (hidrocortisona) en ciclos muy cortos para el eritema agudo. **(ver Imagen 16.7A)**

2. DERMATITIS DE CONTACTO IRRITATIVA (DCI)

Representa el **80% de todas las dermatitis de contacto**. Es un daño citotóxico físico o químico directo sobre la barrera epidérmica **SIN BASE INMUNOLÓGICA** (no requiere sensibilización previa y puede ocurrirle a cualquier persona si la sustancia es suficientemente concentrada). 6.01.1.007

• **Agentes comunes:** Detergentes, lejía/cloro, disolventes, ácidos, álcalis, fricción repetida, agua y jabón constantes ("eccema de las amas de casa").

• **Clínica:** Confinada **estrictamente a la zona anatómica de contacto con el irritante** (habitualmente manos), con bordes netos. Predomina la sensación de **ardor, tirantez, sequedad y quemazón** más que prurito. Piel eritematosa, agrietada, fisurada y descamativa.

• **Pruebas epicutáneas del parche: NEGATIVAS**.

• **Tratamiento:** Retirar y evitar el irritante, uso de guantes protectores con forro de algodón interno y cremas barrera hidratantes. **(ver Imagen 16.7C)**

3. DERMATITIS DE CONTACTO ALÉRGICA (DCA)

Representa el **20% de las dermatitis de contacto**. Es una reacción de **hipersensibilidad retardada celular Tipo IV** mediada por linfocitos T sensibilizados. 6.01.1.007 6.01.4.005

• Requiere un período de sensibilización previo (días a años). Afecta solo a individuos previamente alérgicos.

• **Alérgenos clásicos de examen:**

- **NÍQUEL (el alérgeno más frecuente del mundo):** Joyas de fantasía, bisutería, hebillas de cinturón (eccema periumbilical), botones metálicos de jeans, relojes.

- **Cromo / Dicromato de potasio:** Cemento húmedo (típico en trabajadores de la construcción) y curtido de cueros.

- Fragancias, bálsamo del Perú, conservantes de cosméticos y resinas epoxi.

• **Clínica: PRURITO INTENSO CARDINAL**. Lesiones eccematosas exudativas con vesículas agudas que **tienden a sobrepasar y extenderse más allá de los límites físicos del contacto**.

• **Diagnóstico de Certeza: PRUEBAS EPICUTÁNEAS DEL PARCHE (PATCH TEST)**.

Se aplican alergenos en la espalda bajo oclusión durante 48 horas. Se realizan **dos lecturas: a las 48 horas** (al retirar los parches) y **a las 96 horas** (4.° día, donde la reacción alérgica persiste o aumenta, a diferencia de la irritativa que se desvanece).

• **Tratamiento:** Evitación estricta del alérgeno específico y **corticoides tópicos de mediana o alta potencia** durante 1 a 2 semanas.

4. DERMATITIS DEL PAÑAL: IRRITATIVA, CANDIDIÁSICA Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

La **dermatitis del pañal** es la dermatosis más frecuente del lactante (pico entre los 9 y 12 meses). Es una dermatitis de contacto irritativa causada por la **oclusión, la humedad, el contacto con orina y deposiciones** (las enzimas fecales y el pH alcalino por la ureasa dañan el estrato córneo) y la fricción. La clave clínica es que el eritema, las pápulas y las erosiones se ubican en las **zonas convexas** (nalgas, genitales, muslos internos, bajo vientre) y **respetan el fondo de los pliegues**. Cuando se agrega **Candida albicans** (persistencia mayor de 3 días, uso de antibióticos o diarrea) el eritema es rojo intenso, **compromete los pliegues** y aparecen pápulas y pústulas satélites con un collarete descamativo. Diagnósticos diferenciales: dermatitis seborreica (placas salmón con escama amarilla que también afectan pliegues y cuero cabelludo), psoriasis del pañal, acrodermatitis enteropática (déficit de zinc: lesiones perioriificiales y acrales, diarrea y alopecia), histiocitosis de células de Langerhans (erosiones y pápulas petequiales en pliegues que no ceden), impétigo ampolloso, escabiosis y sífilis congénita. **(ver Imagen 16.7B)** 6.01.1.005 2.01.1.108

Tratamiento y prevención (nivel completo). Cambiar el pañal cada 2 a 3 horas y después de cada deposición, limpiar con agua tibia y algodón o toallitas sin alcohol ni fragancia, **secar sin frotar**, dejar la zona al aire unos minutos y usar pañales superabsorbentes. En cada cambio se aplica una **barrera de pasta de óxido de zinc** (10 a 40%) o vaselina; se evita el talco (riesgo de aspiración) y los jabones irritantes. Si el eritema es intenso, hidrocortisona 1% por 3 a 5 días; **no se usan corticoides potentes ni asociaciones de corticoide con antifúngico y antibiótico** por el riesgo de atrofia y absorción sistémica en la zona ocluida. Si hay candidiasis: **nistatina, clotrimazol 1% o miconazol** crema cada 12 horas por 7 a 14 días, sumada a la barrera, y tratar la candidiasis oral si existe. Se deriva si no mejora en 1 a 2 semanas, si hay erosiones ulceradas profundas o nódulos violáceos (granuloma glúteo infantil) o si se sospecha una enfermedad de fondo. La **dermatitis de contacto del niño** (níquel de broches y botones, perfumes, látex, tinturas de ropa) se maneja con las mismas reglas descritas antes: identificar y evitar el agente y usar corticoide tópico de baja potencia.

5. FOTODERMATOSIS: FOTOTOXICIDAD, FOTOALERGIA Y FOTODERMATOSIS IDIOPÁTICAS

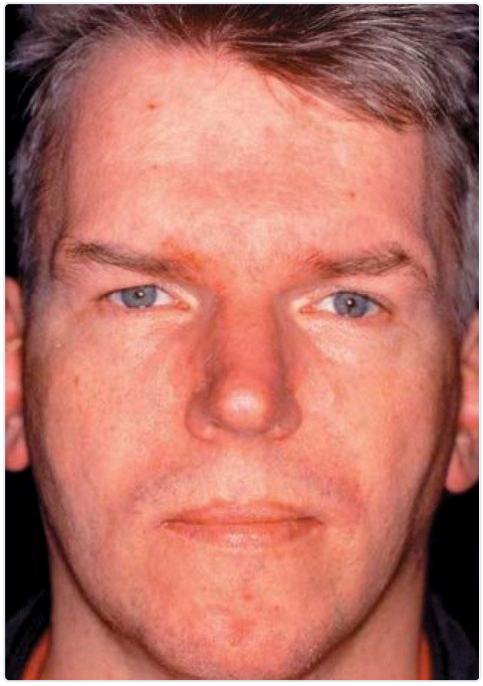
Las **fotodermatosis** son enfermedades desencadenadas o agravadas por la radiación ultravioleta y visible. El signo clave es la distribución en **zonas expuestas** (cara, escote en «V», dorso de manos y antebrazos) con **respeto de las zonas cubiertas o sombreadas** (párpados superiores, región submentoniana, retroauricular y pliegues). Se agrupan en: (1) **fototoxicidad**: reacción no inmunológica, dependiente de la dosis, que puede aparecer en la primera exposición y parece una quemadura solar exagerada (eritema, edema, ampollas y luego hiperpigmentación); la producen doxiciclina y tetraciclinas, amiodarona, tiazidas, furosemida, quinolonas, AINE (piroxicam, ketoprofeno) y voriconazol, y las plantas con furocumarinas (limón, higo, apio, ruda) causan la **fitofotodermatitis**, con lesiones lineales o bizarras que dejan una mancha pigmentada. (2) **Fotoalergia**: hipersensibilidad tipo IV que requiere sensibilización previa, es eccematosa y puede desbordar hacia zonas cubiertas (filtros solares como la oxibenzona, ketoprofeno tópico, fenotiazinas). (3) **Fotodermatosis idiopáticas**: la **erupción polimorfa lumínica** es la más frecuente (pápulas pruriginosas en áreas expuestas, horas a días después de las primeras exposiciones intensas de primavera o verano, en mujeres jóvenes, que remite sin cicatriz en 1 a 2 semanas), la urticaria solar y el prurigo actínico. (4) 6.01.1.011

Dermatosis agravadas por el sol: lupus eritematoso, dermatomiositis, rosácea, porfiria cutánea tarda (ampollas y fragilidad en el dorso de las manos, hipertricosis, asociada a hepatitis C, alcohol y hierro) y pelagra (dermatitis en «collar de Casal», diarrea y demencia).

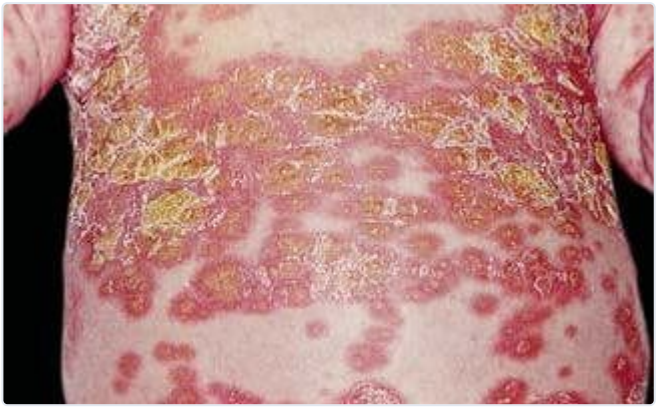


Fototoxicidad por un antidepresivo heterocíclico: eritema y edema en la cara expuesta al sol, con respeto del labio superior sombreado

Conducta (sospecha y tratamiento inicial). Se identifica y suspende el fármaco o el agente sospechoso, se indica **fotoprotección** (protector solar de amplio espectro con FPS 50 o más, ropa y sombrero, evitar las horas de mayor radiación entre las 10 y las 16 horas), frío local y emolientes, corticoide tópico de potencia media o alta en el brote agudo y antihistamínico para el prurito. Las formas intensas de erupción polimorfa lumínica pueden requerir un ciclo corto de prednisona o fototerapia de endurecimiento por el especialista. Cuando la distribución o el cuadro sugieren una enfermedad de fondo se piden anticuerpos antinucleares y anti-Ro/SSA (lupus) o porfirinas en orina (porfiria). Se deriva a dermatología si no cede en 2 a 4 semanas, si hay compromiso sistémico o si se sospecha una enfermedad subyacente.



A. DERMATITIS SEBORREICA



B. SEBORREICA DEL LACTANTE



C. IRRITATIVA DE MANOS

Imagen 16.7

FIGURA 16.7 · ALGORITMO DIFERENCIAL DE ECCEMAS: SEBORREICA VS CONTACTO

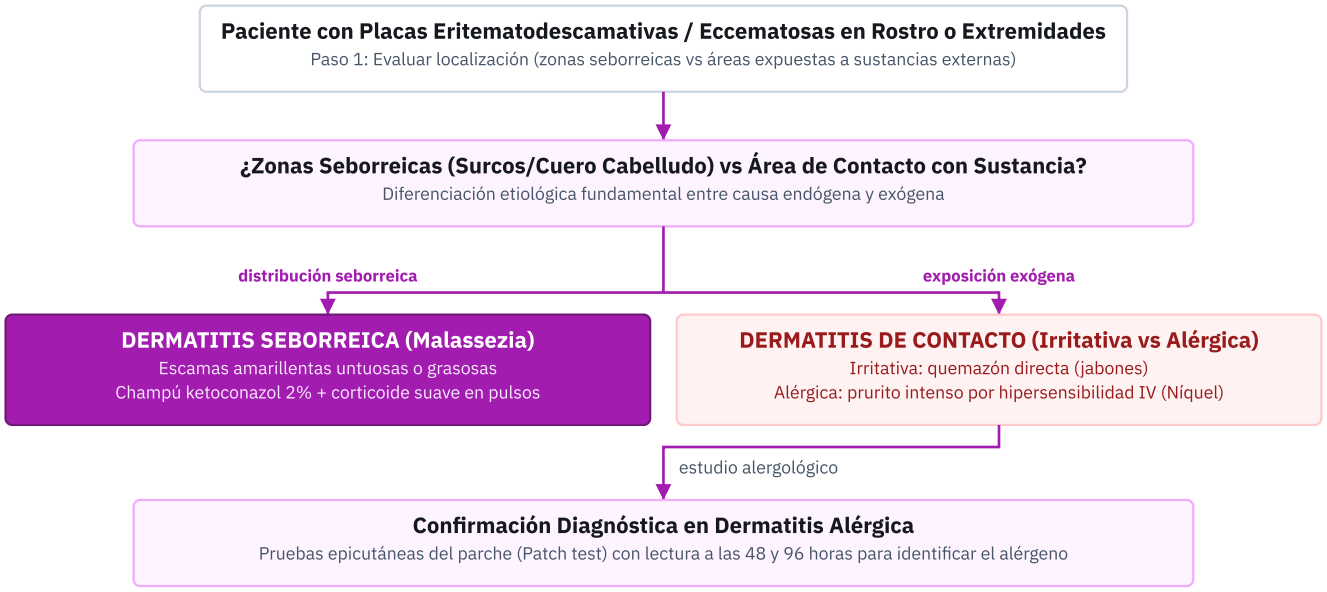


TABLA 16.7 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: CONTACTO IRRITATIVA VS CONTACTO ALÉRGICA VS SEBORREICA

6.01.1.006, 6.01.1.007, 6.01.4.005, 6.01.1.005, 6.01.1.011, 2.01.1.108

CRITERIO	CONTACTO IRRITATIVA (80%)	CONTACTO ALÉRGICA (20%)	DERMATITIS SEBORREICA
Mecanismo etiopatogénico	Daño tóxico celular directo no inmune	Hipersensibilidad retardada Tipo IV (linfocitos T)	Respuesta inmune a levadura Malassezia
Sensibilización previa	NO requiere; le ocurre a cualquiera	SÍ requiere sensibilización previa	No aplica (flora comensal comúnmente presente)
Síntoma cardinal	Ardor, quemazón, tirantez dolorosa	PRURITO INTENSO y continuo	Prurito leve o asintomático
Límites de las lesiones	Confinadas estrictamente al área de contacto	SOBREPASAN los límites del contacto	Zonas seborreicas (surcos, cejas, tórax)
Aspecto de la escama	Escama seca, fisurada, agrietada	Eccema microvesicular exudativo	Escamas GRASOSAS, untuosas, amarillentas
Pruebas del parche (Patch test)	NEGATIVAS (sin reacción alérgica)	POSITIVAS a las 48 y 96 horas	No indicadas
Tratamiento de elección	Evitar irritante + cremas barrera	Evitar alérgeno + Corticoide tópico	Champú Ketoconazol 2% + corticoide suave

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 16.7

Mujer de 26 años consulta por lesiones eccematosas muy pruriginosas en el abdomen inferior de 3 semanas de evolución. Al examen físico se aprecia una placa eritematosa con pequeñas vesículas y excoriaciones por rascado de 4 x 3 cm localizada en la línea media periumbilical inferior, que coincide exactamente con el roce de la hebilla metálica de sus pantalones de mezclilla. Además, refiere que cuando usa aretes de fantasía se le inflaman los lóbulos de las orejas.

Conducta oficial. La presencia de una placa eccematosa intensamente pruriginosa localizada bajo el ombligo en la zona de contacto con una hebilla metálica, asociada al antecedente de eccema en los lóbulos auriculares con bisutería de fantasía, es diagnóstica de Dermatitis de Contacto Alérgica por Níquel (hipersensibilidad retardada tipo IV). El níquel es el sensibilizante cutáneo más común a nivel mundial. La confirmación etiológica formal se realiza mediante Pruebas Epicutáneas del Parche (Patch Test) con lectura a las 48 y 96 horas. El tratamiento consiste en evitar el contacto directo con metales niquelados y aplicar corticoides tópicos de mediana potencia por 7 a 10 días.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- La dermatitis seborreica cursa con escamas amarillentas untuosas en surcos nasogenianos y cuero cabelludo.
- Dermatitis seborreica severa y refractaria en adultos jóvenes obliga a descartar infección por VIH o Parkinson.
- Dermatitis de contacto irritativa (80%) = daño tóxico no inmune con ardor/fisuras delimitado a la zona de contacto.
- Dermatitis de contacto alérgica (20%) = hipersensibilidad tipo IV con prurito intenso que sobrepasa el área de contacto.
- El alérgeno más frecuente es el NÍQUEL (bisutería, hebillas, botones de jeans).
- El diagnóstico de confirmación de dermatitis alérgica es el Patch test con lectura a las 48 y 96 horas.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 16.7

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.1.007

1. Un trabajador de la construcción de 40 años consulta por eccema subagudo en ambas manos de 2 meses de evolución. Trabaja preparando mezclas de cemento y albañilería. Refiere prurito intenso que se extiende desde las palmas hacia el dorso de las manos y antebrazos. Se sospecha una dermatitis de contacto alérgica ocupacional. ¿Cuál es el alérgeno presente en el cemento más probablemente responsable del cuadro y el examen para confirmarlo?

A) Níquel; determinación de IgE específica sérica
B) Dicromato de potasio (cromo); pruebas epicutáneas del parche (Patch test)
C) Látex; prueba de provocación bronquial
D) Resina epoxi; biopsia cutánea por congelación
E) Formaldehído; frotis directo con hidróxido de potasio

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.1.006

2. Un hombre de 34 años consulta por eritema marcado y descamación grasosa amarillenta muy abundante que compromete de forma simétrica los surcos nasogenianos, el entrecejo y las regiones malares, con brotes intensos en el cuero cabelludo desde hace 3 meses, resistente a cremas hidratantes. Se observa además adelgazamiento moderado y una candidiasis oral al examen bucal. ¿Cuál es la conducta diagnóstica de mayor prioridad clínica que debe plantear el médico?

A) Solicitar perfil lipídico y curva de tolerancia a la glucosa para descartar síndrome metabólico
B) Solicitar prueba de ELISA para VIH con consentimiento informado
C) Realizar biopsia de cuero cabelludo para descartar lupus discoide
D) Indicar tratamiento con isotretinoína oral a dosis plenas
E) Prescribir antibióticos orales de amplio espectro por 6 meses

Más preguntas online de Dermatitis Seborreica vs Dermatitis de Contacto →

16.8. Urticaria Aguda y Crónica: Habones Evanescentes, Angioedema y Antihistamínicos

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 6.01.1.030 6.01.2.001 2.01.1.055 6.01.2.016

¿POR QUÉ?

La urticaria es uno de los motivos de consulta más frecuentes en los servicios de urgencias. La perla semiológica cardinal e indiscutible del habón o roncha es su carácter EVANESCENTE: cada lesión individual brota y desaparece por completo en menos de 24 horas sin dejar rastro. El escalonamiento moderno de guías internacionales prohíbe el uso crónico de corticoides y se basa en cuadruplicar los antihistamínicos de segunda generación.

1. FISIOPATOLOGÍA MASTOCITARIA Y SEMIOLOGÍA DEL HABÓN

La lesión elemental patognomónica de la urticaria es el **HABÓN O RONCHA**. 6.01.1.030 6.01.2.016

• Se produce por la **degranulación de mastocitos dérmicos** con liberación de histamina, leucotrienos y prostaglandinas, induciendo vasodilatación arteriolar (eritema) y aumento transitorio de la permeabilidad capilar con edema de la dermis papilar y media.

• **CRITERIO PATOGNOMÓNICO ABSOLUTO DE EXAMEN: CARÁCTER EVANESCENTE**.

Cada habón individual aparece en minutos, dura entre 30 minutos y pocas horas, y **DESAPARECE TOTALMENTE EN MENOS DE 24 HORAS SIN DEJAR HUELLA NI CICATRIZ**.

Regla de oro de examen: Si una lesión con aspecto de habón permanece **FIJA en el mismo sitio durante más de 24 a 48 horas** o al resolverse deja una pigmentación purpúrica residual (hemosiderina), NO es una urticaria común: es una **Vasculitis Urticariana** y obliga a realizar biopsia cutánea.

2. ANGIOEDEMA Y ALERTA DE ANAFILAXIA

• **Angioedema:** Es el mismo proceso fisiopatológico edematoso pero originado en la **dermis profunda, tejido celular subcutáneo y submucosas**. Se manifiesta como tumefacción difusa tensa y deformante de párpados, labios, lengua o genitales. Cursa con **sensación de tensión, ardor o dolor, más que prurito**. Tarda de 48 a 72 horas en reabsorberse. 6.01.2.001 6.01.2.016 2.01.1.055

• **Banderas Rojas de ANAFILAXIA:** Si los habones o el angioedema se acompañan de:

- Compromiso respiratorio (estridor laríngeo por edema de glotis, disnea, sibilancias o disfonía).
- Compromiso hemodinámico (hipotensión arterial, mareo, síncope, shock).
- Síntomas digestivos cólicos intensos con vómitos tras exposición alérgica.

TRATAMIENTO DE ELECCIÓN INMEDIATO: ADRENALINA (EPINEFRINA) INTRAMUSCULAR a dosis de **0.3 a 0.5 mg (solución 1:1.000 sin diluir) inyectada en la cara anterolateral del muslo**. Los corticoides y antihistamínicos son fármacos secundarios que tardan horas en actuar y NUNCA reemplazan a la adrenalina. **(ver Imagen 16.8A y B)**

3. CLASIFICACIÓN TEMPORAL Y ALGORITMO TERAPÉUTICO INTERNACIONAL

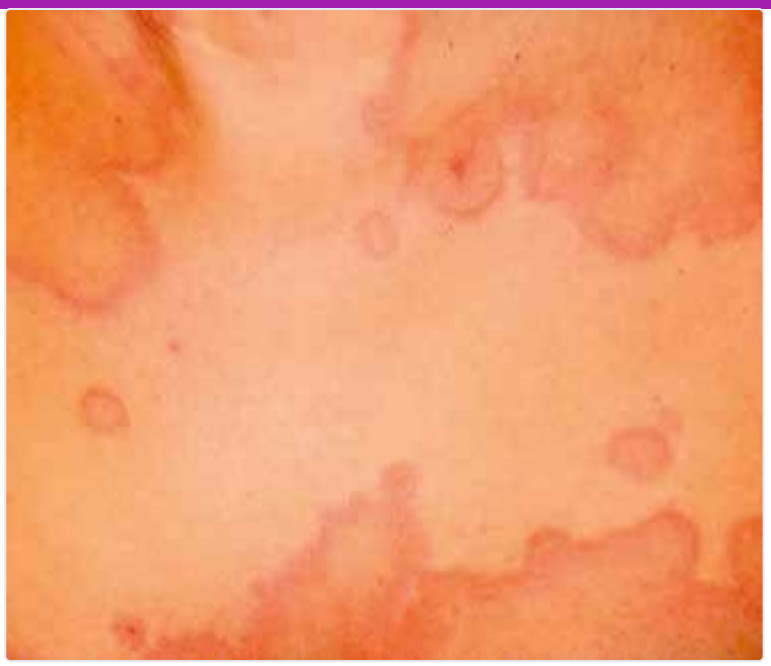
• **Urticaria Aguda:** Duración de los brotes **menor a 6 semanas**. En más del 60% de los casos en niños y adultos se desencadena por **infecciones virales respiratorias o digestivas comunes**. Otras causas: fármacos (AINEs, antibióticos betalactámicos) y alimentos. 6.01.1.030 6.01.2.016 2.01.1.055

• **Urticaria Crónica:** Brotes diarios o casi diarios de habones durante **6 semanas o más**. En el 80% de los casos es **Urticaria Crónica Espontánea (idiopática)**, mediada por autoanticuerpos IgG dirigidos contra el receptor FcεRI del mastocito o contra la IgE.

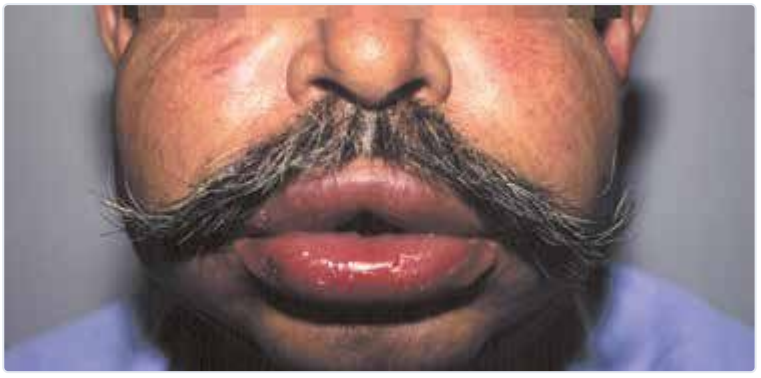
• **Algoritmo de Tratamiento Escalonado (Guías EAACI / GA²LEN / WAO):**

1. **Primera Línea: Antihistamínico H1 de segunda generación (no sedante: Cetirizina 10 mg, Levocetirizina 5 mg, Desloratadina 5 mg, Fexofenadina 180 mg) a dosis estándar diaria**.
2. **Segunda Línea: CUADRUPLICAR LA DOSIS DEL ANTIHISTAMÍNICO H1 DE SEGUNDA GENERACIÓN (hasta 4 veces la dosis estándar diaria)** si no hay control a las 2 a 4 semanas. Es una estrategia de altísima eficacia y seguridad.
3. **Tercera Línea: Omalizumab** (anticuerpo monoclonal anti-IgE) 300 mg subcutáneo mensual.
4. **Cuarta Línea:** Ciclosporina A oral.

TRAMPA GRAVE DE EXAMEN: Los corticoides orales NUNCA se usan en el tratamiento de mantenimiento de la urticaria crónica. Solo se permiten ciclos ultracortos (máximo 3 a 5 días) como rescate en exacerbaciones agudas severas.



A. HABONES



B. ANGIOEDEMA LABIAL

Imagen 16.8

FIGURA 16.8 · ALGORITMO ESCALONADO DE MANEJO DE LA URTICARIA



TABLA 16.8 · URTICARIA COMÚN VS VASCULITIS URTICARIANA 6.01.1.030, 6.01.2.001, 2.01.1.055, 6.01.2.016

PARÁMETRO	URTICARIA COMÚN (AGUDA O CRÓNICA)	VASCULITIS URTICARIANA
Duración de cada lesión individual	EVANESCENTE: desaparece en < 24 HORAS	FIJA: persiste MÁS DE 24 a 48 HORAS
Síntoma subjetivo predominante	PRURITO INTENSO (picazón)	ARDOR, dolor, quemazón o sensibilidad
Evolución al resolverse	Desaparece sin dejar NINGUNA marca	Deja PÚRPURA o mancha pigmentaria residual
Fisiopatología	Degranulación mastocitaria e histamina	Vasculitis leucocitoclástica por inmunocomplejos
Estudio diagnóstico	Clínico; no requiere biopsia	BIOPSIA CUTÁNEA OBLIGATORIA (estudio de LES/hipocomplementemia)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 16.8

Hombre de 32 años consulta por aparición recurrente de ronchas solevantadas, rojizas y muy pruriginosas en el tronco y las extremidades desde hace 3 meses, que aparecen prácticamente todos los días. Refiere que cada roncha individual le dura entre 4 y 6 horas y desaparece sin dejar ninguna cicatriz ni marca en la piel, pero brotan otras nuevas en sitios diferentes. Ha estado usando desloratadina 5 mg al día sin lograr mejoría satisfactoria. Examen físico: múltiples habones eritematosos con halo pálido en abdomen y muslos.

Conducta oficial. El paciente presenta una Urticaria Crónica Espontánea (duración de los brotes mayor a 6 semanas con habones típicamente evanescentes que duran menos de 24 horas y no dejan rastro). Ante la falta de control con un antihistamínico H1 de segunda generación a dosis convencional, la conducta médica estandarizada según las guías clínicas internacionales de consenso (EAACI/GA²LEN) y el MINSAL es Aumentar la dosis del antihistamínico H1 de segunda generación hasta 4 veces la dosis estándar diaria (ej. Levocetirizina 10 a 20 mg/día o Desloratadina 10 a 20 mg/día). Está contraindicado prescribir corticoides orales de forma crónica o mantenida.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- El habón o roncha es EVANESCENTE: dura menos de 24 horas y desaparece sin dejar rastro.
- Si el habón dura más de 24 horas o deja mancha purpúrica residual, es Vasculitis Urticariana (requiere biopsia).
- Urticaria aguda < 6 semanas (desencadenada por virus o fármacos); Urticaria crónica ≥ 6 semanas (autoinmune).
- Primera línea: Antihistamínicos H1 de 2.ª generación no sedantes (Cetirizina, Desloratadina, Levocetirizina).
- Si no responde en 2 a 4 semanas: CUADRUPLICAR la dosis del antihistamínico H1 de 2.ª generación (hasta 4 veces).
- En ANAFILAXIA (compromiso de vía aérea o hipotensión), el tratamiento inmediato vital es ADRENALINA INTRAMUSCULAR.
- Los corticoides orales NUNCA se usan como tratamiento crónico en urticaria.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 16.8

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.1.030

1. Un hombre de 28 años presenta ronchas eritematosas pruriginosas diseminadas en el cuerpo desde hace 2 meses. El médico sospecha una urticaria crónica espontánea. Para corroborar el diagnóstico clínico antes de solicitar exámenes, ¿cuál es la pregunta semiológica clave que debe formularse respecto a las lesiones?

A) ¿Cada roncha individual dura más de 72 horas en el mismo sitio?
B) ¿Las ronchas desaparecen en menos de 24 horas sin dejar marca, apareciendo otras en sitios distintos?
C) ¿Las lesiones dejan cicatrices atróficas deprimidas al desaparecer?
D) ¿Aparecen ampollas de contenido purulento en el centro de las ronchas?
E) ¿Las ronchas duelen intensamente al tacto sin producir picazón?

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.1.030

2. Una paciente de 35 años con diagnóstico de urticaria crónica espontánea continúa presentando brotes diarios de habones intensamente pruriginosos a pesar de tomar religiosamente cetirizina 10 mg al día durante el último mes. No tiene signos de angioedema ni compromiso respiratorio. Según las guías internacionales de manejo de urticaria, ¿cuál es el siguiente paso terapéutico recomendado?

A) Iniciar prednisona oral 40 mg al día durante 3 meses continuos
B) Aumentar la dosis del antihistamínico H1 de segunda generación hasta cuatro veces la dosis estándar (cetirizina hasta 40 mg/día)
C) Cambiar a clorfenamina oral 4 mg cada 6 horas
D) Iniciar tratamiento con azatioprina oral
E) Indicar plasmaféresis de urgencia

Más preguntas online de Urticaria Aguda y Crónica →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 2.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 16.5 A 16.8

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Psoriasis Vulgar: Fenómeno de Koebner, Auspitz y Terapias Tópicas/Sistémicas	El raspado metódico de Brocq culmina en el Signo de Auspitz (rocío sangrante...	**El fenómeno de Koebner es la aparición de lesiones psoriásicas típicas sobre piel sana...**	CONTRAINDICACIÓN FATAL: NUNCA usar corticoides orales o parenterales (causan rebote a...
Dermatitis Atópica: Hanifin y Rajka, Corticoides Tópicos e Hidratación	El PRURITO INTENSO es el criterio diagnóstico cardinal obligatorio de dermatitis...	**En el lactante afecta mejillas y convexidades, y RESPETA ESTRICTAMENTE el área del...**	—
Dermatitis Seborreica vs Dermatitis de Contacto (Alérgica vs Irritativa)	La dermatitis seborreica cursa con escamas amarillentas untuosas en surcos nasogenianos...	**Dermatitis seborreica severa y refractaria en adultos jóvenes obliga a descartar...**	La presencia de una placa eccematosa intensamente pruriginosa localizada bajo el...
Urticaria Aguda y Crónica: Habones Evanescentes, Angioedema y Antihistamínicos	El habón o roncha es EVANESCENTE: dura menos de 24 horas y desaparece sin dejar rastro.	**Si el habón dura más de 24 horas o deja mancha purpúrica residual, es Vasculitis...**	Los corticoides orales NUNCA se usan como tratamiento crónico en urticaria.

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

El raspado metódico de Brocq culmina en el Signo de Auspitz (rocío sangrante patognomónico).

El fenómeno de Koebner es la aparición de lesiones psoriásicas típicas sobre piel sana traumatizada.

La psoriasis en placas típica se ubica en superficies de extensión: codos, rodillas y región lumbosacra.

La psoriasis en gotas ocurre en jóvenes tras una faringoamigdalitis estreptocócica.

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- El fenómeno de Koebner es la aparición de lesiones psoriásicas típicas sobre piel sana traumatizada.
- La psoriasis en placas típica se ubica en superficies de extensión: codos, rodillas y región lumbosacra.
- En el lactante afecta mejillas y convexidades, y RESPETA ESTRICTAMENTE el área del pañal.
- En niños mayores y adultos se localiza en los PLIEGUES FLEXURALES (fosas antecubitales y poplíteas).

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

El raspado metódico de Brocq culmina en el Signo de Auspitz (rocío sangrante patognomónico).	Tema 16.5 →
El PRURITO INTENSO es el criterio diagnóstico cardinal obligatorio de dermatitis atópica.	Tema 16.6 →
La dermatitis seborreica cursa con escamas amarillentas untuosas en surcos nasogenianos y cuero cabelludo.	Tema 16.7 →
El habón o roncha es EVANESCENTE: dura menos de 24 horas y desaparece sin dejar rastro.	Tema 16.8 →

MANUAL EUNACOM DE DERMATOLOGÍA

BLOQUE 03 DE 04 · PERFIL DE CONOCIMIENTOS V3 ASOFAMECH

perfil v3 asofamech
11 CÓDIGOS OFICIALES

03

BLOQUE TEMÁTICO
4 clases

FARMACODERMIAS GRAVES & ENFERMEDADES AMPOLLARES

4	10	MINSAL
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
16.9	Reacciones Medicamentosas Graves: Stevens-Johnson (SSJ) y Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET)	45
16.10	Síndrome DRESS: Erupción Medicamentosa con Eosinofilia y Síntomas Sistémicos	49
16.11	Pénfigo Vulgar (Intraepidérmico) vs Penfigoide Ampollar (Subepidérmico)	54
16.12	Eritema Multiforme: Morfología en Diana Clásica y Asociación a Virus Herpes Simple	59

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

11 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
6.01.2.015	Síndrome de Stevens-Johnson Tema 16.9	Sospecha	Inicial	Derivar
6.01.2.009	Necrolisis tóxica epidérmica Tema 16.9	Sospecha	Inicial	Derivar
6.01.2.014	Síndrome de piel escaldada por estafilococos Tema 16.9	Sospecha	Inicial	No requiere
6.01.2.013	Síndrome de hipersensibilidad a drogas Tema 16.10	Sospecha	Inicial	Completo
6.01.1.025	Reacciones cutáneas por drogas (rush, toxidermia fija) Tema 16.10	Específico	Inicial	Completo
6.01.2.010	Pénfigo y penfigoide Tema 16.11	Sospecha	Inicial	Derivar
6.01.1.020	Pénfigo Tema 16.11	Sospecha	Inicial	Derivar
6.01.5.001	Biopsia de piel Tema 16.11	Derivar a especialista		
6.01.1.010	Eritema polimorfo menor Tema 16.12	Específico	Inicial	Completo
6.01.1.031	Verrugas, herpes simplex, herpes zoster, moluscos Tema 16.12	Específico	Completo	Completo
6.01.4.006	Test TZANCK Tema 16.12	Interpreta y emplea		

BLOQUE 03 · FARMACODERMIAS GRAVES & ENFERMEDADES AMPOLLARES

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
10 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- Los fármacos gatillantes más frecuentes son Alopurinol, Carbamazepina, Cotrimoxazol y AINEs.
- El período de latencia típico es de 1 a 4 semanas tras el inicio del fármaco culpable.
- El Signo de Nikolsky (+) es el desprendimiento de la epidermis por fricción suave sobre piel eritematosa.
- Clasificación por superficie corporal desprendida: SSJ < 10%; Superposición SSJ/NET 10-30%; NET > 30%.
- El score SCORTEN (7 parámetros dentro de las primeras 48 h) estima con precisión la mortalidad.
- La medida de mayor impacto en la sobrevida es el RETIRO INMEDIATO del fármaco sospechoso.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

4 DE 4 TEMAS

Reacciones Medicamentosas Graves: Stevens-Johnson	EUNACOM Diciembre 2025 · #80 · EUNACOM Julio 2024 · #94 · EUNACOM Julio 2024 · #103 · EUNACOM Julio 2016 · #48
Síndrome DRESS: Erupción Medicamentosa con Eosinofilia y Síntomas Sistémicos	EUNACOM Julio 2024 · #104
Pénfigo Vulgar	EUNACOM Enero 2023 · #114
Eritema Multiforme: Morfología en Diana Clásica y Asociación a Virus Herpes Simple	EUNACOM Agosto 2021 · #177 · EUNACOM Agosto 2021 · #30 · EUNACOM Julio 2017 · #86 · EUNACOM Julio 2016 · #43

16.9. Reacciones Medicamentosas Graves: Stevens-Johnson (SSJ) y Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET)

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 6.01.2.015 6.01.2.009 6.01.2.014

¿POR QUÉ?

El Síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) y la Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET o síndrome de Lyell) representan el espectro de máxima gravedad de las reacciones adversas a medicamentos mediadas por inmunidad celular. Se caracterizan por la apoptosis y necrosis masiva de queratinocitos mediada por linfocitos T citotóxicos (CD8+) y células NK mediante la vía Fas/FasL y la secreción masiva de Granulisina. El cuadro se comporta clínicamente como un "gran quemado médico", con alto riesgo de sepsis bacteriana, shock hipovolémico y falla multiorgánica. La evaluación del signo de Nikolsky, la superficie desprendida y el cálculo del score pronóstico SCORTEN son preguntas obligadas en el examen.

1. FÁRMACOS DESENCADENANTES Y FISIOPATOLOGÍA CELULAR

• **Fármacos Culpables de Alto Riesgo (Acrónimo EUNACOM "S-A-P-O-C"):** 6.01.2.015 6.01.2.009
- **Sulfonamidas:** Cotrimoxazol (Sulfametoxazol-Trimetoprima) y sulfadiazina.
- **Alopurinol:** Especialmente al iniciar dosis elevadas o en pacientes con insuficiencia renal crónica sin ajuste.
- **Anticonvulsivantes Aromáticos:** Carbamazepina, Fenitoína, Lamotrigina y Fenobarbital.
- **Oxicams / AINEs:** Piroxicam, meloxicam y metamizol.
- **Cefalosporinas y Penicilinas:** Antibióticos betalactámicos de uso masivo.

• **Período de Latencia:** Típicamente entre **1 a 4 semanas (promedio 7 a 21 días)** tras el inicio del fármaco culpable (nunca ocurre a las pocas horas ni después de años de tratamiento crónico ininterrumpido).

• **Patogenia Inmune:** Reconocimiento hapteno/péptido mediado por HLA específico (ej. HLA-B*1502 con carbamazepina en asiáticos; HLA-B*5801 con alopurinol). Los linfocitos T CD8+ clonales liberan **Granulisina** (la principal toxina inductora de apoptosis) junto con perforina y granzima B, desencadenando la muerte celular programada masiva de todo el estrato epidérmico.

2. CUADRO CLÍNICO, SIGNO DE NIKOLSKY Y ESPECTRO SSJ/NET

• **Pródromos (1 a 3 días antes):** Síndrome pseudogripal con fiebre alta (> 38.5 °C), malestar general, dolor faríngeo, tos y ardor ocular severo. 6.01.2.015 6.01.2.009

• **Lesiones Cutáneas Iniciales:** Máculas eritematosas o purpúricas de contorno irregular, confluentes, que evolucionan rápidamente a máculas con aspecto de "diana atípica" (solo 2 anillos concéntricos o centro purpúrico/ampollar, a diferencia de la diana clásica de 3 anillos del eritema multiforme). **El dolor cutáneo es intenso y desproporcionado a los hallazgos iniciales**.

• **Formación de Flictenas y Desprendimiento Epidérmico:** Las lesiones confluyen y se forman grandes ampollas flácidas que se rompen con facilidad, dejando la dermis denudada de color rojo vivo ("aspecto de escaldadura térmica").

• **SIGNO DE NIKOLSKY (+):** Al aplicar una suave fricción tangencial o deslizamiento digital sobre piel eritematosa o perilesional aparentemente intacta, **la epidermis se despega y desprende en sábana** revelando la dermis húmeda subyacente. También se presenta el *Signo de Asboe-Hansen* (al comprimir verticalmente el centro de una ampolla, esta se extiende lateralmente hacia piel sana).

• **Compromiso Severo de Mucosas (> 90% de los casos):**
- **Mucosa Oral y Labial:** Estomatitis hemorrágica masiva con queilitis costrosa sanguinolenta ("costras hemáticas gruesas en los labios"), odinofagia severa e imposibilidad de deglutir.
- **Mucosa Ocular:** Conjuntivitis pseudomembranosa bilateral severa, queratitis, ulceración corneal y riesgo crítico de **simblefaron** (sinequias cicatriciales conjuntivo-palpebrales) y ceguera.
- **Mucosa Urogenital:** Balanitis, vulvovaginitis erosiva y sinequias vaginales/uretrales. **(ver Imagen 16.9B)**

TABLA 16.9.A · CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DEL ESPECTRO SSJ / NET 6.01.2.015, 6.01.2.009, 6.01.2.014

PARÁMETRO	SÍNDROME DE STEVENS-JOHNSON (SSJ)	SUPERPOSICIÓN SSJ / NET	NECRÓLISIS EPIDÉRMICA TÓXICA (NET)
Porcentaje de BSA Desprendida	< 10% de la piel total	10% a 30% de la piel total	> 30% de la piel total (hasta > 80%)
Tipo de Lesión Cutánea	Máculas en dianas atípicas purpúricas y flictenas	Dianas atípicas confluentes con ampollas extensas	Desprendimiento en sábanas completas (escaldadura)
Compromiso de Mucosas	Grave (≥ 2 mucosas en > 95%)	Grave y constante (oral, genital, conjuntival)	Masivo y hemorrágico difuso con necrosis traqueobronquial
Signo de Nikolsky	Positivo (+) en áreas eritematosas	Positivo (+) ampliamente distribuido	Positivo (+) generalizado en casi toda la superficie
Mortalidad Estimada	1% a 5%	10% a 15%	30% a 50% (por sepsis y shock distributivo)

16.9. Reacciones Medicamentosas Graves: Stevens-Johnson (SSJ) y Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET) — Enfrentamiento Diagnóstico

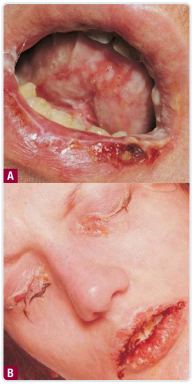
3. CLASIFICACIÓN SEGÚN PORCENTAJE DE SUPERFICIE CORPORAL TOTAL (BSA)

La distinción entre SSJ y NET es estrictamente cuantitativa y se basa en el porcentaje de **Superficie Corporal Total (BSA) con desprendimiento epidérmico franco** (empleando la regla de los nueve de Wallace o tabla de Lund-Browder): 6.01.2.015 6.01.2.009

1. **Síndrome de Stevens-Johnson (SSJ):** Desprendimiento epidérmico en **< 10%** de la superficie corporal total + compromiso de mucosas.
2. **Síndrome de Superposición SSJ / NET:** Desprendimiento epidérmico entre **10% y 30%** de la superficie corporal total.
3. **Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET o Síndrome de Lyell):** Desprendimiento epidérmico en **> 30%** de la superficie corporal total (con frecuencia llega al 70-90% de la piel). **(ver Imagen 16.9C)**



A. DIANAS ATÍPICAS



B. MUCOSA ORAL Y LABIOS



C. STEVENS-JOHNSON: LABIOS

Imagen 16.9

FIGURA 16.9 · ALGORITMO DE MANEJO DE EMERGENCIA EN SSJ Y NET

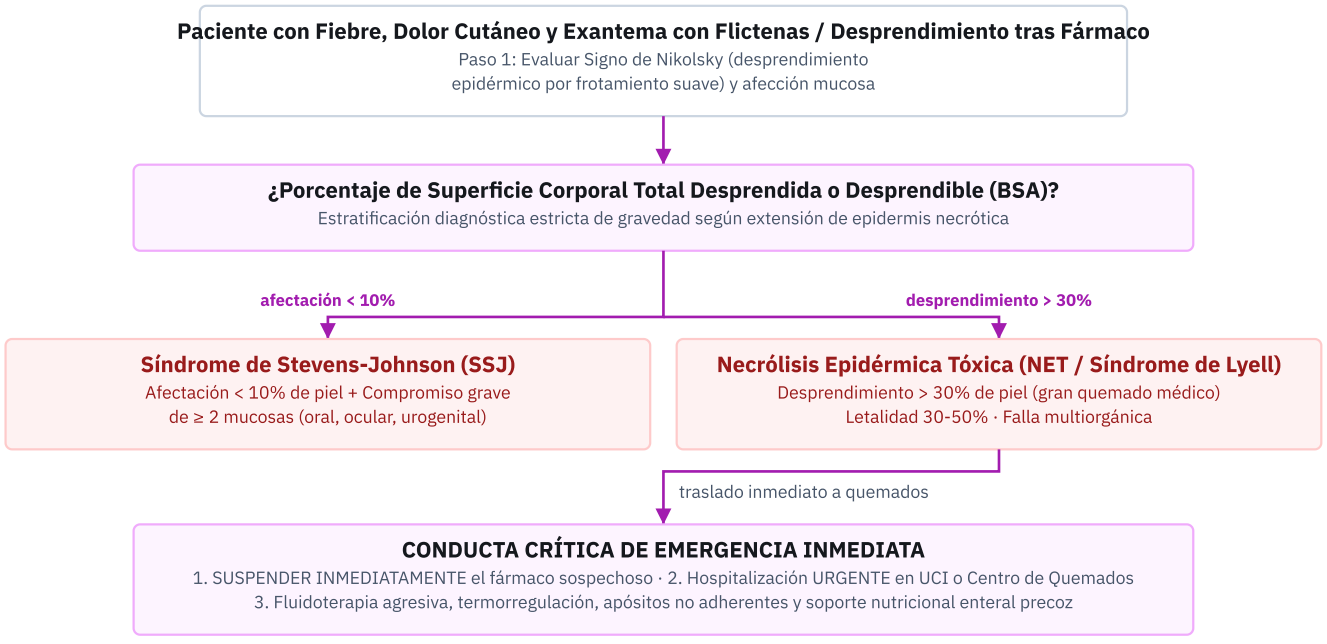


TABLA 16.9.B · SCORE PRONÓSTICO SCORTEN EN LAS PRIMERAS 48 HORAS DE HOSPITALIZACIÓN CRITERIOS DE GRAVEDAD

VARIABLE SCORTEN	PUNTO DE CORTE DE RIESGO (1 PUNTO)	FUNDAMENTO FISIOPATOLÓGICO	MORTALIDAD SEGÚN PUNTAJE ACUMULADO
1. Edad del Paciente	≥ 40 años	Menor reserva fisiológica y regeneración epitelial	0 a 1 punto: 3.2% de mortalidad
2. Frecuencia Cardíaca	≥ 120 latidos/minuto	Respuesta hiperadrenérgica y shock hipovolémico	2 puntos: 12.1% de mortalidad
3. Cáncer / Neoplasia	Presencia de malignidad previa activa	Inmunosupresión basal y caquexia tumoral	3 puntos: 35.3% de mortalidad
4. Extensión Desprendida	Superficie desprendida inicial > 10% BSA	Falla de barrera cutánea masiva y pérdida insensible	4 puntos: 58.3% de mortalidad
5. Nitrógeno Ureico / Urea	BUN > 28 mg/dL (o Urea sérica > 60 mg/dL)	Hipovolemia prerrenal severa y catabolismo proteico	≥ 5 puntos: > 90% de mortalidad (crítico)
6. Bicarbonato Sérico	Bicarbonato sérico < 20 mEq/L	Acidosis láctica por hipoperfusión tisular	—
7. Glicemia en Ayunas	Glicemia > 252 mg/dL (> 14 mmol/L)	Estrés metabólico hiperglucémico extremo	—

16.9. Reacciones Medicamentosas Graves: Stevens-Johnson (SSJ) y Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET) — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. ESCALA PRONÓSTICA SCORTEN Y ENFOQUE TERAPÉUTICO EN CENTRO DE QUEMADOS

• **Score Pronóstico SCORTEN (evaluado dentro de las primeras 24-48 horas):** 6.01.2.015 6.01.2.009

Consta de 7 variables independientes (1 punto cada una). A mayor puntaje, mayor mortalidad:

1. Edad ≥ 40 años.
2. Frecuencia cardíaca ≥ 120 latidos por minuto.
3. Presencia de cáncer activo o neoplasia hematológica.
4. Superficie corporal desprendida inicial > 10% de BSA.
5. Nitrógeno ureico en sangre (BUN) > 28 mg/dL (> 10 mmol/L) o Urea > 60 mg/dL.
6. Bicarbonato sérico < 20 mEq/L (acidosis metabólica).
7. Glicemia en ayunas > 252 mg/dL (> 14 mmol/L).

Mortalidad esperada: 0-1 puntos: ~3%; 2 puntos: ~12%; 3 puntos: ~35%; 4 puntos: ~58%; ≥ 5 puntos: > 90%.

• **Pilares Terapéuticos Fundamentales:**

1. **Retiro Inmediato del Fármaco Causal:** Es la medida que más impacta en la sobrevida. Cuanto más corta la vida media del fármaco y más precoz su suspensión, menor es la mortalidad.
2. **Traslado Urgente a Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) o Centro de Gran Quemado:** Requiere aislamiento térmico ambiental (temperatura ambiente controlada a 30-32 °C para evitar la hipotermia severa por evaporación cutánea masiva).
3. **Fluidoterapia Intravenosa Agresiva:** Reposición hidroelectrolítica calculada similar a quemaduras pero reduciendo un 25-30% el volumen de Parkland para evitar sobrecarga y edema pulmonar.
4. **Cuidado Tópico de la Piel:** Asepsia estricta, NUNCA desbridar quirúrgicamente las flictenas ni despegar la epidermis necrótica (la piel desprendida actúa como apósito biológico natural); aplicar gasas vaselinadas no adherentes o apósitos de plata nanocristalina.
5. **Interconsulta Oftalmológica de Emergencia:** Aseo ocular continuo, lágrimas artificiales sin conservantes cada 1-2 horas y desbridamiento manual de sinequias conjuntivales diariamente para prevenir simbléfaron y perforación corneal.

5. SÍNDROME DE PIEL ESCALDADA POR ESTAFILOCOCOS (SSSS)

El **síndrome de piel escaldada por estafilococos** es producido por las **toxinas exfoliativas A y B de Staphylococcus aureus**, que cortan la desmogleína 1 en el estrato granuloso: el clivaje es **muy superficial** y forma ampollas flácidas que se rompen con facilidad. Afecta a **recién nacidos y niños menores de 5 a 6 años**, por inmadurez de la depuración renal de la toxina y falta de anticuerpos; en adultos solo aparece con insuficiencia renal o inmunosupresión. Hay un foco infeccioso distante (conjuntivitis, impétigo, onfalitis, otitis, rinofaringitis) y luego fiebre, irritabilidad y **dolor cutáneo** con eritema escarlatiniforme en cara, cuello, axilas e ingles; después aparecen ampollas flácidas que dejan erosiones húmedas «escaldadas», **costras radiadas periorificiales** y **signo de Nikolsky positivo**. La diferencia clave con el Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica es que **las mucosas están respetadas**, no hay dianas atípicas, la lesión es más superficial y cura en 5 a 7 días sin cicatriz. Los cultivos de las ampollas son estériles (la toxina circula); el cultivo se toma del foco primario (nariz, conjuntiva, ombligo, lesión). Se diferencia además del impétigo ampolloso (localizado, ampollas con bacterias) y de las quemaduras por escaldadura. **(ver Imagen 16.9A)**



Síndrome de piel escaldada por estafilococos en un niño de 6 años: signo de Nikolsky, con separación de la epidermis superficial

Conducta (sospecha, tratamiento inicial). Ante la sospecha en un lactante o preescolar se **hospitaliza**: antibiótico antiestafilocócico endovenoso (cloxacilina; vancomicina si hay sospecha de SARM), a veces asociado a clindamicina para frenar la síntesis de toxina, analgesia, hidratación y control de la temperatura, y curaciones como en un quemado superficial, con emolientes y apósitos no adhesivos. **Se evitan corticoides y AINE.** El pronóstico en niños es excelente (mortalidad menor del 5%), a diferencia de los adultos, en quienes es grave. No requiere seguimiento posterior, pero sí se trata el foco primario y a los portadores del grupo familiar cuando hay brotes en salas cuna o neonatología.

TABLA 16.9.C · PROTOCOLO TERAPÉUTICO Y SOPORTE VITAL EN CENTRO DE QUEMADOS — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

EJE DE MANEJO	INTERVENCIÓN DE EMERGENCIA	OBJETIVO TERAPÉUTICO	ERROR CRÍTICO A EVITAR
1. Etiológico	Suspensión inmediata de todo fármaco introducido en últimas 8 semanas	Detener la cascada de apoptosis epidérmica por linfocitos CD8+	NUNCA demorar el retiro buscando exámenes confirmatorios
2. Soporte Hemodinámico	Fluidoterapia balanceada (Ringer Lactato ~2 mL/kg/%BSA en 24 h)	Mantener diuresis > 0.5-1 mL/kg/h y presión arterial media > 65 mmHg	NO sobrehidratar (riesgo de edema pulmonar y dificultad respiratoria)
3. Termorregulación	Sala térmica calefaccionada a 30 °C - 32 °C y mantas térmicas	Evitar hipotermia grave por pérdida calórica masiva transcutánea	NO dejar al paciente expuesto a temperatura ambiente estándar
4. Cuidado de la Piel	Apósitos no adherentes de vaselina o plata, aseo suave con clorhexidina 0.05%	Proteger la dermis denudada sin despegar la epidermis residual	PROHIBIDO el desbridamiento quirúrgico mecánico agresivo
5. Prevención Ocular	Lavado ocular salino cada hora + lágrimas artificiales + lisis de sinequias	Evitar formación de simbléfaron, queratinización conjuntival y ceguera	NO diferir la evaluación por oftalmólogo desde el día 1
6. Terapia Inmunomoduladora	Ciclosporina A oral (3-5 mg/kg/día) o Inmunoglobulina Humana IV (IGIV 1 g/kg/d x 3 d)	Neutralizar Granulisina y detener apoptosis en centros especializados	Uso rutinario de corticoides sistémicos a dosis altas es controvertido por sepsis

16.9. Reacciones Medicamentosas Graves: Stevens-Johnson (SSJ) y Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET) — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (REACCIONES MEDICAMENTOSAS GRAVES)

- Los fármacos gatillantes más frecuentes son Alopurinol, Carbamazepina, Cotrimoxazol y AINEs.
- El Signo de Nikolsky (+) es el desprendimiento de la epidermis por fricción suave sobre piel eritematosa.
- El score SCORTEN (7 parámetros dentro de las primeras 48 h) estima con precisión la mortalidad.
- El manejo debe realizarse en UCI o Centro de Quemados con soporte hidroelectrolítico y control térmico estricto.
- El período de latencia típico es de 1 a 4 semanas tras el inicio del fármaco culpable.
- Clasificación por superficie corporal desprendida: SSJ < 10%; Superposición SSJ/NET 10-30%; NET > 30%.
- La medida de mayor impacto en la sobrevida es el RETIRO INMEDIATO del fármaco sospechoso.
- El compromiso ocular exige evaluación precoz para evitar sinequias conjuntivales (simbléfaron) y ceguera.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

16.9

Hombre de 54 años, con antecedente de gota tofácea que inició alopurinol 300 mg/día hace 3 semanas, consulta en urgencias por cuadro de 4 días de fiebre alta (39 °C), malestar general, dolor faríngeo intenso y ardor en ambos ojos. Al examen físico destaca paciente en malas condiciones generales, taquicárdico a 125 lpm, con eritema confluente extenso en tronco y extremidades asociado a flictenas y desprendimiento epidérmico que compromete el 35% de la superficie corporal total. Al frotar suavemente la piel perilesional eritematosa con el pulpejo del dedo, la epidermis se desprende con extrema facilidad dejando una superficie denudada y sangrante. Presenta labios cubiertos por gruesas costras hemáticas e inyección conjuntival bilateral con exudado purulento.

Conducta oficial razonada. El cuadro clínico corresponde a una Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET o síndrome de Lyell) secundaria al uso reciente de alopurinol. El hallazgo de desprendimiento epidérmico en el 35% de la superficie corporal total (> 30%) clasifica de inmediato el cuadro como NET. El desprendimiento epidérmico ante la fricción digital tangencial corresponde al Signo de Nikolsky positivo, confirmando la necrosis epidérmica de espesor total por lisis mediada por granulisina y linfocitos T. La conducta inmediata mandatoria es la suspensión inmediata del alopurinol, el ingreso urgente a una Unidad de Cuidados Intensivos o Centro de Quemados para manejo hidroelectrolítico y de soporte de barrera, y la interconsulta oftalmológica precoz para prevenir simbléfaron.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 16.9 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.2.009

1. Una mujer de 38 años consulta en urgencias por un cuadro febril de 48 horas de evolución acompañado de odinofagia intensa y ardor ocular. Al examen físico presenta lesiones eritematosas en diana atípica en tronco, con flictenas y desprendimiento de la piel que compromete aproximadamente el 7% de la superficie corporal total, asociado a úlceras orales con costras hemáticas labiales y conjuntivitis bilateral. Al realizar una suave presión tangencial con el dedo sobre la piel eritematosa, la epidermis se desliza y desprende. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el signo semiológico descrito?

A) Eritema multiforme menor y Signo de Darier
B) Síndrome de Stevens-Johnson y Signo de Nikolsky
C) Necrólisis epidérmica tóxica y Fenómeno de Koebner
D) Penfigoide ampollar y Signo de Auspitz
E) Síndrome DRESS y Fenómeno de Patergia

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.2.009

2. ¿Cuál es el porcentaje de superficie corporal total (BSA) desprendida que define y distingue formalmente a la Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET) del Síndrome de Stevens-Johnson (SSJ)?

A) Mayor al 5% de superficie corporal total
B) Mayor al 10% de superficie corporal total
C) Mayor al 20% de superficie corporal total
D) Mayor al 30% de superficie corporal total
E) Mayor al 50% de superficie corporal total

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.2.009

3. Un hombre de 62 años es hospitalizado por una Necrólisis Epidérmica Tóxica que compromete el 45% de la superficie corporal tras iniciar carbamazepina hace dos semanas. Al ingreso a la unidad de pacientes críticos se calculan los parámetros de la escala pronóstica SCORTEN. ¿Cuál de los siguientes hallazgos aporta UN PUNTO de gravedad en dicha escala?

A) Frecuencia cardíaca de 95 latidos por minuto
B) Edad de 35 años
C) Bicarbonato sérico de 16 mEq/L
D) Glicemia en ayunas de 140 mg/dL
E) Nitrógeno ureico en sangre (BUN) de 15 mg/dL

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.2.009

4. En el manejo hospitalario de un paciente diagnosticado con Necrólisis Epidérmica Tóxica severa en un Centro de Quemados, ¿cuál de las siguientes intervenciones representa una MALA PRÁCTICA contraindicada?

A) Mantener la temperatura ambiental de la sala entre 30 °C y 32 °C
B) Desbridamiento quirúrgico agresivo en pabellón de toda la epidermis desprendida y flictenas
C) Instilación frecuente de lágrimas artificiales sin preservantes y evaluación diaria por oftalmología
D) Reposición hídrica intravenosa guiada por diuresis horaria estricta
E) Suspensión inmediata de todos los fármacos no vitales introducidos en las semanas previas

Más preguntas online de Reacciones Medicamentosas Graves →

16.10. Síndrome DRESS: Erupción Medicamentosa con Eosinofilia y Síntomas Sistémicos

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 6.01.2.013 6.01.1.025

¿POR QUÉ?

El Síndrome DRESS (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms o Síndrome de Hipersensibilidad Inducida por Fármacos - DIHS) es una reacción de hipersensibilidad retardada potencialmente letal (mortalidad del 5-10%). Su patogenia combina una respuesta inmune mediada por linfocitos T específicos antígeno-fármaco junto con la reactivación masiva de virus de la familia Herpesviridae (particularmente Herpesvirus Humano tipo 6 - HHV-6, HHV-7 y Virus de Epstein-Barr). Se distingue clínicamente por una latencia muy prolongada (de 2 a 8 semanas tras iniciar el fármaco), la presencia de edema facial prominente, fiebre alta, eosinofilia marcada y daño visceral grave, principalmente hepatitis tóxica.

1. FÁRMACOS IMPLICADOS Y MECANISMO DE HIPERSENSIBILIDAD RETARDADA

• **Fármacos Típicamente Responsables:** 6.01.2.013

- **Anticonvulsivantes Aromáticos (los más frecuentes, > 50% de casos):** 6.01.1.025 Carbamazepina, Fenitoína, Fenobarbital y Lamotrigina.
- **Alopurinol:** Frecuente en pacientes ancianos o con insuficiencia renal.
- **Sulfonamidas y Sulfonas:** Cotrimoxazol, Sulfasalazina y Dapsona (Síndrome por Dapsona).
- **Antibióticos y Antivirales:** Vancomicina, Minociclina, Nevirapina y Abacavir.

• **Período de Latencia Característico (CLAVE DE EXAMEN):** A diferencia de las urticarias (minutos a horas) o del SSJ (1 a 3 semanas), el DRESS tiene una **latencia prolongada y traicionera de 2 a 8 semanas (habitualmente 3 a 6 semanas)**. Con frecuencia el paciente olvida mencionar el medicamento porque lo viene tomando desde hace un mes.

• **Reactivación Viral de Herpesvirus 6 (HHV-6):** La interacción fármaco-linfocito T provoca una inmunodepresión transitoria que reactiva el virus herpes humano 6 latente, perpetuando la inflamación y las recaídas tardías semanas después de retirar el medicamento.

2. TRÍADA CLÍNICA CLÁSICA Y CRITERIOS REGISCAR

• **1. Fiebre Alta Persistente (> 38.5 °C):** Presente en más del 90% de los casos, suele ser el primer síntoma y se acompaña de compromiso del estado general y postración. 6.01.2.013 6.01.1.025

• **2. Erupción Cutánea Polimorfa con Edema Facial:**

- Comienza como un exantema morbiliforme o maculopapular eritematoso difuso en cara, tronco superior y extremidades que confluye en un eritema generalizado.
- **EDEMA FACIAL PERIORBITARIO Y MALAR PROMINENTE:** Es el hallazgo semiológico cardinal más orientador en la inspección física (presente en > 75% de los pacientes).
- A diferencia de SSJ/NET, en el DRESS **NO suele haber flictenas ni desprendimiento epidérmico difuso**, y el Signo de Nikolsky es TÍPICAMENTE NEGATIVO.

• **3. Linfadenopatías Generalizadas:** Ganglios dolorosos palpables ≥ 1 cm en dos o más cadenas linfáticas (cervicales, axilares, inguinales).

• **Criterios Diagnósticos Internacionales RegiSCAR (Score ≥ 4 confirma DRESS):**

1. Erupción cutánea aguda que compromete > 50% de la superficie corporal.
2. Fiebre superior a 38.5 °C.
3. Linfadenopatías en al menos dos territorios ganglionares anatómicos.
4. Compromiso de al menos un órgano interno.
5. Anormalidades hematológicas: **Eosinofilia (≥ 700/uL o ≥ 10%)** o presencia de **Linfocitos Atípicos** en sangre periférica.
6. Curso clínico prolongado (> 15 días tras retirar el fármaco) y exclusión de causas infecciosas primarias. **(ver Imagen 16.10A, B y C)**

TABLA 16.10.A · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: DRESS VS SÍNDROME DE STEVENS-JOHNSON / NET 6.01.2.013, 6.01.1.025

CARACTERÍSTICA CLÍNICA	SÍNDROME DRESS	SÍNDROME DE STEVENS-JOHNSON / NET
Período de Latencia Farmacológica	Muy prolongado: 2 a 8 semanas (habitual 3-6 sem)	Intermedio: 1 a 3 semanas (7 a 21 días)
Lesión Cutánea Predominante	Exantema morbiliforme confluente + Edema facial intenso	Máculas en diana atípica + Flictenas y ampollas flácidas
Signo de Nikolsky	Negativo (-) habitualmente	Positivo (+) patognomónico
Desprendimiento Epidérmico	Ausente o solo descamación tardía laminar	Presente y extenso (> 10% a > 30% de la piel)
Compromiso de Mucosas	Ausente o leve queilitis (labios secos)	Severo y hemorrágico (≥ 2 mucosas en > 90%)
Hallazgo Hematológico Clave	Eosinofilia marcada (≥ 700-1500/uL) + Linfocitos atípicos	Neutropenia o leucopenia de mal pronóstico
Órgano Blanco Principal	Hígado (hepatitis en 80-90%), Riñón y Miocardio	Piel (gran quemado) y mucosa respiratoria/ocular
Tratamiento Específico	Corticoides sistémicos orales en retiro muy lento (2-3 meses)	Manejo en Centro de Quemados / Soporte hidroelectrolítico

16.10. Síndrome DRESS: Erupción Medicamentosa con Eosinofilia y Síntomas Sistémicos — Enfrentamiento Diagnóstico

3. COMPROMISO DE ÓRGANOS INTERNOS (FALLA VISCERAL)

La morbimortalidad del síndrome DRESS depende exclusivamente de la gravedad del daño en los órganos internos: 6.01.2.013

• **Hígado (el órgano blanco más frecuentemente afectado, 75% a 90% de casos):** Hepatitis tóxica que varía desde elevación asintomática de transaminasas (GOT/GPT > 2 a 5 veces el límite superior normal) y colestasis, hasta necrosis hepática masiva e insuficiencia hepática aguda fulminante (principal causa de muerte).

• **Riñón (15% a 30% de casos):** Nefritis tubulointersticial aguda con elevación de creatinina, proteinuria y hematuria microscópica (particularmente frecuente tras alopurinol).

• **Corazón (Miocarditis por Hipersensibilidad, 5% a 10%):** Cuadro muy grave y traicionero que puede debutar semanas después con disnea, arritmias ventriculares, elevación de troponinas y shock cardiogénico.

• **Pulmón (10% a 15%):** Neumonitis intersticial con infiltrados bilaterales y disnea progresiva.



A. EXANTEMA DEL TRONCO **B.** EDEMA FACIAL **C.** EXANTEMA MORBILIFORME

Imagen 16.10

FIGURA 16.10 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DEL SÍNDROME DRESS

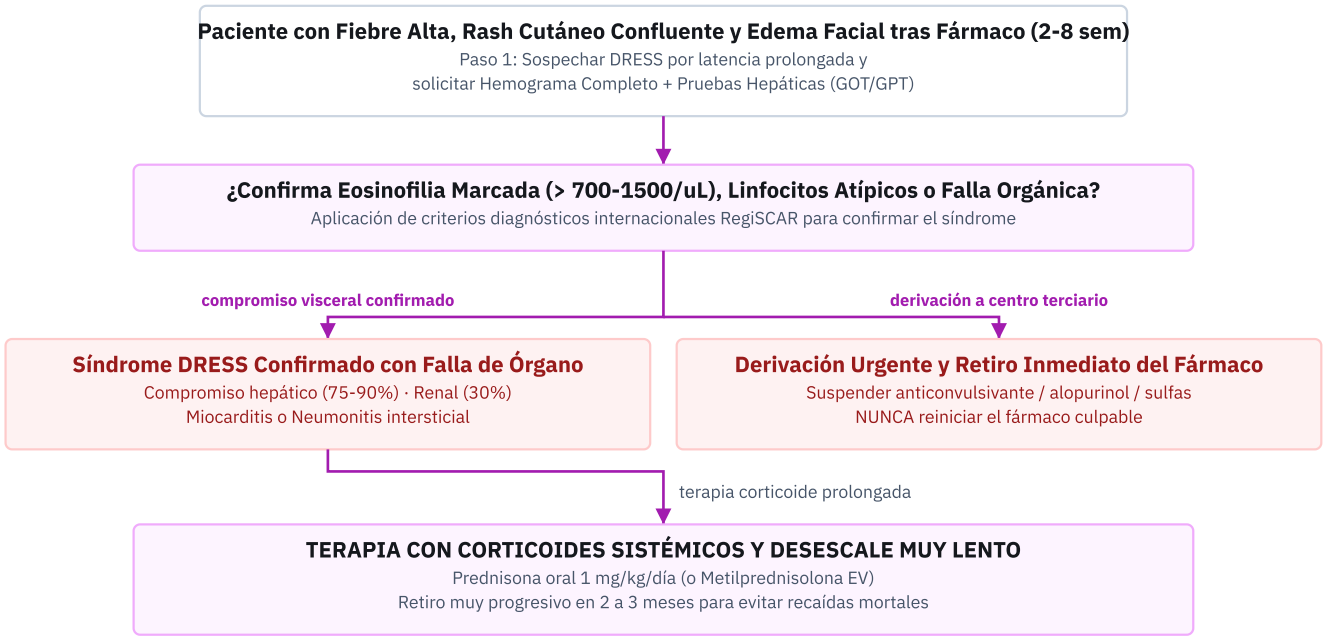


TABLA 16.10.B · CRITERIOS REGISCAR PARA DIAGNÓSTICO Y CLASIFICACIÓN DE GRAVEDAD EN DRESS CRITERIOS DE GRAVEDAD

CRITERIO REGISCAR	HALLAZGO REQUERIDO	PUNTAJE	CATEGORÍA DIAGNÓSTICA
Fiebre	Temperatura corporal > 38.5 °C	+1	Score < 2: No es DRESS
Linfadenopatías	Cadenas ganglionares palpables ≥ 2 sitios (≥ 1 cm)	+1	Score 2 a 3: Caso Posible
Eosinofilia	Eosinófilos 700 a 1499/uL (+1) o ≥ 1500/uL (+2)	+1 o +2	Score 4 a 5: Caso Probable
Linfocitos Atípicos	Presencia documentada en frotis sanguíneo	+1	Score ≥ 6: Caso Definitivo
Exantema Cutáneo	Extensión > 50% de BSA (+1) y edema facial/infiltrado (+1)	+1 a +2	—
Daño de Órgano	Compromiso de 1 órgano (+1) o ≥ 2 órganos internos (+2)	+1 a +2	—
Biopsia Cutánea	Infiltrado compatible sin otra causa explicable	+1	—

16.10. Síndrome DRESS: Erupción Medicamentosa con Eosinofilia y Síntomas Sistémicos — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. TRATAMIENTO: SUSPENSIÓN PRECOZ Y CORTICOIDES SISTÉMICOS PROLONGADOS

• **Medida Inmediata y Esencial: RETIRAR INMEDIATAMENTE EL FÁRMACO CULPABLE**. Registrar la alergia de forma indeleble en la ficha clínica (advertir riesgo de reactividad cruzada entre anticonvulsivantes aromáticos: si hizo DRESS por carbamazepina, tiene prohibida la fenitoína y fenobarbital). 6.01.2.013 6.01.1.025

• **Terapia Farmacológica de Elección: CORTICOIDES SISTÉMICOS:**

- En pacientes con compromiso de órganos internos o eosinofilia severa: **Prednisona oral a dosis de 0.5 a 1.0 mg/kg/día** (o pulsos de Metilprednisolona endovenosa 1 g/día por 3 días si hay hepatitis grave o miocarditis).

- **REGLA DE ORO DE DESCONTINUACIÓN:** La reducción de la dosis de corticoides debe ser **EXTREMADAMENTE LENTA Y PROGRESIVA, A LO LARGO DE 2 A 3 MESES (8 a 12 semanas)**. La suspensión rápida antes de las 4 semanas produce recaídas inflamatorias graves o empeoramiento fulminante de la hepatitis.

- En casos refractarios a corticoides: Se puede asociar Inmunoglobulina intravenosa (IGIV) o Ciclosporina A oral.

5. EXANTEMA MEDICAMENTOSO SIMPLE Y TOXIDERMIA FIJA

Exantema morbiliforme (maculopapular) por fármacos. Es la reacción cutánea medicamentosa más frecuente. Aparece **4 a 14 días después de iniciado el fármaco** (más rápido si hubo exposición previa), con máculas y pápulas rojas, pruriginosas y simétricas que comienzan en el tronco y se extienden a las extremidades, sin fiebre alta, sin edema facial, sin compromiso de mucosas ni de órganos. Los agentes más frecuentes son aminopenicilinas (la amoxicilina en un paciente con mononucleosis infecciosa produce exantema casi siempre, sin que signifique alergia verdadera), sulfonamidas, alopurinol y anticonvulsivantes. Se debe distinguir del exantema viral y reconocer los **signos de alarma** que hacen sospechar DRESS o Stevens-Johnson: fiebre alta, edema facial, lesiones dolorosas, ampollas, erosiones de mucosas, dianas atípicas, eosinofilia o alteración hepática. Manejo: **suspender el fármaco sospechoso** (si es imprescindible y el cuadro es leve puede mantenerse bajo vigilancia estrecha), antihistamínicos y corticoide tópico de potencia media, control a las 48 a 72 horas para detectar progresión, y registro de la sospecha en la ficha. Se resuelve en 1 a 2 semanas con descamación fina.

Toxidermia fija. Es una placa eritematovioláceo, redonda u oval, bien delimitada, a veces con una ampolla central, **única o escasa, que reaparece siempre en el mismo sitio cada vez que se expone al fármaco** y deja una **mancha residual hiperpigmentada gris parda**. Aparece entre 30 minutos y 8 horas después de tomar el medicamento y prefiere labios, cara, manos y genitales (en el glande produce erosiones dolorosas). Las causas más frecuentes son AINE, cotrimoxazol y otras sulfas, tetraciclinas, paracetamol, barbitúricos, carbamazepina y fluconazol. El diagnóstico es clínico con una buena historia de fármacos; la biopsia se reserva para las dudas. Tratamiento inicial: **suspender y evitar el fármaco**, corticoide tópico potente por pocos días, curación de las erosiones y dejar anotado el agente causante. La forma ampollosa generalizada con más del 10% de superficie se maneja como necrólisis epidérmica tóxica.



Toxidermia fija

TABLA 16.10.C · ESQUEMA DE TRATAMIENTO Y MONITORIZACIÓN EN SÍNDROME DRESS — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

FASE TERAPÉUTICA	INTERVENCIÓN Y FÁRMACO	DOSIS / DURACIÓN	MONITORIZACIÓN DE SEGURIDAD
1. Retiro de Culpable	Suspensión inmediata de anticonvulsivantes, alopurinol o sulfas	Inmediato (día 0)	Evitar reactividad cruzada con otros anticonvulsivantes aromáticos
2. Corticoterapia Inducción	Prednisona oral (o Metilprednisolona EV si hay falla hepática)	0.5 a 1.0 mg/kg/día por vía oral (o pulsos EV 1 g/d x 3 d)	Control de presión arterial, hemoglucotest y profilaxis con IBP
3. Desescalamiento Lento	Descenso paulatino bisemanal de la dosis de prednisona	Disminución progresiva a lo largo de 8 a 12 semanas (2-3 meses)	Monitorear reaparición de fiebre o eosinofilia por rebote
4. Control Paraclínico	Perfil hepático (GOT/GPT/FA/Bilirrubina), Creatinina y Hemograma	Semanal durante el primer mes, luego cada 2 semanas	Descartar hepatitis fulminante o nefritis intersticial aguda
5. Seguimiento Tardío	Evaluación tiroidea (TSH y T4 libre) a los 2 y 6 meses	Tamizaje de tiroiditis autoinmune post-DRESS	Pesquisar fenómenos autoinmunes tardíos post-reactivación viral

16.10. Síndrome DRESS: Erupción Medicamentosa con Eosinofilia y Síntomas Sistémicos — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (SÍNDROME DRESS)

- El DRESS tiene una latencia prolongada y característica de 2 a 8 semanas tras iniciar el fármaco.
- La tríada cardinal es: Fiebre alta + Rash confluente con Edema Facial + Linfadenopatías.
- El órgano interno más afectado es el hígado (hepatitis tóxica en 75-90% de los pacientes).
- El tratamiento de elección es la Prednisona oral (1 mg/kg/día) con desescalamiento muy lento (2-3 meses).
- Los fármacos causales más comunes son Carbamazepina, Fenitoína, Fenobarbital y Alopurinol.
- En el laboratorio destaca eosinofilia marcada (> 700-1500/uL) y presencia de linfocitos atípicos.
- A diferencia de SSJ/NET, el signo de Nikolsky es negativo y no hay desprendimiento epidérmico difuso.
- Existe reactivación de Herpesvirus humano tipo 6 (HHV-6) que explica las recaídas tardías.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

16.10

Mujer de 48 años con antecedente de neuralgia del trigémino que inició carbamazepina hace 4 semanas. Consulta en el servicio de urgencias por fiebre alta de 39 °C de 5 días de evolución, astenia intensa y aparición de una erupción cutánea pruriginosa. Al examen físico destaca paciente febril, con notable edema periorbitario y facial simétrico, asociado a un exantema eritematoso maculopapular confluente que cubre la cara, tronco y más del 60% de la superficie corporal, sin flictenas ni desprendimiento epidérmico (Nikolsky negativo). Se palpan adenopatías cervicales anteriores y axilares de 1.5 cm, sensibles. Los exámenes de laboratorio revelan: Leucocitos 18.500/uL con 18% de eosinófilos (recuento absoluto 3.330/uL), presencia de linfocitos reactivos atípicos en el frotis, GOT 320 U/L (VN < 35), GPT 410 U/L (VN < 35) y Creatinina 1.1 mg/dL.

Conducta oficial razonada. El cuadro clínico es clásico de un Síndrome DRESS (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms) secundario a carbamazepina. Los elementos definitorios son: 1) Período de latencia prolongado de 4 semanas; 2) Fiebre persistente y adenopatías múltiples; 3) Exantema eritematoso confluente con edema facial característico y Nikolsky negativo; 4) Marcada eosinofilia periférica (> 1.500/uL) y presencia de linfocitos atípicos; 5) Compromiso visceral evidenciado por hepatitis tóxica (transaminasas > 10 veces el valor normal). El score RegiSCAR es ≥ 6 (caso definitivo). La conducta inmediata es la suspensión absoluta y definitiva de la carbamazepina y el inicio de corticoterapia sistémica (prednisona 1 mg/kg/día) con un retiro muy gradual en 2 a 3 meses para evitar recaídas y falla hepática.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 16.10 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.2.013

1. Un hombre de 55 años inició tratamiento con alopurinol 300 mg/día hace un mes por gota tofácea. Consulta por fiebre de 39 °C, malestar general y un exantema eritematoso difuso confluente en tronco y extremidades, acompañado de evidente edema periorbitario y en mejillas. Al examen no se observan ampollas ni desprendimiento cutáneo. En el hemograma destaca leucocitosis de 16.000/uL con 2.100 eosinófilos/uL y linfocitos atípicos. El perfil hepático muestra GOT 280 U/L y GPT 340 U/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Síndrome de Stevens-Johnson
B) Síndrome DRESS
C) Psoriasis eritrodérmica
D) Urticaria aguda alérgica
E) Enfermedad del suero

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.2.013

2. ¿Cuál es el período de latencia típico característico que transcurre entre el inicio del medicamento causal y la aparición de las manifestaciones clínicas del Síndrome DRESS?

A) Menos de 24 a 48 horas
B) De 3 a 5 días
C) De 2 a 8 semanas
D) De 6 a 12 meses
E) Más de 2 años de uso ininterrumpido

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.2.013

3. ¿Cuál es el órgano interno que se compromete con mayor frecuencia en los pacientes con Síndrome DRESS y cuya afectación condiciona la principal causa de mortalidad?

A) Riñón (glomerulonefritis membranosa)
B) Hígado (hepatitis tóxica / necrosis hepática)
C) Pulmón (derrame pleural hemorrágico)
D) Páncreas (pancreatitis aguda necrotizante)
E) Sistema nervioso central (meningoencefalitis aséptica)

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.2.013

4. Una mujer de 32 años es diagnosticada de Síndrome DRESS secundario a fenitoína con compromiso hepático moderado (GPT 380 U/L). Se suspende el fármaco culpable y se inicia prednisona oral a 1 mg/kg/día con excelente mejoría clínica y paraclínica a las dos semanas. Respecto al plan de retiro de la corticoterapia, ¿cuál es la conducta más adecuada?

A) Suspender de inmediato la prednisona ya que los exámenes se han normalizado
B) Reducir la dosis rápidamente para suspenderla en un plazo de 3 a 5 días
C) Disminuir la dosis de prednisona de manera muy lenta y progresiva a lo largo de 2 a 3 meses
D) Mantener la dosis plena de 1 mg/kg/día de por vida para evitar reactivación de la epilepsia
E) Cambiar a hidrocortisona tópica en crema y suspender la vía oral

Más preguntas online de Síndrome DRESS →

16.11. Pénfigo Vulgar (Intraepidérmico) vs Penfigoide Ampollar (Subepidérmico)

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 6.01.2.010 6.01.1.020 6.01.5.001

¿POR QUÉ?

Las enfermedades ampollares autoinmunes representan un clásico evaluado año a año en el examen EUNACOM. La distinción cardinal se establece entre el Pénfigo Vulgar (patología intraepidérmica con acantolisis mediada por autoanticuerpos dirigidos contra desmogleínas desmosómicas) y el Penfigoide Ampollar (patología subepidérmica mediada por autoanticuerpos contra proteínas hemidesmosómicas de la membrana basal: BP180 y BP230). El reconocimiento de las diferencias clínicas (flácida vs tensa, Nikolsky positivo vs negativo, afectación mucosa oral vs indemnidad de mucosas) y de la inmunofluorescencia directa permite responder con total certeza cualquier pregunta del examen.

1. PÉNFIGO VULGAR: FISIOPATOLOGÍA, AUTOANTÍGENOS Y NIVEL DE CLIVAJE

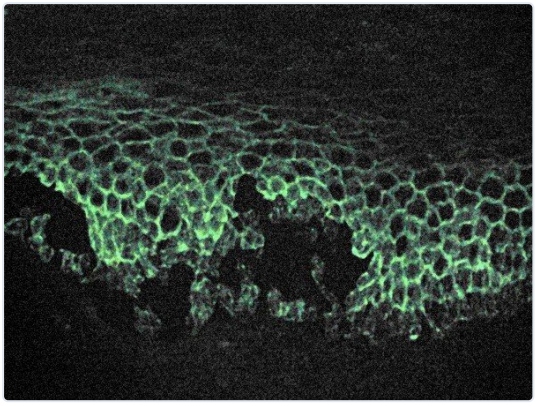
6.01.2.010 6.01.1.020

• **Mecanismo Inmune:** Es una enfermedad autoinmune potencialmente mortal causada por **autoanticuerpos IgG circulantes dirigidos contra la Desmogleína 3 (Dsg3)** —responsable de la adhesión queratinocítica suprabasal en mucosas— y secundariamente contra la **Desmogleína 1 (Dsg1)** en piel.

• **Fenómeno de Acantolisis:** La unión del anticuerpo a las desmogleínas rompe los desmosomas (complejos de unión intercelular entre queratinocitos), provocando la pérdida de cohesión intercelular (acantolisis).

• **Nivel Histopatológico de la Ampolla: AMPOLLA INTRAEPIDÉRMICA SUPRABASAL**. El techo de la ampolla está formado por las capas superiores de la epidermis y el piso por la monocapa de células basales ancladas a la lámina basal (aspecto de "hilera de lápidas sepulcrales").

• **Inmunofluorescencia Directa (IFD):** Depósito intercelular intraepidérmico de **IgG y C3 con patrón en "malla", "red de pescar" o "panal de abejas"** alrededor de los queratinocitos.



IFD de pénfigo vulgar

2. SEMIOLOGÍA Y CUADRO CLÍNICO DEL PÉNFIGO VULGAR

6.01.2.010 6.01.1.020

• **Población Típica:** Adultos entre los **40 y 60 años**, sin predominio marcado de sexo.

• **Compromiso de Mucosa Oral (HALLAZGO INAUGURAL EN 70-90% DE CASOS):**
El paciente debuta meses antes con erosiones y úlceras orales muy dolorosas en paladar blando, mucosa yugal y encías que tardan semanas en sanar y dificultan la alimentación. Es excepcional observar ampollas intactas en la boca debido al roce constante que las deseca de inmediato.

• **Lesiones Cutáneas:**
- **AMPOLLAS FLÁCIDAS, DE TECHO MUY DELGADO Y FRÁGIL**, que surgen sobre piel aparentemente sana o ligeramente eritematosa.
- Por ser de techo tan fino, **se rompen con extrema facilidad al menor roce**, dejando grandes erosiones y costras denudadas muy dolorosas que sangran y no cicatrizan espontáneamente.
- **SIGNO DE NIKOLSKY POSITIVO (+):** Al frotar suavemente con el pulgar la piel aparentemente sana perilesional, la epidermis superior se desprende en bloque.
- **Signo de Asboe-Hansen (+):** La compresión vertical del techo de una ampolla intacta extiende el líquido lateralmente despegando la piel vecina. **(ver Imagen 16.11A)**

TABLA 16.11.A · TABLA COMPARATIVA CLAVE EUNACOM: PÉNFIGO VULGAR VS PENFIGOIDE AMPOLLAR 6.01.2.010, 6.01.1.020, 6.01.5.001

PARÁMETRO	PÉNFIGO VULGAR	PENFIGOIDE AMPOLLAR
Grupo Etario Típico	Adultos de 40 a 60 años	Adultos mayores / Ancianos (> 70-80 años)
Autoantígenos Diana	Desmogleína 3 (mucosa) y Desmogleína 1 (piel)	BP180 (colágeno XVII) y BP230 (hemidesmosomas)
Estructura Afectada	Desmosomas (unión célula-célula)	Hemidesmosomas (unión epidermis-dermis)
Nivel Histológico de la Ampolla	Intraepidérmica suprabasal (con acantolisis)	Subepidérmica (techo epidérmico completo íntegro)
Morfología de la Ampolla	Flácida, pared muy delgada, se rompe rápido	Tensa, pared gruesa resistente, permanece días
Signo de Nikolsky	Positivo (+)	Negativo (-)
Afectación de Mucosa Oral	Muy frecuente (> 70-90%, suele ser el inicio)	Rara (< 10-20%, casi siempre respeta mucosas)
Prurito	Raro o escaso (predomina el dolor y ardor)	Muy intenso (síntoma cardinal predominante)
Inmunofluorescencia Directa	Depósito intraepidérmico en "red de pescar" / "malla"	Depósito lineal continuo en la membrana basal
Tratamiento de Elección	Corticoides orales dosis altas (1-1.5 mg/kg) + Rituximab	Corticoides tópicos potentes (Clobetasol) o Prednisona 0.5 mg/kg

16.11. Pénfigo Vulgar (Intraepidérmico) vs Penfigoide Ampollar (Subepidérmico) — Enfrentamiento Diagnóstico

3. PENFIGOIDE AMPOLLAR: AUTOANTÍGENOS, CLIVAJE SUBEPIDÉRMICO Y CLÍNICA

• **Mecanismo Inmune:** Es la dermatosis ampollar autoinmune **más frecuente** de todas. Producida por autoanticuerpos IgG dirigidos contra 6.01.2.010 componentes de los hemidesmosomas en la unión dermoepidérmica: el **antígeno del penfigoide ampollar 1 (BP230)** y el **antígeno del penfigoide ampollar 2 (BP180 o colágeno XVII)**.
• **Nivel Histopatológico de la Ampolla: AMPOLLA SUBEPIDÉRMICA** (por debajo de la membrana basal). El techo de la ampolla contiene toda la epidermis íntegra y engrosada, lo que le otorga enorme resistencia y estabilidad.
• **Inmunofluorescencia Directa (IFD):** Depósito continuo y lineal de **IgG y C3 a lo largo de la membrana basal** (patrón lineal de unión dermoepidérmica).
• **Población Afectada:** Predomina marcadamente en **ancianos mayores de 70 u 80 años**, con frecuencia con comorbilidades neurológicas crónicas (demencia, Parkinson o ACV previo).
• **Cuadro Clínico Clásico:**
- **Fase Prodrómica Pruriginosa:** Meses antes pueden presentar un prurito intenso e intratable con placas urticariales eritematosas semejantes a eccema o urticaria ("fase pre-ampollar").
- **AMPOLLAS TENSAS Y DURO-ELÁSTICAS:** Ampollas de gran tamaño (de 1 a varios centímetros), de paredes gruesas y contenido seroso o hemorrágico transparente, que **NO se rompen fácilmente** y permanecen intactas durante días.
- Asientan predominantemente sobre base eritematosa o eccematosa en abdomen inferior, ingles, axilas y caras de flexión de extremidades.
- **SIGNO DE NIKOLSKY NEGATIVO (-):** La fricción lateral no despega la piel vecina porque la cohesión intraepidérmica está completamente sana.
- **COMPROMISO DE MUCOSAS EXCEPCIONAL (< 10-20%):** Respeta típicamente la mucosa oral.
- Frecuente presencia de **Eosinofilia** periférica y en el líquido de la ampolla.



A. NIKOLSKY POSITIVO



B. PÉNFIGO VULGAR ORAL



C. PÉNFIGO VULGAR

Imagen 16.11

FIGURA 16.11 · ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE DERMATOSIS AMPOLLARES AUTOINMUNES

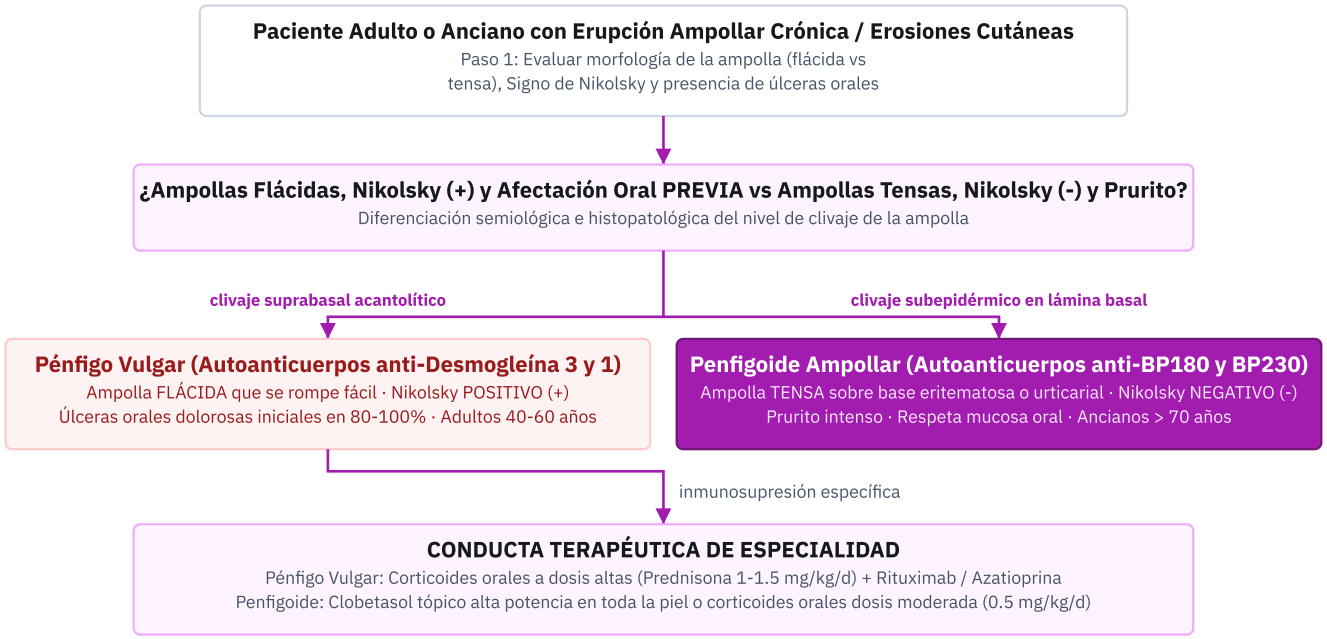


TABLA 16.11.B · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL COMPLETO DE ENFERMEDADES AMPOLLARES PARA EUNACOM

CRITERIOS DE GRAVEDAD

ENTIDAD CLÍNICA	NIVEL DE LA AMPOLLA	SIGNO DE NIKOLSKY	ASOCIACIÓN CLÍNICA Y TERAPÉUTICA CLAVE
Pénfigo Vulgar	Intraepidérmica suprabasal	Positivo (+)	Anticuerpos anti-Dsg3; úlceras orales graves; Prednisona altas dosis
Pénfigo Foliáceo	Intraepidérmica subcórnea	Positivo (+)	Anticuerpos anti-Dsg1; NO afecta mucosas; escamas y costras superficiales
Penfigoide Ampollar	Subepidérmica	Negativo (-)	Anticuerpos anti-BP180/BP230; prurito en ancianos; Clobetasol tópico
Dermatitis Herpetiforme	Subepidérmica (microabscesos papilares)	Negativo (-)	Asociada 100% a Celiaquía; IgA granular en papilas dérmicas; Dapsona
Epidermólisis Bullosa	Subepidérmica mecánica hereditaria	Variable	Genética congénita ("piel de mariposa"); fragilidad extrema ante trauma
NET / Síndrome de Lyell	Necrosis epidérmica total	Positivo (+)	Desencadenada por fármacos; > 30% BSA desprendida; Centro de Quemados

16.11. Pénfigo Vulgar (Intraepidérmico) vs Penfigoide Ampollar (Subepidérmico) — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. COMPARACIÓN TERAPÉUTICA Y PRONÓSTICO VITAL

• **Tratamiento del Pénfigo Vulgar:** 6.01.2.010
- Históricamente era una patología mortal (> 70% por sepsis o deshidratación antes de los corticoides). 6.01.1.020
- **Pilar Inicial: Corticoides Sistémicos en Dosis Altas: Prednisona oral a 1.0 a 1.5 mg/kg/día** (asociado a profilaxis de osteoporosis y gastroprotección).
- **Terapia Ahorradora de Corticoides y Biológica: Rituximab (anticuerpo monoclonal anti-CD20)** es hoy de primera línea en guías internacionales para inducir remisión completa precoz; alternativamente Azatioprina o Micofenolato Mofetilo.

• **Tratamiento del Penfigoide Ampollar:**
- El tratamiento de elección de primera línea (demostrado en ensayos clínicos con menor mortalidad que corticoides orales en ancianos) es el uso de **Corticoides Tópicos de Muy Alta Potencia (Clobetasol propionato crema al 0.05% aplicado en todo el cuerpo, 20-40 g/día)**.
- Si hay intolerancia tópica o enfermedad muy extensa: Prednisona oral a dosis moderadas (0.5 mg/kg/día), asociando Metotrexato oral a dosis bajas si se requiere mantenimiento. **(ver Imagen 16.11B y C)**

5. BIOPSIA DE PIEL E INMUNOFLUORESCENCIA DIRECTA EN ENFERMEDADES AMPOLLARES

En el pénfigo y el penfigoide el diagnóstico de certeza exige **biopsia de piel**, que el médico general indica y **deriva al especialista** para su toma e interpretación. Se hacen **dos muestras** bajo anestesia local con punch de 3 a 4 mm: (1) una de la **lesión reciente, en el borde de una ampolla de menos de 24 horas** (nunca de una ampolla antigua ni solo de su techo, que tiene cambios secundarios), en **formalina**, para hematoxilina-eosina, que distingue la ampolla intraepidérmica acantolítica del pénfigo de la subepidérmica del penfigoide; y (2) una de la **piel perilesional de aspecto sano** (a 1 cm de la ampolla), que **no va en formalina** sino en medio de Michel o suero fisiológico y se envía rápido, para la **inmunofluorescencia directa**: en el pénfigo se ve depósito intercelular de IgG y C3 «en red» y en el penfigoide un depósito lineal en la membrana basal. En el suero se pide inmunofluorescencia indirecta o ELISA contra desmogleínas 1 y 3 (pénfigo) y BP180 y BP230 (penfigoide). Antes de biopsiar se pregunta por anticoagulantes y alergia a anestésicos; el sitio se cura con sutura o hemostasia simple. 6.01.5.001

TABLA 16.11.C · PROTOCOLOS DE INMUNOSUPRESIÓN EN PÉNFIGO VULGAR Y PENFIGOIDE AMPOLLAR — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

ENFERMEDAD	FASE DE INDUCCIÓN	FASE DE MANTENIMIENTO / AHORRADORES	MONITORIZACIÓN CRÍTICA
Pénfigo Vulgar	Prednisona oral 1.0 a 1.5 mg/kg/día (o pulsos de Metilprednisolona)	Rituximab 1000 mg IV (días 1 y 15) o Azatioprina 2-3 mg/kg/día	Pesquisar infecciones oportunistas, sepsis, diabetes esteroidal
Penfigoide Ampollar (Leve-Mod)	Clobetasol propionato 0.05% crema 20-30 g/día en todo el tegumento	Reducción progresiva de aplicaciones tópicas a lo largo de 4-6 meses	Vigilar atrofia cutánea superficial; menor riesgo sistémico
Penfigoide Ampollar (Grave/Ext)	Prednisona oral 0.5 mg/kg/día	Metotrexato oral 10-15 mg/semana + Ácido fólico o Azatioprina	Hemograma y función hepática seriada por inmunosupresión

16.11. Pénfigo Vulgar (Intraepidérmico) vs Penfigoide Ampollar (Subepidérmico) — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (PÉNFIGO VULGAR (INTRAEPIDÉRMICO) VS PENFIGOIDE AMPOLLAR (SUBEPIDÉRMICO))

- Pénfigo Vulgar = Ampolla flácida intraepidérmica suprabasal + Nikolsky (+) + Afectación mucosa oral inicial.
- El autoantígeno del pénfigo vulgar es la Desmogleína 3 y 1 (desmosomas / acantolisis).
- La IFD en pénfigo muestra depósito en "red de pescar"; en penfigoide muestra depósito lineal en membrana basal.
- El tratamiento de primera línea del penfigoide ampollar es el corticoide tópico de alta potencia (Clobetasol).
- Penfigoide Ampollar = Ampolla tensa subepidérmica + Nikolsky (-) + Prurito intenso en ancianos + Respeta boca.
- El autoantígeno del penfigoide ampollar es BP180 y BP230 (hemidesmosomas / membrana basal).
- El tratamiento del pénfigo vulgar requiere corticoides orales a dosis altas (1-1.5 mg/kg) + Rituximab.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

16.11

Hombre de 46 años consulta por múltiples erosiones dolorosas en la mucosa bucal y encías de 3 meses de evolución, tratadas sin éxito con enjuagues bucales y nistatina. Desde hace 3 semanas nota la aparición en el pecho y espalda de varias ampollas de contenido transparente que se rompen con extrema facilidad con el roce de la camisa, dejando erosiones eritematosas descubiertas muy sensibles y exudativas. Al examen físico no se aprecian ampollas intactas en la cavidad oral sino múltiples aftas y úlceras en mucosa yugal; en el tronco se observan algunas ampollas flácidas de paredes delgadas y extensas áreas denudadas húmedas. Al ejercer una suave presión tangencial con el dedo sobre la piel aparentemente sana adyacente a una lesión, la epidermis se desprende con facilidad desnudando la dermis.

Conducta oficial razonada. La presencia de ampollas flácidas intraepidérmicas que se rompen con gran fragilidad, el antecedente de úlceras orales crónicas dolorosas que precedieron a las lesiones cutáneas y el Signo de Nikolsky positivo en un paciente adulto de mediana edad (46 años) configuran el cuadro clínico típico e indudable de un Pénfigo Vulgar. La fisiopatología corresponde a la producción de autoanticuerpos IgG contra desmogleína 3 y desmogleína 1 con acantolisis suprabasal. El diagnóstico se confirma con biopsia para histología e inmunofluorescencia directa que demostrará depósitos de IgG intercelulares en "red de pescar". El tratamiento inicial mandatorio son los corticoides sistémicos a dosis altas (prednisona 1 a 1.5 mg/kg/día), asociados a inmunosupresores como rituximab.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 16.11 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.2.010

1. Un hombre de 76 años, con antecedentes de enfermedad de Parkinson, consulta por un cuadro de 2 meses de evolución de prurito generalizado severo, al que se agregó en las últimas dos semanas la aparición de múltiples ampollas de gran tamaño en el abdomen, ingles y caras internas de muslos. Al examen físico se aprecian numerosas ampollas de contenido seroso claro, de paredes gruesas, muy tensas y duras a la palpación, asentadas sobre placas eritematosas. La mucosa oral no presenta lesiones. Al frotar con fuerza moderada la piel sana perilesional, la epidermis no se despega. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Pénfigo vulgar
B) Penfigoide ampollar
C) Necrólisis epidérmica tóxica
D) Dermatitis herpetiforme
E) Epidermólisis bullosa simple

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.1.020

2. ¿Cuál es el hallazgo anatomopatológico característico en la biopsia cutánea que define la ampolla del Pénfigo Vulgar?

A) Ampolla subepidérmica con neutrófilos en las papilas dérmicas
B) Ampolla intraepidérmica suprabasal con acantolisis celular
C) Ampolla subcórnea con pústulas de espongiosis eosinofílica
D) Necrosis de espesor total de la epidermis con despegamiento dermoepidérmico
E) Vacuolización de la capa basal con infiltrado linfocítico en banda

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.1.020

3. Una paciente de 50 años con diagnóstico confirmado de Pénfigo Vulgar extenso inicia tratamiento de inducción. ¿Cuál es el tratamiento médico de primera línea indicado para controlar la actividad de la enfermedad?

A) Corticoides sistémicos a dosis altas (Prednisona 1 a 1.5 mg/kg/día)
B) Antihistamínicos H1 orales de segunda generación en dosis estándar
C) Dapsona oral combinada con dieta estricta libre de gluten
D) Aciclovir oral en dosis de 800 mg cinco veces al día
E) Metotrexato subcutáneo a dosis bajas en monoterapia exclusiva

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.2.010

4. ¿Cuál es el patrón característico observado en la Inmunofluorescencia Directa (IFD) de una biopsia perilesional en un paciente con Penfigoide Ampollar?

A) Depósito de IgA granular en los vértices de las papilas dérmicas
B) Depósito intercelular intraepidérmico de IgG en patrón de red de pescar
C) Depósito lineal y continuo de IgG y C3 a lo largo de la membrana basal
D) Ausencia total de depósitos inmunes en la epidermis y dermis
E) Depósito granular de IgM en los vasos capilares dérmicos superficiales

Más preguntas online de Pénfigo Vulgar →

16.12. Eritema Multiforme: Morfología en Diana Clásica y Asociación a Virus Herpes Simple

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 6.01.1.010 6.01.1.031 6.01.4.006

¿POR QUÉ?

El Eritema Multiforme (antiguamente llamado eritema multiforme menor) es una reacción inmunológica mucocutánea aguda y autolimitada mediada por complejos inmunes y linfocitos T citotóxicos. La causa desencadenante más frecuente por amplio margen (> 70% de los casos) es una infección viral precedente por Virus Herpes Simple (VHS-1 o VHS-2), típicamente un herpes labial presentado 7 a 14 días antes. La segunda causa más común es Mycoplasma pneumoniae en niños y adultos jóvenes. En las clasificaciones dermatológicas modernas, el Eritema Multiforme se considera una entidad completamente separada del Síndrome de Stevens-Johnson (que es una farmacodermia necrotizante grave).

1. MORFOLOGÍA DE LA LESIÓN EN DIANA TÍPICA (LESIÓN EN ESCARAPELA)

• **LA LESIÓN PATOGNOMÓNICA: DIANA CLÁSICA O EN ESCARAPELA:** 6.01.1.010

Se trata de una lesión anular concéntrica muy bien delimitada, regular, de menos de 3 cm de diámetro, que se compone de **TRES ZONAS CONCÉNTRICAS BIEN DIFERENCIADAS**:

1. **Centro oscuro:** Disco central violáceo, purpúrico o con una microvesícula/costra.
2. **Anillo intermedio pálido:** Zona edematosa elevada de color blanquecino o rosado claro.
3. **Halo exterior eritematoso:** Anillo externo plano de color rojo brillante o violáceo bien circunscrito.

• **Distribución Acral y Simétrica:** Las lesiones aparecen de forma eruptiva y bilateral en las **extremidades: dorso de manos, muñecas, palmas, antebrazos, codos, rodillas y dorso de pies**. Es común que se extiendan centrípetamente hacia el tronco. **(ver Imagen 16.12A)**

2. CLASIFICACIÓN: ERITEMA MULTIFORME MINOR VS MAJOR Y CAUSAS GATILLANTES

• **Eritema Multiforme Minor:** Presenta lesiones típicas en diana en piel acral, **sin afección de mucosas o con compromiso leve de una sola mucosa (habitualmente oral)**. Buen estado general del paciente, sin fiebre ni compromiso sistémico. 6.01.1.010

• **Eritema Multiforme Major:** Presenta lesiones típicas en diana o placas eritematosas dianaformes asociadas a **compromiso mucoso franco en al menos dos mucosas (oral, conjuntival o genital)**, con fiebre y astenia. A pesar de las erosiones mucosas, **NO presenta desprendimiento epidérmico en sábanas y el Signo de Nikolsky es NEGATIVO**.

• **Etiología Desencadenante:**

- **Infecciosa en > 90%: Virus Herpes Simple tipo 1 y 2 (causa número 1, responsable de más del 70% de casos y de las recurrencias periódicas)**. El ADN viral de VHS se transporta por células de Langerhans a la piel donde estimula la citotoxicidad.
- *Mycoplasma pneumoniae:* Causa infecciosa prominente en niños (asociada a menudo a neumonía atípica y mucositis grave).
- *Fármacos:* Muy infrecuente como causa de eritema multiforme típico con dianas de 3 anillos (< 10%). **(ver Imagen 16.12B)**

3. DIAGNÓSTICO Y MANEJO TERAPÉUTICO

• **Diagnóstico Clínico:** Es eminentemente visual e inspeccional. La presencia de dianas de 3 zonas concéntricas de predominio acral con antecedente de herpes labial previo es confirmatoria. 6.01.1.010 6.01.1.031

• **Tratamiento Sintomático de Soporte:**

- Por regla general es una enfermedad benigna autolimitada que **se resuelve espontáneamente en 2 a 4 semanas** sin secuelas cicatriciales.
- Control del prurito y ardor con **Antihistamínicos orales** (Cetirizina, Desloratadina) y **Corticoides tópicos** en las lesiones dérmicas.
- Enjuagues orales antisépticos o con lidocaína viscosa para el dolor en erosiones bucales.

• **Terapia Antiviral Específica:**

- En el episodio agudo: Si el herpes labial está activo simultáneamente, se indica **Aciclovir oral (400 mg 5 veces/día o Valaciclovir 500-1000 mg cada 12 h)**.
- **Eritema Multiforme Recurrente por VHS:** En pacientes que sufren más de 3 a 5 brotes al año, el tratamiento de elección profiláctico es la **terapia antiviral supresiva continua con Aciclovir oral (400 mg cada 12 horas por 6 meses)**, logrando prevenir las recurrencias en más del 80% de los casos.

4. INFECCIONES VIRALES CUTÁNEAS FRECUENTES: VERRUGAS, MOLUSCO CONTAGIOSO, HERPES SIMPLE Y HERPES ZÓSTER

Verrugas (virus papiloma humano). Los tipos 1, 2 y 4 producen las verrugas vulgares y plantares, los tipos 3 y 10 las verrugas planas y los tipos 6 y 11 los condilomas anogenitales benignos (los tipos 16 y 18 son oncogénicos). La **verruga vulgar** es una pápula o nódulo hiperqueratósico rugoso en dedos, manos y rodillas, con puntos negros (capilares trombosados); la **verruga plantar** es endofítica, dolorosa a la compresión lateral e **interrumpe los dermatoglifos** (el callo los conserva); las verrugas planas son pápulas rosadas de superficie lisa en cara y dorso de manos, con distribución lineal por Koebner. En el niño inmunocompetente se resuelven solas en cerca de 2 años en la mayoría. Tratamiento: **ácido salicílico 15 a 40%** diario con lijado y **crioterapia con nitrógeno líquido** cada 2 a 3 semanas; se deriva si no hay respuesta en 3 meses, si hay inmunosupresión, lesiones atípicas (biopsia) o condilomas (podofilotoxina, imiquimod o crioterapia, con estudio y tratamiento de la pareja). **(ver Imagen 16.12C)** 6.01.1.031

Molusco contagioso. Es causado por un poxvirus: pápulas **perladas, color piel, de 2 a 5 mm, con una depresión central (umbilicadas)** y contenido caseoso, en niños (contacto en piscinas, atopia) y, en adultos, en el área genital (infección de transmisión sexual) o múltiples y gigantes en inmunosuprimidos (VIH). Es autolimitado en 6 a 12 meses, y en algunos casos hasta 4 años; se puede observar o tratar con curetaje, crioterapia o hidróxido de potasio tópico 5 a 10%. Se evita el rascado (autoinoculación) y compartir toallas, y en un adulto con muchas lesiones se descarta infección por VIH.



Molusco contagioso

Herpes simple. El VHS-1 produce el herpes labial y el VHS-2 el genital. La primoinfección en el niño es una gingivoestomatitis; en la recurrencia hay un pródromo de ardor y prurito y luego **vesículas agrupadas «en racimo» sobre base eritematosa** que se erosionan y forman costras en 7 a 10 días, desencadenadas por fiebre, radiación UV, estrés o menstruación. Complicaciones: eccema herpético de Kaposi sobre dermatitis atópica (urgencia), queratitis herpética (derivar a oftalmología), eritema multiforme recurrente, encefalitis y herpes neonatal. Tratamiento oral: **aciclovir 400 mg cada 8 horas por 7 a 10 días** en la primoinfección y por 5 días en las recurrencias (o valaciclovir); si hay 6 o más episodios al año se indica supresión con

aciclovir 400 mg cada 12 horas; en inmunosuprimidos y formas graves se usa aciclovir endovenoso.

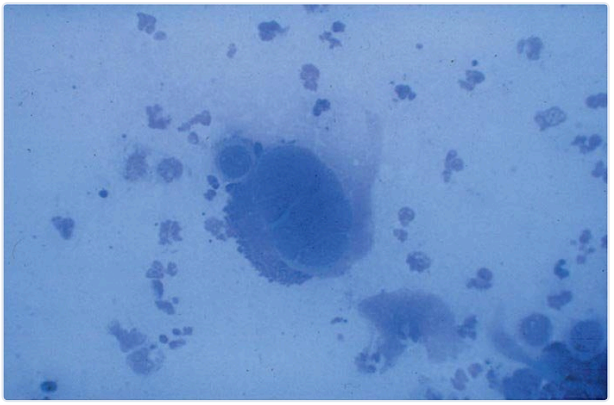
Herpes zóster. Es la reactivación del virus varicela-zóster en un ganglio de la raíz dorsal, frecuente sobre los 50 años o con inmunosupresión. Tras 1 a 5 días de dolor o ardor neuropático aparece una placa eritematosa con **vesículas agrupadas en un dermatoma, unilateral, que no cruza la línea media** (el torácico es el más frecuente); las costras se forman a los 7 a 10 días. Complicaciones: **neuralgia posherpética** (dolor de más de 3 meses, hasta 20% sobre los 50 años), **zóster oftálmico** (rama V1; las vesículas en la punta de la nariz o signo de Hutchinson anuncian compromiso ocular y obligan a derivar de urgencia a oftalmología), **síndrome de Ramsay Hunt** (vesículas en el conducto auditivo externo con parálisis facial periférica e hipoacusia) y zóster diseminado en inmunosuprimidos. Tratamiento: antiviral idealmente dentro de las **72 horas** del inicio, **aciclovir 800 mg cinco veces al día, valaciclovir 1 g cada 8 horas o famciclovir 500 mg cada 8 horas, por 7 días**, con analgesia escalonada (paracetamol, AINE y gabapentinoides o amitriptilina para el dolor neuropático) y compresas; los corticoides no son de rutina. Mientras haya vesículas o costras húmedas contagia varicela a quienes no la han tenido. Se derivan los casos oftálmicos, con Ramsay Hunt, diseminados o en inmunosuprimidos.



Herpes zóster diseminado: lesiones en distintas etapas de evolución, con pústulas y costras

5. TEST DE TZANCK: CITODIAGNÓSTICO DE LESIONES VESICULARES Y AMPOLLARES

El **test de Tzanck** es un citodiagnóstico rápido y barato, que el 6.01.4.006 médico general debe saber interpretar y emplear. Se **destecha una vesícula reciente** (no una costrosa), se raspa suavemente el piso con un bisturí, se extiende el material en un portaobjetos, se fija y se tiñe con Giemsa, Wright o azul de toluidina. En la **infección por virus herpes simple o varicela-zóster** se observan **células gigantes multinucleadas con núcleos en «vidrio esmerilado» y moldeamiento nuclear** (con inclusiones eosinofílicas); no distingue entre herpes simple, zóster y varicela. En el **pénfigo vulgar** se ven **queratinocitos acantolíticos** redondeados, aislados, de núcleo grande y citoplasma basófilo, sin multinucleación; así orienta entre una erosión herpética y una enfermedad ampollar autoinmune. Su sensibilidad es de 60 a 70%: un test negativo no descarta herpes y se confirma con PCR, inmunofluorescencia directa o cultivo viral. En el eritema multiforme causado por herpes sirve para documentar el virus.



Test de Tzanck



A. DIANAS EN LAS MANOS



B. ERITEMA MULTIFORME EN EL PIE



C. VERRUGA VULGAR

Imagen 16.12

FIGURA 16.12 · ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE ERITEMA MULTIFORME

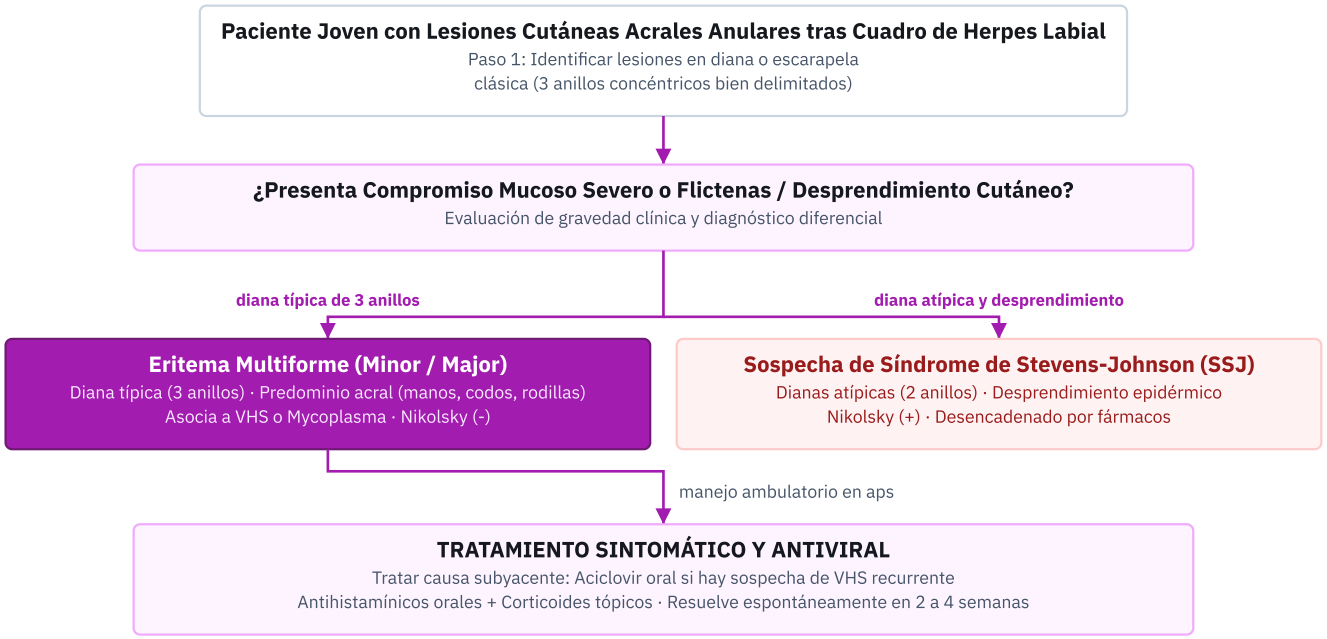


TABLA 16.12 · DIFERENCIAS CARDINALES: ERITEMA MULTIFORME VS SÍNDROME DE STEVENS-JOHNSON `6.01.1.010, 6.01.1.031, 6.01.4.006`

CRITERIO DIFERENCIAL	ERITEMA MULTIFORME (EM)	SÍNDROME DE STEVENS-JOHNSON (SSJ)
Etiología Principal	Infecciosa: Virus Herpes Simple (> 70%) o Mycoplasma	Medicamentosa: Fármacos (Alopurinol, sulfas, anticonvulsivantes)
Morfología de la Diana	Diana típica clásica con 3 anillos concéntricos definidos	Diana atípica con 2 anillos (centro purpúrico/ampollar plano)
Distribución Anatómica	Acral: dorso de manos, antebrazos, codos, rodillas	Centrípeta y axial: tronco, tórax anterior, cara y cuello
Desprendimiento Epidérmico	Ausente (0% de superficie corporal desprendida)	Presente (< 10% en SSJ puro, > 30% en NET)
Signo de Nikolsky	Negativo (-)	Positivo (+) en piel perilesional
Compromiso de Mucosas	Ausente o leve a moderado (oral); buen estado general	Severo, extenso, hemorrágico y con costras labiales
Pronóstico y Manejo	Autolimitado en 2-4 semanas; manejo ambulatorio en APS	Grave con riesgo vital; requiere hospitalización en UCI/Quemados

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 16.12

Joven de 22 años consulta en el CESFAM por la aparición súbita hace 3 días de múltiples lesiones cutáneas eritematosas poco pruriginosas en ambas manos y antebrazos. Refiere como único antecedente haber presentado un brote de "fuegos labiales" (herpes labial recurrente) hace 10 días, el cual ya se encuentra en fase costrosa cicatrizal. Al examen físico se aprecian múltiples lesiones circulares regulares de 1 a 2 cm de diámetro en el dorso de las manos, palmas y cara extensora de ambos antebrazos. Cada lesión presenta un centro violáceo oscuro con una pequeña vesícula central, rodeado por un anillo pálido edematoso y un halo exterior eritematoso rojo vivo bien delimitado (aspecto de tiro al blanco o escarapela). El signo de Nikolsky es negativo y la mucosa oral no presenta úlceras.

Conducta oficial. El cuadro corresponde a un Eritema Multiforme clásico (Eritema Multiforme Minor). La morfología de las lesiones en diana típica o escarapela con 3 anillos concéntricos bien delimitados, de distribución simétrica y predominantemente acral en dorso de manos y antebrazos, gatillada 10 días después de un episodio de herpes labial por Virus Herpes Simple (la causa más frecuente en > 70% de los casos), confirma el diagnóstico. El signo de Nikolsky negativo y la ausencia de desprendimiento epidérmico o afección mucosa severa descartan de plano un síndrome de Stevens-Johnson. El manejo en este paciente es sintomático ambulatorio con antihistamínicos orales y corticoides tópicos, con resolución espontánea esperada en 2 a 4 semanas.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- La causa más frecuente de Eritema Multiforme es el Virus Herpes Simple (VHS-1 y 2) en > 70% de los casos.
- La segunda causa infecciosa relevante es Mycoplasma pneumoniae en niños y jóvenes.
- La lesión elemental patognomónica es la Diana Típica o en Escarapela con 3 zonas concéntricas.
- Se distribuye de forma simétrica en zonas acrales: dorso de manos, palmas, antebrazos y rodillas.
- En el eritema multiforme NO hay desprendimiento epidérmico en sábanas y el Nikolsky es NEGATIVO.
- El cuadro es benigno y autolimitado, resolviéndose espontáneamente en 2 a 4 semanas.
- En casos de brotes recurrentes frecuentes asociados a VHS, el tratamiento de elección es Aciclovir oral supresivo.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 16.12

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.1.010

1. Un adulto joven de 24 años consulta por una erupción cutánea en el dorso de ambas manos y antebrazos caracterizada por lesiones redondeadas eritematosas, con un centro purpúrico violáceo rodeado por un anillo pálido edematoso y un halo eritematoso externo (lesiones en diana de 3 anillos). Refiere haber tenido un episodio de herpes labial hace una semana. Al examen físico no se palpan adenopatías y el signo de Nikolsky es negativo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el agente causal más frecuentemente asociado?

A) Síndrome de Stevens-Johnson por ingesta de paracetamol
B) Eritema multiforme por infección por Virus Herpes Simple
C) Urticaria multiforme por virus de Epstein-Barr
D) Penfigoide ampollar por exposición a radiación UV
E) Lupus eritematoso discoide por fotosensibilidad

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.1.031

2. Un paciente de 28 años presenta su quinto episodio en el último año de eritema multiforme con lesiones típicas en diana en manos y antebrazos, todos ellos precedidos 10 días antes por un brote visible de herpes labial recurrente. ¿Cuál es la conducta médica más adecuada para prevenir futuros episodios?

A) Prednisona oral en dosis de 1 mg/kg/día de forma indefinida
B) Tratamiento profiláctico continuo con Aciclovir oral durante 6 meses
C) Aplicación de protector solar factor 50+ como única medida
D) Inmunoterapia con interferón gamma recombinante subcutáneo
E) Derivación para plasmaféresis de mantención mensual

Más preguntas online de Eritema Multiforme →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 3.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 16.9 A 16.12

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Reacciones Medicamentosas Graves: Stevens-Johnson (SSJ) y Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET)	Los fármacos gatillantes más frecuentes son Alopurinol, Carbamazepina, Cotrimoxazol y...	**El período de latencia típico es de 1 a 4 semanas tras el inicio del fármaco culpable.**	El compromiso ocular exige evaluación precoz para evitar sinequias conjuntivales...
Síndrome DRESS: Erupción Medicamentosa con Eosinofilia y Síntomas Sistémicos	El DRESS tiene una latencia prolongada y característica de 2 a 8 semanas tras iniciar...	**Los fármacos causales más comunes son Carbamazepina, Fenitoína, Fenobarbital y...**	El cuadro clínico es clásico de un Síndrome DRESS (Drug Reaction with Eosinophilia and...
Pénfigo Vulgar (Intraepidérmico) vs Penfigoide Ampollar (Subepidérmico)	Pénfigo Vulgar = Ampolla flácida intraepidérmica suprabasal + Nikolsky (+) + Afectación...	**Penfigoide Ampollar = Ampolla tensa subepidérmica + Nikolsky (-) + Prurito intenso en...**	—
Eritema Multiforme: Morfología en Diana Clásica y Asociación a Virus Herpes Simple	La causa más frecuente de Eritema Multiforme es el Virus Herpes Simple (VHS-1 y 2) en >...	**La segunda causa infecciosa relevante es Mycoplasma pneumoniae en niños y jóvenes.**	El cuadro corresponde a un Eritema Multiforme clásico (Eritema Multiforme Minor). La...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

Los fármacos gatillantes más frecuentes son Alopurinol, Carbamazepina, Cotrimoxazol y AINEs.

El período de latencia típico es de 1 a 4 semanas tras el inicio del fármaco culpable.

El Signo de Nikolsky (+) es el desprendimiento de la epidermis por fricción suave sobre piel eritematosa.

Clasificación por superficie corporal desprendida: SSJ 30%.

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- El período de latencia típico es de 1 a 4 semanas tras el inicio del fármaco culpable.
- El Signo de Nikolsky (+) es el desprendimiento de la epidermis por fricción suave sobre piel eritematosa.
- Los fármacos causales más comunes son Carbamazepina, Fenitoína, Fenobarbital y Alopurinol.
- La tríada cardinal es: Fiebre alta + Rash confluente con Edema Facial + Linfadenopatías.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

Los fármacos gatillantes más frecuentes son Alopurinol, Carbamazepina, Cotrimoxazol y AINEs.	Tema 16.9 →
El DRESS tiene una latencia prolongada y característica de 2 a 8 semanas tras iniciar el fármaco.	Tema 16.10 →
Pénfigo Vulgar = Ampolla flácida intraepidérmica suprabasal + Nikolsky (+) + Afectación mucosa oral inicial.	Tema 16.11 →
La causa más frecuente de Eritema Multiforme es el Virus Herpes Simple (VHS-1 y 2) en > 70% de los casos.	Tema 16.12 →

MANUAL EUNACOM DE DERMATOLOGÍA

BLOQUE 04 DE 04 · PERFIL DE CONOCIMIENTOS V3 ASOFAMECH

perfil v3 asofamech
21 CÓDIGOS OFICIALES

04

BLOQUE TEMÁTICO
6 clases

ONCOLOGÍA CUTÁNEA, LESIONES PREMALIGNAS & INFECCIONES CUTÁNEAS

6	17	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE — PÁGINA

16.13 Melanoma Maligno: Regla ABCDE, Biopsia Excisional, Índice de Breslow y Márgenes Quirúrgicos 68

16.14 Carcinomas Cutáneos No Melanoma: Carcinoma Basocelular (CBC) vs Carcinoma Espinocelular (CEC) 73

16.15 Lesiones Cutáneas Premalignas: Queratosis Actínica, Cuerno Cutáneo y Nevos Displásicos 77

16.16 Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis 81

16.17 Tumores Benignos de Piel, Hemangiomas Infantiles y Malformaciones Vasculares 86

16.18 Loxoscelismo (Loxosceles laeta): Cuadro Cutáneo y Cutáneo-Visceral, Manejo y Prevención en la Vivienda 91

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM — 21 CÓDIGOS

Este bloque cubre **21 códigos oficiales** (21 situaciones). La tabla completa, con el nivel exigido de cada uno, está en la página siguiente.

BLOQUE 04 · ONCOLOGÍA CUTÁNEA, LESIONES PREMALIGNAS & INFECCIONES CUTÁNEAS

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3

perfil v3 asofamech
21 CÓDIGOS OFICIALES

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

21 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
6.01.1.017	Melanoma maligno Tema 16.13	Sospecha	Inicial	Derivar
6.01.5.001	Biopsia de piel Tema 16.13	Derivar a especialista		
6.01.4.002	Dermatoscopía Tema 16.13	Emplea informe		
6.01.1.003	Cáncer de piel no melanoma (carcinoma basocelular y espinocelular) Tema 16.14	Sospecha	Inicial	Derivar
6.01.3.001	Fotoprotección Tema 16.14	Conocimiento		
6.01.1.029	Tumores premalignos (queratosis actínicas, Bowen) Tema 16.15	Sospecha	Inicial	Completo
6.01.1.018	Micosis superficiales Tema 16.16	Específico	Completo	Completo
6.01.1.027	Sarna Tema 16.16	Específico	Completo	Completo
6.01.1.019	Pediculosis Tema 16.16	Específico	Completo	Completo
6.01.4.004	Micológico directo de piel, pelos y uñas Tema 16.16	Interpreta y emplea		
2.01.1.109	Ectoparasitosis Tema 16.16	Específico	Completo	Completo
2.01.1.110	Infecciones micóticas de piel y fanéreos Tema 16.16	Específico	Completo	Completo
1.04.4.003	Cultivos de hongos Tema 16.16	Interpreta y emplea		
6.01.1.022	Pitiriasis Rosada de Gilbert Tema 16.16	Específico	Completo	Completo
6.01.1.023	Prúrigo infantil agudo, picadura de insectos Tema 16.16	Específico	Completo	Completo
6.01.4.001	Acarotest Tema 16.16	Realiza, interpreta y emplea		
6.01.1.028	Tumores benignos de piel (quistes, lipomas, queratosis seborreica) Tema 16.17	Específico	Completo	Completo
6.01.1.013	Hemangiomas cutáneos infantiles Tema 16.17	Específico	Inicial	Derivar
2.01.1.111	Malformaciones vasculares cutáneas Tema 16.17	Específico	Inicial	Derivar
6.01.2.008	Loxocelismo Tema 16.18	Específico	Completo	Completo
6.01.3.002	Higiene de la vivienda y profilaxis del loxoscelismo Tema 16.18	Conocimiento		

BLOQUE 04 · ONCOLOGÍA CUTÁNEA, LESIONES PREMALIGNAS & INFECCIONES CUTÁNEAS

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
17 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

La regla del ABCDE (Asimetría, Bordes, Color heterogéneo, Diámetro > 6 mm, Evolución) es la herramienta clínica de tamizaje cardinal para melanoma.

La biopsia de elección de toda lesión sospechosa de melanoma es la BIOPSIA EXCISIONAL COMPLETA con margen estrecho de 1 a 2 mm e hipodermis.

! TRAMPA · Las biopsias por rasurado (shave) o punch están contraindicadas porque mutilan la muestra e impiden medir con exactitud el espesor de Breslow.

El Índice de Breslow (espesor tumoral en milímetros) es el factor pronóstico individual más importante para el melanoma localizado.

El margen de ampliación quirúrgica definitiva se define según el Breslow: in situ (0.5 cm), ≤ 1 mm (1 cm), 1-2 mm (1-2 cm), > 2 mm (2 cm).

La biopsia de ganglio centinela está formalmente indicada en todo melanoma con espesor de Breslow > 0.8 mm (o < 0.8 mm con ulceración).

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

6 DE 6 TEMAS

Melanoma Maligno: Regla ABCDE, Biopsia Excisional, Índice de Breslow y Márgenes Quirúrgicos	EUNACOM Enero 2023 · #115 · EUNACOM Enero 2023 · #114 · EUNACOM Diciembre 2019 · #178
Carcinomas Cutáneos No Melanoma: Carcinoma Basocelular	EUNACOM Diciembre 2024 · #111 · EUNACOM Diciembre 2019 · #80 · EUNACOM Diciembre 2018 · #63
Lesiones Cutáneas Premalignas: Queratosis Actínica, Cuerno Cutáneo y Nevos Displásicos	EUNACOM Diciembre 2025 · #81
Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales	EUNACOM Diciembre 2025 · #91 · EUNACOM Julio 2025 · #144 · EUNACOM Julio 2024 · #17 · EUNACOM Diciembre 2024 · #4
Tumores Benignos de Piel, Hemangiomas Infantiles y Malformaciones Vasculares	EUNACOM Diciembre 2025 · #83 · EUNACOM Julio 2024 · #125 · EUNACOM Julio 2024 · #126 · EUNACOM Enero 2023 · #19
Loxoscelismo	EUNACOM Enero 2023 · #149 · EUNACOM Diciembre 2017 · #89

16.13. Melanoma Maligno: Regla ABCDE, Biopsia Excisional, Índice de Breslow y Márgenes Quirúrgicos

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 6.01.1.017 6.01.5.001 6.01.4.002

¿POR QUÉ?

El melanoma maligno es el tumor cutáneo con mayor letalidad por su elevado potencial metastásico precoz. En el EUNACOM se evalúan con absoluta certeza tres conceptos fundamentales: 1) la regla del ABCDE para la sospecha clínica; 2) la técnica de biopsia adecuada, que DEBE SER EXCISIONAL COMPLETA con margen mínimo de 1 a 2 mm incluyendo hipodermis (la biopsia por afeitado/shave o punch está formalmente contraindicada porque mutila la medición del espesor); y 3) el Índice de Breslow (profundidad de invasión en milímetros medido desde la capa granulosa), que es el factor pronóstico individual más importante y determina la ampliación definitiva de márgenes quirúrgicos y la indicación de biopsia de ganglio centinela.

1. FACTORES DE RIESGO, SOSPECHA CLÍNICA Y REGLA DEL ABCDE

• **Factores de Riesgo:** Exposición solar ultravioleta intermitente e intensa con quemaduras solares en la infancia/adolescencia, fototipo cutáneo claro (Fitzpatrick I y II: ojos claros, pelo rubio o pelirrojo, pecas), presencia de > 50-100 nevos melanocíticos comunes, presencia de nevos displásicos/atípicos, historia personal o familiar de melanoma (mutaciones en CDKN2A/p16). **(ver Imagen 16.13A, B y C)** 6.01.1.017

• **Regla del ABCDE de la Lesión Pigmentada:**

- **A (Asimetría):** Al trazar una línea imaginaria por el centro, las dos mitades no coinciden en forma.

- **B (Bordes):** Bordes irregulares, festoneados, recortados, dentados o mal definidos.

- **C (Color):** Variación heterogénea de color en la misma lesión (marrón oscuro, negro, azulado, blanco o rojo).

- **D (Diámetro):** Mayor a 6 mm (aproximadamente el borrador de un lápiz), aunque melanomas iniciales pueden ser menores.

- **E (Evolución):** El criterio más sensible. Cualquier cambio dinámico de tamaño, forma, color, elevación, prurito o sangrado espontáneo en un nevo previo, o la aparición de una lesión nueva de novo en adultos ("signo del patito feo").

2. SUBTIPOS CLÍNICO-PATOLÓGICOS PRINCIPALES

• **Melanoma de Extensión Superficial (70%):** Es el subtipo más frecuente en caucásicos. Se presenta en tronco en hombres y piernas en mujeres. Fase de crecimiento radial intraepidérmico prolongada antes de invadir la dermis. 6.01.1.017

• **Melanoma Nodular (15%):** El subtipo más agresivo. Fase de crecimiento vertical rápida desde el inicio, sin fase radial. Nódulo cupuliforme negro-azulado, sangrante o ulcerado. Elevado espesor de Breslow al diagnóstico.



Melanoma nodular

• **Léntigo Maligno Melanoma (10%):** En zonas fotoexpuestas crónicas (cara, cuello) de ancianos. Precedido por léntigo maligno in situ ("peca de Hutchinson") de evolución lenta durante décadas.

• **Melanoma Lentiginoso Acral (5% en caucásicos, pero > 50% en poblaciones mestizas y chilenas):** Localizado en palmas, plantas y lechos ungueales (melanoniquia longitudinal con signo de Hutchinson: pigmento que compromete el pliegue ungueal cutáneo). **NO se relaciona con exposición solar.**



Melanoma lentiginoso acral en planta del pie o lecho ungueal

TABLA 16.13.A · SUBTIPOS DE MELANOMA MALIGNO Y CORRELACIÓN CLÍNICO-PATOLÓGICA 6.01.1.017, 6.01.5.001, 6.01.4.002

SUBTIPO	FRECUENCIA GLOBAL / CHILE	LOCALIZACIÓN TÍPICA	FASE DE CRECIMIENTO	CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS
Extensión Superficial	70% caucásicos	Espalda (hombres), Piernas (mujeres)	Radial prolongada antes de vertical	Mácula/placa policromática asimétrica; el más frecuente
Nodular	15%	Cualquier zona anatómica	Vertical pura desde el inicio	Nódulo azul-negro cupuliforme, muy agresivo, Breslow alto
Léntigo Maligno Melanoma	10%	Cara, mejillas, nariz en ancianos	Radial muy lenta (años/décadas)	Asociado a daño solar crónico continuo (peca de Hutchinson)
Lentiginoso Acral	5% caucásicos (>50% en Chile/latino)	Palmas, plantas, subungueal	Radial y vertical	No UV-dependiente; Signo de Hutchinson periungueal

16.13. Melanoma Maligno: Regla ABCDE, Biopsia Excisional, Índice de Breslow y Márgenes Quirúrgicos — Enfrentamiento Diagnóstico

3. DIAGNÓSTICO Y CONDUCTA QUIRÚRGICA ESCALONADA

• **TÉCNICA DE BIOPSIA DE ELECCIÓN: Biopsia excisional completa** con margen estrecho de 1 a 2 mm de piel sana y con profundidad que incluya todo el tejido celular subcutáneo. Está terminantemente contraindicada la biopsia por rasurado (shave) o sacabocados (punch) superficial, ya que amputa la base del tumor y hace imposible medir el espesor de Breslow real. 6.01.1.017 6.01.5.001

• **Índice de Breslow:** Medición histológica exacta en milímetros desde la capa granulosa de la epidermis hasta la célula tumoral más profunda en la dermis/hipodermis.

• **Ampliación Quirúrgica Definitiva según Breslow:** 6.01.1.017

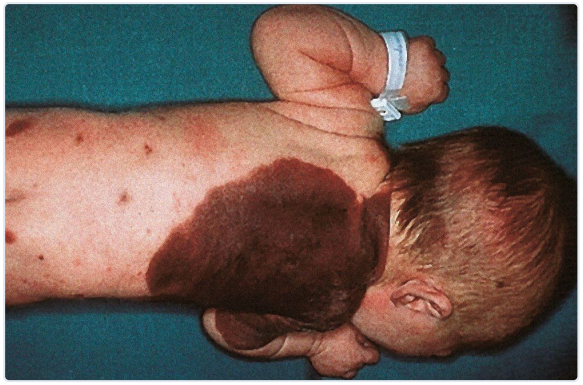
- *Melanoma in situ:* Margen de 0.5 cm (5 mm).

- *Breslow ≤ 1.0 mm:* Margen de 1.0 cm.

- *Breslow 1.01 a 2.0 mm:* Margen de 1.0 a 2.0 cm.

- *Breslow > 2.0 mm:* Margen de 2.0 cm.

• **Biopsia de Ganglio Centinela:** Indicada en todo melanoma con **Breslow > 0.8 mm** (o Breslow < 0.8 mm con ulceración histológica o mitosis elevadas) en ausencia de adenopatías clínicas palpables.



A. NEVO CONGÉNITO GRANDE



B. NEVO COMÚN



C. MELANOMA

Imagen 16.13

FIGURA 16.13 · ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y MANEJO QUIRÚRGICO DEL MELANOMA MALIGNO

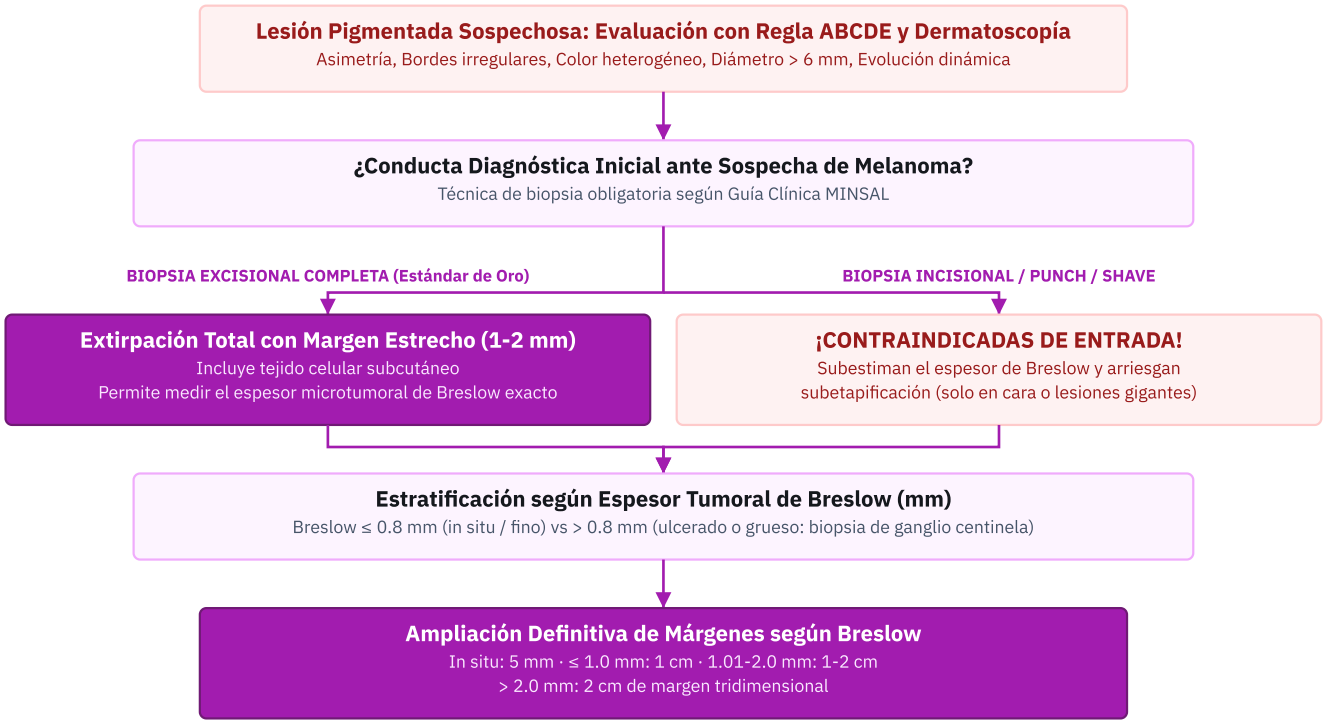


TABLA 16.13.B · ESTRATIFICACIÓN SEGÚN ÍNDICE DE BRESLOW Y MÁRGENES QUIRÚRGICOS DEFINITIVOS — CRITERIOS DE GRAVEDAD

ESPESOR DE BRESLOW (MM)	ESTADIO T	MARGEN QUIRÚRGICO DEFINITIVO	BIOPSIA DE GANGLIO CENTINELA	SOBREVIDA A 5 AÑOS
In situ (Tis)	Tis	0.5 cm (5 mm)	No indicada	> 99%
≤ 1.00 mm	T1 (a: <0.8 s/ulc; b: 0.8-1.0 o c/ulc)	1.0 cm	Indicada si > 0.8 mm o con ulceración	95 - 98%
1.01 - 2.00 mm	T2 (a: sin ulc; b: con ulc)	1.0 - 2.0 cm	Indicada siempre	85 - 90%
2.01 - 4.00 mm	T3 (a: sin ulc; b: con ulc)	2.0 cm	Indicada siempre	65 - 75%
> 4.00 mm	T4 (a: sin ulc; b: con ulc)	2.0 cm	Indicada + Estudio de diseminación	50%

16.13. Melanoma Maligno: Regla ABCDE, Biopsia Excisional, Índice de Breslow y Márgenes Quirúrgicos — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. DERMATOSCOPÍA: HERRAMIENTA DE APOYO EN EL DIAGNÓSTICO DE LESIONES PIGMENTADAS

La **dermatoscopía** es la observación de la lesión con un dermatoscopio (luz polarizada y aumento de 10 veces) que muestra estructuras bajo la epidermis; aumenta la sensibilidad para detectar melanoma y evita biopsias innecesarias. El médico general **emplea el informe**: lo lee y decide conducta, sin reemplazar la biopsia. Los hallazgos de las lesiones benignas son retículo pigmentado regular, patrón globular o empedrado, color homogéneo y simetría. Los **hallazgos de alarma de melanoma** son: red pigmentada atípica o irregular, estrías o pseudópodos irregulares, **velo azul blanquecino**, **estructuras de regresión** (áreas blancas cicatriciales y puntos azul-grisáceos), glóbulos y puntos irregulares y vasos atípicos; se usan algoritmos como el análisis de patrones, la regla ABCD dermatoscópica y la **lista de 7 puntos de Argenziano**, y el signo del «patito feo» (la lesión que no se parece a las demás del paciente). Otras lesiones tienen patrones propios: el carcinoma basocelular muestra **vasos arboriformes**, ulceración y glóbulos azul-grisáceos; la queratosis seborreica, aperturas tipo comedón, quistes tipo milia y aspecto cerebriforme; el dermatofibroma, una red periférica delicada con centro blanco cicatricial. Conducta: dermatoscopía sospechosa de melanoma se resuelve con **biopsia excisional con margen de 1 a 3 mm y derivación** (véase sección 3); las lesiones benignas se siguen con fotografía y dermatoscopía digital, y en pacientes de alto riesgo (más de 50 nevos, antecedente familiar o personal de melanoma) se hace mapeo corporal total.

6.01.4.002

TABLA 16.13.C · MANEJO MÉDICO Y QUIRÚRGICO INTEGRAL DEL MELANOMA MALIGNO (GES) — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

ESCENARIO CLÍNICO	INTERVENCIÓN PRIMARIA	ESTUDIO DE ETAPIFICACIÓN	TERAPIA ADYUVANTE / SISTÉMICA
Lesión Sospechosa Inicial	Biopsia excisional completa con margen 1-2 mm	Dermatoscopía digital + estudio histopatológico	No aplica
Melanoma Localizado (T1-T4 N0)	Ampliación de márgenes (1 a 2 cm) + Ganglio Centinela	TAC tórax-abdomen-pelvis o PET-CT si T3-T4	Interferón-alfa (histórico) o seguimiento estrecho
Compromiso Ganglionar (N+)	Linfadenectomía regional terapéutica si macroscópico	PET-CT o RMN cerebral + TAC TAP	Inmunoterapia (Nivolumab / Pembrolizumab) o Terapia dirigida
Melanoma Metastásico (Estadio IV)	Manejo oncológico sistémico según mutación BRAF V600E	RMN cerebral + PET-CT completo	Inhibidores BRAF/MEK (Dabrafenib+Trametinib) o anti-PD-1

16.13. Melanoma Maligno: Regla ABCDE, Biopsia Excisional, Índice de Breslow y Márgenes Quirúrgicos — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (MELANOMA MALIGNO)

- La regla del ABCDE (Asimetría, Bordes, Color heterogéneo, Diámetro > 6 mm, Evolución) es la herramienta clínica de tamizaje cardinal para melanoma.
- Las biopsias por rasurado (shave) o punch están contraindicadas porque mutilan la muestra e impiden medir con exactitud el espesor de Breslow.
- El margen de ampliación quirúrgica definitiva se define según el Breslow: in situ (0.5 cm), ≤ 1 mm (1 cm), 1-2 mm (1-2 cm), > 2 mm (2 cm).
- La biopsia de elección de toda lesión sospechosa de melanoma es la BIOPSIA EXCISIONAL COMPLETA con margen estrecho de 1 a 2 mm e hipodermis.
- El Índice de Breslow (espesor tumoral en milímetros) es el factor pronóstico individual más importante para el melanoma localizado.
- La biopsia de ganglio centinela está formalmente indicada en todo melanoma con espesor de Breslow > 0.8 mm (o < 0.8 mm con ulceración).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

16.13

Hombre de 52 años, agricultor, consulta por la aparición de una lesión pigmentada en la región interescapular de 8 meses de evolución, que ha presentado crecimiento progresivo y picazón ocasional. Al examen dermatológico se observa una lesión macular de 9 mm de diámetro mayor, francamente asimétrica, con bordes dentados e irregulares y múltiples tonalidades de color marrón oscuro, negro y áreas azuladas centrales. No se palpan adenopatías en las cadenas ganglionares axilares ni cervicales.

Conducta oficial razonada. La lesión reúne todos los criterios de sospecha de melanoma maligno según la regla del ABCDE (Asimétrica, Bordes irregulares, Color policromático, Diámetro > 6 mm, Evolución dinámica). De acuerdo con las guías clínicas ministeriales e internacionales, la conducta diagnóstica de elección obligatoria es realizar una biopsia excisional completa con 1 a 2 mm de margen de piel sana, incluyendo tejido celular subcutáneo en profundidad, para confirmar el diagnóstico y permitir al patólogo medir con exactitud el espesor de Breslow.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 16.13 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.5.001

1. Un hombre de 46 años consulta por un nevo en la espalda que ha cambiado de color y aumentado de tamaño en los últimos 4 meses. Al examen se observa una lesión macular asimétrica de 8 mm con bordes irregulares y tres colores distintos (café claro, negro y grisáceo). ¿Cuál es la conducta diagnóstica de elección?

A) Cauterización con nitrógeno líquido (crioterapia) en la consulta
B) Biopsia excisional completa con 1 a 2 mm de margen lateral y celular subcutáneo
C) Biopsia por afeitado (shave) superficial para no dejar cicatriz antiestética
D) Biopsia por sacabocados (punch) de 2 mm tomada del centro más pigmentado de la lesión
E) Control fotográfico digital seriado cada 3 meses

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.1.017

2. El informe histopatológico de una biopsia excisional de una lesión cutánea en la pierna de una mujer de 38 años concluye: "Melanoma maligno de extensión superficial, espesor de Breslow de 0.6 mm, sin ulceración, márgenes de resección libres a 1 mm". ¿Cuál es la conducta terapéutica definitiva más apropiada?

A) No realizar ningún procedimiento adicional dado que los márgenes de la biopsia estaban libres
B) Ampliación quirúrgica de márgenes a 1 cm de tejido sano, sin necesidad de biopsia de ganglio centinela
C) Ampliación quirúrgica de márgenes a 2 cm más biopsia de ganglio centinela obligatoria
D) Iniciar quimioterapia adyuvante con dacarbazina por 6 ciclos
E) Radioterapia local fraccionada sobre el lecho de la cicatriz

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.1.017

3. ¿Cuál de los siguientes subtipos clínico-patológicos de melanoma maligno se caracteriza por no estar relacionado con la exposición a radiación ultravioleta y ser el subtipo proporcionalmente más común en poblaciones hispanoamericanas y de etnia no caucásica?

A) Melanoma de extensión superficial
B) Melanoma nodular
C) Léntigo maligno melanoma
D) Melanoma lentiginoso acral
E) Melanoma desmoplásico

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.1.017

4. En el informe histológico de un melanoma maligno, ¿cuál es el factor pronóstico individual más importante para determinar el riesgo de metástasis y la sobrevida en estadios clínicos iniciales?

A) El diámetro clínico mayor de la lesión
B) El nivel de invasión anatómica de Clark
C) El espesor tumoral microtumoral medido en milímetros según el Índice de Breslow
D) La intensidad de la pigmentación melánica tumoral
E) La presencia de infiltrado inflamatorio perilesional

Más preguntas online de Melanoma Maligno →

16.14. Carcinomas Cutáneos No Melanoma: Carcinoma Basocelular (CBC) vs Carcinoma Espinocelular (CEC)

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 6.01.1.003 6.01.3.001

¿POR QUÉ?

El cáncer de piel no melanoma comprende los tumores malignos más frecuentes en el ser humano. El carcinoma basocelular (CBC, 75-80%) y el carcinoma espinocelular o escamoso (CEC, 20%) difieren profundamente en su comportamiento biológico y semiología. En el EUNACOM se evalúa con gran constancia la identificación clínica: la lesión perlada con telangiectasias del CBC (que prácticamente nunca da metástasis a distancia, pero genera destrucción local severa) versus la lesión queratósica o ulcerada de base indurada del CEC (que sí tiene potencial de invasión perineural y metástasis a ganglios regionales, especialmente si asienta en labio inferior u oreja).

1. CARCINOMA BASOCELULAR (CBC): CLÍNICA Y VARIANTES

• **Epidemiología:** Es el cáncer cutáneo más frecuente (80% de los no melanoma). Deriva de células pluripotenciales de la capa basal de la epidermis. **(ver Imagen 16.14A y C)** 6.01.1.003

• **Fisiopatología:** Asociado a quemaduras solares agudas intermitentes en la infancia/adolescencia y a mutaciones en la vía Sonic Hedgehog (PTCH1).

• **Clínica Cardinal:** Pápula o nódulo de aspecto **perlado o translúcido, brillante, con telangiectasias superficiales ramificadas** y bordes arrollados o acordonados. Con el tiempo suele ulcerarse centralmente (úlcera de Rodent o nódulo-ulcerativo). **(ver Imagen 16.14B)**

• **Subtipos:** Nódulo-ulcerativo (el más común, 60%), superficial (placa eritematosa descamativa en tronco), morfeiforme o esclerosante (placa amarillenta similar a cicatriz, bordes infiltrativos mal definidos, el más agresivo localmente).

• **Comportamiento Biológico: Riesgo de metástasis prácticamente nulo (< 0.01%)**. Sin embargo, si se deja evolucionar sin tratamiento, produce invasión y destrucción tisular local masiva (cartílago, hueso, órbita).

2. CARCINOMA ESPINOCELULAR (CEC): CLÍNICA Y FACTORES DE ALTO RIESGO

• **Epidemiología:** Segundo cáncer de piel más común (20%). Deriva de los queratinocitos de la capa espinosa. 6.01.1.003

• **Fisiopatología:** Asociado a la **dosis acumulativa total de radiación ultravioleta** a lo largo de toda la vida (típico de trabajadores al aire libre), a inmunosupresión crónica (trasplantados renales: riesgo 65 veces mayor) e infección por VPH.

• **Lesión Precursora Clásica:** La **queratosis actínica** es su precursor obligado más común.

• **Clínica Cardinal:** Pápula, placa o nódulo indurado, eritematoso, cubierto de **escama gruesa o hiperqueratosis hiperadherente, que sangra con el roce o se ulcera** sobre una base firme e infiltrada.

• **Localizaciones de Alto Riesgo: Labio inferior (queilitis actínica)**, pabellón auricular y cuero cabelludo calvo.

• **Comportamiento Biológico:** A diferencia del CBC, el CEC **SÍ tiene capacidad de invasión perineural y de diseminación metastásica linfática regional (2-5% en piel sana, pero hasta 15-20% en labio y pabellón auricular)**.

3. TRATAMIENTO, DERIVACIÓN Y FOTOPROTECCIÓN DEL CÁNCER DE PIEL NO MELANOMA

Sospecha, tratamiento inicial y derivación. El médico general sospecha por la clínica, toma una biopsia (punch o incisional) si hay dudas y **deriva**; no cauteriza ni congela a ciegas una lesión sin diagnóstico porque impide el estudio histológico. El tratamiento definitivo es **quirúrgico**: escisión con márgenes (cerca de 4 mm en el CBC de bajo riesgo y de 4 a 6 mm en el CEC de bajo riesgo, 6 a 10 mm si es de alto riesgo) o **cirugía micrográfica de Mohs** cuando el tumor está en la «zona H» de la cara (nariz, párpados, labios, orejas), es recurrente, de subtipo morfeiforme o infiltrante, mayor de 2 cm o en inmunosuprimidos. En el CBC superficial de bajo riesgo hay alternativas no quirúrgicas: imiquimod 5%, 5-fluorouracilo tópico, crioterapia, curetaje con electrodesecación y terapia fotodinámica; la radioterapia se reserva para quienes no pueden operarse. Para tumores avanzados existen inhibidores de la vía Hedgehog (vismodegib) en el CBC y cemiplimab (anti-PD-1) en el CEC. El CEC se deriva con prioridad por su potencial metastásico, igual que toda lesión de cara o de un paciente trasplantado. Seguimiento: control cutáneo completo anual (cada 6 meses en los primeros 2 años del CEC o alto riesgo), pues cerca de 40% desarrolla otro cáncer de piel en 5 años. 6.01.1.003

Fotoprotección (prevención primaria). La radiación ultravioleta B causa quemadura solar y cáncer; la A, envejecimiento e inmunosupresión cutánea. Chile tiene un índice UV muy alto en verano por la menor capa de ozono, por lo que se educa desde la infancia, etapa en que las quemaduras solares aumentan el riesgo de melanoma. Las medidas son: **evitar la exposición directa entre las 10 y las 16 horas**, buscar la sombra, usar ropa de manga larga, sombrero de ala ancha y lentes con filtro UV, y aplicar un **protector solar de amplio espectro (UVA y UVB) con FPS 30 o más, idealmente 50**, en cantidad suficiente (cerca de una cucharadita para cara y cuello) **15 a 30 minutos antes de salir y reaplicarlo cada 2 horas** y después de sudar o bañarse. En menores de 6 meses se evita el sol directo y se prefiere la ropa y la sombra. Se desaconsejan las camas solares (carcinógeno del grupo 1 de la OMS). Se enseña el autoexamen de piel y se hace examen cutáneo anual en pacientes de alto riesgo: fototipos I y II, muchos nevos, antecedente de quemaduras, antecedente personal o familiar de cáncer de piel e inmunosupresión. 6.01.3.001



A. BASOCELULAR NODULAR



B. ÚLCERA DE RODENT



C. ESPINOCELULAR

Imagen 16.14

FIGURA 16.14 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ENTRE CARCINOMA BASOCELULAR Y ESPINOCELULAR



TABLA 16.14 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: CARCINOMA BASOCELULAR VS CARCINOMA ESPINOCELULAR 6.01.1.003, 6.01.3.001

PARÁMETRO	CARCINOMA BASOCELULAR (CBC)	CARCINOMA ESPINOCELULAR (CEC)
Frecuencia Relativa	75 - 80% (el más frecuente)	15 - 20%
Lesión Precursora	Ninguna conocida (aparece de novo)	Queratosis actínica / Queilitis actínica
Aspecto Clínico Típico	Pápula translúcida perlada con telangiectasias y borde arrollado	Placa/nódulo queratósico costroso indurado o cuerno cutáneo
Compromiso de Mucosas	Excepcional (nunca en mucosas puras)	Frecuente (labio inferior, lengua, mucosa genital)
Riesgo de Metástasis	Prácticamente nulo (< 0.01%)	Significativo (2 - 5% en piel, > 15% en labio/oreja)
Tratamiento Estándar	Extirpación con margen 4-5 mm o Mohs	Extirpación con margen 5-10 mm + evaluación ganglionar

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 16.14

Hombre de 66 años, agricultor retirado, consulta por una lesión en la mejilla derecha de 1 año de evolución que sangra ocasionalmente al lavarse la cara. Al examen físico se aprecia una pápula brillante de 7 mm de diámetro, de tonalidad perlada translúcida, con borde levemente solevantado y finas telangiectasias ramificadas arboriformes en su superficie, con una pequeña costra central hemática. No se palpan adenopatías en el cuello.

Conducta oficial. El cuadro es semiológicamente clásico de un Carcinoma Basocelular nódulo-ulcerativo (pápula perlada con telangiectasias y ulceración central en zona fotoexpuesta en paciente mayor con daño solar). La conducta adecuada es realizar una biopsia diagnóstica (o extirpación quirúrgica completa con margen oncológico de 4 mm), lo que brinda una tasa de curación superior al 95%.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- El Carcinoma Basocelular (CBC) es el cáncer cutáneo más frecuente de todos; se caracteriza por pápula perlada con telangiectasias.
- El CBC tiene un riesgo de metástasis prácticamente nulo (<0.01%), pero gran poder de destrucción local invasiva.
- El Carcinoma Espinocelular (CEC) se manifiesta como nódulo o placa queratósica descamativa indurada sobre queratosis actínica previa.
- El CEC SÍ tiene potencial metastásico linfático regional (2-5% habitual, hasta 15% en labio inferior y pabellón auricular).
- Los pacientes con trasplante de órganos bajo inmunosupresión crónica tienen un riesgo masivamente aumentado de CEC agresivo.
- La Cirugía Micrográfica de Mohs es el tratamiento de elección para tumores en áreas cosméticamente críticas faciales o con bordes mal definidos.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 16.14

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.1.003

1. Un hombre de 68 años presenta en la punta nasal una lesión papular de 6 mm de diámetro, de coloración blanquecina perlada translúcida, de bordes redondeados solevantados, con presencia de finas telangiectasias en su superficie y una úlcera milimétrica en el centro. ¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable?

A) Carcinoma basocelular nódulo-ulcerativo
B) Carcinoma espinocelular queratoacantoma
C) Melanoma amelanótico de extensión superficial
D) Queratosis seborreica irritada
E) Lupus eritematoso discoide crónico

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.1.003

2. Una mujer de 72 años consulta por una lesión en el labio inferior que no cicatriza desde hace 6 meses. Al examen se observa una placa de 12 mm, de base indurada e infiltrada, con superficie ulcerada y cubierta de costra hiperqueratósica amarillenta adherente, que sangra al desprendimiento. ¿Cuál es el diagnóstico clínico más probable?

A) Carcinoma basocelular superficial
B) Carcinoma espinocelular infiltrante
C) Herpes labial recidivante crónico
D) Aftosis oral recurrente mayor de Sutton
E) Queilitis angular bacteriana

Más preguntas online de Carcinomas Cutáneos No Melanoma →

16.15. Lesiones Cutáneas Premalignas: Queratosis Actínica, Cuerno Cutáneo y Nevos Displásicos

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 6.01.1.029

¿POR QUÉ?

La queratosis actínica (QA) es la lesión cutánea premaligna más frecuente en la práctica médica. Representa la proliferación intraepidérmica clonal de queratinocitos atípicos inducida por radiación UV acumulativa; si no se trata, entre un 5% y 20% evoluciona a carcinoma espinocelular invasor. El EUNACOM evalúa: 1) su semiología clásica, donde la lesión muchas veces "se palpa mejor de lo que se ve" como una superficie áspera o en papel de lija; y 2) las modalidades de tratamiento, distinguiendo la crioterapia para lesiones aisladas del tratamiento de campo de cancerización con fármacos tópicos (Imiquimod al 5% o 5-Fluorouracilo en crema).

1. QUERATOSIS ACTÍNICA: FISIOPATOLOGÍA Y SEMIOLOGÍA

• **Fisiopatología:** Proliferación de queratinocitos displásicos 6.01.1.029 en la epidermis basal debido a mutaciones inducidas por radiación UVB en el gen supresor tumoral **TP53**. Se considera biológicamente un carcinoma espinocelular in situ incipiente. **(ver Imagen 16.15C)**

• **Semiología Clásica:** Mácula o pápula eritematosa mal delimitada, cubierta por una escama seca o costra rugosa amarillenta o blanquecina muy adherente. *Aforismo clínico:* **"La queratosis actínica se palpa antes de verse"**; al pasar la yema del dedo sobre la piel se percibe una aspereza característica idéntica a **papel de lija**. **(ver Imagen 16.15A)**

• **Localizaciones Predilectas:** Cara (frente, mejillas, nariz), pabellones auriculares, dorso de manos, antebrazos y cuero cabelludo calvo en hombres.

• **Cuerno Cutáneo:** Protrusión cónica hiperqueratósica compacta que semeja un pequeño cuerno. No es un diagnóstico histológico sino una descripción morfológica; en su base suele esconderse una queratosis actínica (60%), una verruga viral o un carcinoma espinocelular invasor (20%). **(ver Imagen 16.15B)**

2. TRATAMIENTO FOCAL VS TRATAMIENTO DE CAMPO DE CANCERIZACIÓN

• **Tratamiento de Lesiones Aisladas (Focal):** 6.01.1.029

- **Crioterapia con Nitrógeno Líquido (-196 °C):** Método físico de elección para lesiones únicas o escasas. Produce necrosis celular por congelación rápida y descongelación lenta.

• **Concepto de "Campo de Cancerización":** Se refiere al área de piel fotoexpuesta que rodea a las queratosis visibles, la cual presenta alteraciones genéticas subclínicas idénticas predisponentes a la formación continua de nuevos tumores.

• **Tratamientos Tópicos de Campo:**

- **Imiquimod al 5% en crema:** Modificador de la respuesta inmunológica (agonista de receptores TLR-7). Induce respuesta inflamatoria con necrosis selectiva de células displásicas.

- **5-Fluorouracilo (5-FU) al 5% en crema:** Antimetabolito que inhibe la timidilato sintasa, bloqueando la síntesis de ADN en células con alta tasa de división.

- **Terapia Fotodinámica (TFD):** Aplicación de ácido metilaminolevulinato (MAL) seguido de iluminación con luz roja.

3. ENFERMEDAD DE BOWEN (CARCINOMA ESPINOCELULAR IN SITU)

La **enfermedad de Bowen** es un carcinoma espinocelular **in situ** (la displasia compromete todo el espesor de la epidermis sin invadir la dermis). Clínicamente es una **placa eritematosa, bien delimitada, escamosa o costrosa, solitaria y de crecimiento lento** (años), en áreas fotoexpuestas, sobre todo piernas de mujeres y cabeza y cuello. Su error clásico es tratarla como eccema numular, psoriasis o tiña: **toda placa solitaria que no responde a corticoides ni a antifúngicos debe biopsiarse**. Sus causas son la radiación UV, el **arsénico** (exposición crónica en aguas del norte de Chile, con queratosis palmoplantares y lesiones múltiples), el VPH 16 en la región genital (papulosis bowenoide y eritroplasia de Queyrat en el glande, con mayor riesgo de invasión) y la inmunosupresión. Hasta 3 a 5% progresa a carcinoma espinocelular invasor, por lo que se trata. Manejo: sospecha clínica, biopsia y tratamiento inicial por el médico general o derivación, con opciones de **escisión con margen, curetaje y electrodesecación, crioterapia, 5-fluorouracilo 5% o imiquimod tópicos y terapia fotodinámica**; el seguimiento es anual con examen completo de la piel. La queratosis actínica, en cambio, es una lesión premaligna que no compromete todo el espesor epidérmico. 6.01.1.029



Enfermedad de Bowen: placa eritematosa, escamosa y bien delimitada en la pierna



A. QUERATOSIS ACTÍNICA



B. CUERNO CUTÁNEO



C. NEVOS DISPLÁSICOS

Imagen 16.15

FIGURA 16.15 · DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LESIONES PREMALIGNAS CUTÁNEAS



TABLA 16.15 · MODALIDADES TERAPÉUTICAS EN QUERATOSIS ACTÍNICAS

6.01.1.029

MODALIDAD	FÁRMACO / TÉCNICA	INDICACIÓN CLÍNICA	EFECTO ADVERSO ESPERABLE
Terapia Dirigida a Lesión	Crioterapia con Nitrógeno Líquido	Lesiones aisladas, gruesas o hiperqueratósicas	Ampolla, costra, hipopigmentación residual
Terapia de Campo Tópica	Imiquimod al 5% crema (2-3 veces/sem x 4-6 sem)	Múltiples lesiones en área extensa (frente/cuero cabelludo)	Eritema intenso, erosiones, costras (señal de eficacia)
Terapia de Campo Tópica	5-Fluorouracilo (5-FU) 5% crema (2 veces/día x 3-4 sem)	Múltiples lesiones en cara y dorso de manos	Inflamación marcada, descamación, ardor
Cirugía / Biopsia	Biopsia excisional o curetaje	Lesión con base indurada, dolor o rápido crecimiento	Cicatriz (descartar carcinoma espinocelular invasor)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 16.15

Hombre de 70 años, calvo, aficionado a la jardinería, consulta porque nota la piel de su cuero cabelludo y frente "áspera y con pequeñas escamas que reaparecen al rascarlas". Al examen dermatológico, la piel de la región frontal y vértex presenta múltiples máculas eritematosas poco delimitadas de 3 a 6 mm cubiertas por escamas secas adherentes que al tacto se perciben ásperas como papel de lija. Ninguna lesión presenta induración en la base ni sangrado espontáneo.

Conducta oficial. El cuadro corresponde a queratosis actínicas múltiples en el contexto de un campo de cancerización en cuero cabelludo y frente fotoexpuestos. El tratamiento de elección consiste en combinar medidas destructivas focales (crioterapia con nitrógeno líquido para las lesiones más engrosadas) con tratamiento médico del campo de cancerización mediante Imiquimod al 5% o 5-Fluorouracilo tópico, asociado a educación rigurosa en fotoprotección diaria con FPS ≥ 50+.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- La queratosis actínica es la lesión premaligna cutánea más común y es precursora directa del Carcinoma Espinocelular.
- Clínicamente se caracteriza por máculas eritematosas con escamas secas adherentes que al tacto se sienten ásperas como papel de lija.
- La presencia de induración en la base de una queratosis actínica obliga a sospechar progresión a carcinoma espinocelular invasor y realizar biopsia.
- El cuerno cutáneo es una hiperqueratosis compacta en cuya base frecuentemente subyace una queratosis actínica o un CEC.
- Para lesiones múltiples en una zona fotoexpuesta extensa se debe tratar el 'campo de cancerización' con Imiquimod o 5-Fluorouracilo tópico.
- La crioterapia con nitrógeno líquido es la terapia de primera línea para lesiones individuales aisladas.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 16.15

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.1.029

1. Un hombre de 65 años presenta en la frente y dorso de manos varias máculas eritematosas milimétricas cubiertas por escamas ásperas muy adherentes, que al frotarlas suavemente con el dedo se sienten rugosas como lija. No hay induración ni signos inflamatorios profundos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Queratosis actínicas
B) Queratosis seborreicas
C) Psoriasis vulgar
D) Lupus eritematoso discoide
E) Linfoma cutáneo de células T

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.1.029

2. ¿Cuál de los siguientes fármacos tópicos está indicado para el tratamiento del "campo de cancerización" en pacientes con múltiples queratosis actínicas faciales?

A) Clobetasol propionato al 0.05% en crema
B) Imiquimod al 5% en crema
C) Mupirocina al 2% en ungüento
D) Ketoconazol al 2% en crema
E) Metronidazol al 0.75% en gel

Más preguntas online de Lesiones Cutáneas Premalignas →

16.16. Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

CÓDIGO PERFIL V3 6.01.1.018 | 6.01.1.027 | 6.01.1.019 | 6.01.4.004 | 2.01.1.109 | 2.01.1.110 | 1.04.4.003 | 6.01.1.022 | 6.01.1.023 | 6.01.4.001

¿POR QUÉ?

Las infecciones fúngicas superficiales y las ectoparasitosis son motivos de consulta diarios en la atención primaria y hospitalaria chilena. El EUNACOM evalúa sistemáticamente: 1) el diagnóstico de las dermatofitosis (placa anular de centro claro con borde circinado eritematoescamoso activo); 2) el tratamiento de la Tiña Capitis, que SIEMPRE requiere antimicóticos orales (griseofulvina o terbinafina oral) ya que los tópicos no penetran el folículo piloso; 3) el diagnóstico de la escabiosis (prurito de predominio nocturno y surcos en pliegues interdigitales); y 4) el pilar del tratamiento de la escabiosis con permetrina al 5% aplicada desde el cuello a los pies con indicación simultánea obligatoria a TODOS los convivientes, tengan o no síntomas.

1. MICOSIS SUPERFICIALES: DERMATOFITOSIS Y PITIRIASIS VERSICOLOR

• **Dermatofitosis (Tiñas):** Producidas por hongos filamentosos queratinofílicos (*Trichophyton*, *Microsporum*, *Epidermophyton*). 6.01.1.018 | 2.01.1.110

- **Tiña del Cuerpo (Tinea corporis):** Placas anulares u ovales eritematodescamativas con **borde activo solevantado microvesiculoso** y centro que aclara ("lesión en diana o anillo"). **(ver Imagen 16.16A)**

- **Tiña Inguinal (Tinea cruris):** Placa eritematosa bilateral en pliegues inguinales que **RESPETA el escroto** (a diferencia del intértrigo candidiásico, que compromete escroto con lesiones satélites).



Tiña cruris

- **Tiña del Pie (Tinea pedis / "Pie de Atleta"):** Maceración y fisuración interdigital (4° espacio) o patrón descamativo en mocasín. **(ver Imagen 16.16B)**

- **Tiña de la Cabeza (Tinea capitis):** Exclusiva de niños. Placas alopécicas con pelos rotos "en sacapuntas" y escamas. **REGLA DE ORO EUNACOM: El tratamiento SIEMPRE es sistémico por vía oral (Griseofulvina 20-25 mg/kg/día por 6-8 semanas o Terbinafina oral). Los antimicóticos tópicos son ineficaces. (ver Imagen 16.16C)**

• **Pitiriasis Versicolor:** Causada por la levadura lipofílica *Malassezia globosa/furfur*. Máculas hipo o hiperpigmentadas con fina descamación furfurácea al raspado (**signo de la uñada o de Besnier**) en tronco superior y cuello. Diagnóstico con KOH: imagen en "albóndigas con espaguetis" (hifas cortas y esporas redondas). Tratamiento: Ketoconazol shampoo al 2% o Terbinafina tópica. 6.01.1.018 | 2.01.1.110 | 6.01.4.004

2. ECTOPARASITOSIS: ESCABIOSIS (SARNA) Y PEDICULOSIS

• **Escabiosis (Sarna Humana):** Infestación por el ácaro *Sarcoptes scabiei var. hominis*. 6.01.1.027 | 2.01.1.109

- **Clínica Cardinal: Prurito de predominio nocturno intenso** e intratable, que afecta a varios miembros del grupo familiar.

- **Lesiones Patognomónicas: Surco acariano** (línea serpinginosa milimétrica) y **vesícula perlada** en su extremo. Localizaciones predilectas: **espacios interdigitales de manos, cara anterior de muñecas**, pliegues axilares, areolas mamarias en mujeres y genitales externos en hombres (nódulos escabióticos pruriginosos en escroto y pene). Respeta cabeza y espalda en adultos (puede afectar cuero cabelludo y palmas/plantas en lactantes).



Surco acarino interdigital con vesícula perlada

- **Tratamiento de Elección: Permetrina al 5% en crema**. Aplicar desde el cuello hacia abajo (en lactantes incluir cuero cabelludo) cubriendo toda la superficie corporal; dejar actuar 8 a 12 horas y retirar con ducha. Repetir a los 7 días (para eliminar ácaros eclosionados de huevos residuales). Alternativa oral: **Ivermectina oral 200 mcg/kg** (dosis única, repetir a los 7-14 días; contraindicada en < 15 kg y embarazadas).

- **REGLA FUNDAMENTAL DE ÉXITO: Tratar simultáneamente a TODOS los miembros del hogar y contactos íntimos**, presenten o no síntomas. Lavar ropa de vestir y ropa de cama usada las últimas 48-72 h con agua caliente (> 60 °C) o guardarla en bolsas plásticas cerradas herméticamente durante 3 a 5 días (el ácaro no sobrevive más de 48-72 h fuera del huésped).

• **Pediculosis:** Infestación por *Pediculus humanus capitis* (piojo de la cabeza), *corporis* o *Phthirus pubis* (ladilla). Tratamiento: Permetrina al 1% loción en cuero cabelludo seco por 10 minutos + remoción mecánica de liendres con peine metálico fino; repetir a los 7 días. 6.01.1.019 | 2.01.1.109

3. EXÁMENES EN DERMATOLOGÍA INFECCIOSA: KOH, CULTIVO DE HONGOS Y ACAROTEST

Examen micológico directo con KOH (interpreta y emplea). 6.01.4.004
Se indica en tiñas, onicomicosis (siempre se confirma antes de un tratamiento oral prolongado), pitiriasis versicolor y candidiasis. Toma de la muestra: limpiar con alcohol 70% y dejar secar, **raspar con bisturí N° 15 el borde activo de la lesión** (no el centro), en la uña recoger el detritus subungueal de la zona proximal del área enferma y en el cuero cabelludo **arrancar los pelos rotos** y las escamas. El material se coloca en un portaobjetos con 1 a 2 gotas de **KOH al 10 a 20%** (40% en uñas y pelos), se cubre con cubreobjetos, se calienta suavemente sin hervir o se espera 10 a 20 minutos y se observa a 10 y 40 aumentos. Los dermatofitos se ven como **hifas hialinas septadas, ramificadas, de grosor uniforme**, con artroconidias; en la tiña capitis las esporas pueden estar dentro del pelo (endotrix, *Trichophyton tonsurans*) o alrededor (ectotrix, *Microsporum*); la pitiriasis versicolor muestra hifas cortas y gruesas con esporas redondas («espaguetis con albóndigas») y *Candida*, levaduras con pseudohifas y gemación. Puede haber falsos negativos si se usó un antifúngico tópico en las últimas 2 semanas u oral en las últimas 4, y artefactos (bordes celulares o fibras de algodón) que simulan hifas. La lámpara de Wood da fluorescencia verde-amarilla en *Microsporum* y color coral en el eritrasma.

Cultivo de hongos (interpreta y emplea). Se siembra el raspado en **agar Sabouraud con cloranfenicol** (con o sin cicloheximida) y se incuba a 25 a 30 °C por **2 a 4 semanas** (hasta 6 en uñas); la especie se identifica por la colonia y la microscopía. Se pide en la **tiña capitis** (el género decide el fármaco: *Microsporum* responde mejor a griseofulvina y *Trichophyton* a terbinafina), en la onicomicosis antes de un tratamiento sistémico, con KOH negativo y alta sospecha, en formas extensas o refractarias y en brotes en colectividades para buscar la fuente zoofílica (gatos, perros, cobayos con *M. canis*). Interpretación: el aislamiento de un **dermatofito** confirma la infección; los hongos filamentosos no dermatofitos o contaminantes (*Aspergillus*, *Penicillium*) solo cuentan si se aíslan en forma repetida con KOH positivo, y *Candida* en piel o uñas debe correlacionarse con la clínica porque puede ser colonización. 1.04.4.003

Acarotest (realiza, interpreta y emplea). Es el examen directo de la escabiosis. Se elige un **surco o una vesícula perlada reciente y no excoriada** (espacios interdigitales, muñecas), se pone una gota de aceite mineral o de KOH, se raspa con bisturí N° 15 hasta un mínimo de sangrado y se lleva al portaobjetos. Al microscopio (10 aumentos) se ve el **ácaro adulto** (0,3 a 0,4 mm, ovalado, de 8 patas), los **huevos** y los **escíbalos** (heces, bolitas pardas). Una variante es la prueba de la tinta: se pinta el surco con tinta y se limpia con alcohol, y la tinta delimita su trayecto; la dermatoscopía muestra el signo del «ala delta». Un resultado negativo **no descarta sarna** (hay pocos ácaros por paciente): si la clínica y la epidemiología son compatibles se trata. En la sarna costrosa o noruega, de inmunodeprimidos y ancianos, hay miles de ácaros y gran contagiosidad: se aísla, se deriva y se asocia ivermectina oral a la permetrina. 6.01.4.001

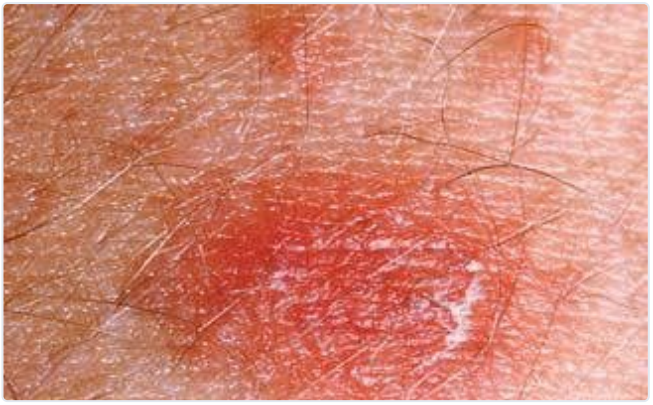
4. PEDICULOSIS: PIOJO DE LA CABEZA, DEL CUERPO Y LADILLA

Existen tres entidades. **Pediculosis capitis** (*Pediculus humanus capitis*): afecta a escolares de 3 a 12 años por contacto directo cabeza con cabeza (los piojos no saltan ni vuelan y sobreviven 1 a 2 días fuera de la cabeza); produce **prurito intenso en la nuca y detrás de las orejas**, excoriaciones, impétigo secundario y adenopatías occipitales y retroauriculares. El diagnóstico se hace al ver el piojo vivo o **liendres adheridas al pelo a menos de 6 mm del cuero cabelludo**, que no se desprenden al sacudirlas (la caspa sí cae); el peine fino sobre cabello húmedo es la mejor técnica. **Pediculosis corporis** (*P. h. corporis*): el piojo vive en las costuras de la ropa y se asocia a hacinamiento y falta de higiene; produce excoriaciones lineales en tronco, hombros y cintura y, crónicamente, hiperpigmentación; es vector de *Rickettsia prowazekii* (tifus epidémico), *Bartonella quintana* (fiebre de las trincheras) y fiebre recurrente; el tratamiento es lavar la ropa a más de 60 °C y cambiarla. **Pediculosis pubis o ladilla** (*Phthirus pubis*): infección de transmisión sexual con prurito púbico y a veces máculas azuladas (cerúleas) en muslos y abdomen; en pestañas de un niño obliga a descartar abuso sexual. Se estudian otras ITS y se trata a los contactos. 6.01.1.019

Tratamiento de la pediculosis (nivel completo). Primera línea en la cabeza: **permetrina 1% loción durante 10 minutos sobre el cabello húmedo**, repetida a los 7 a 10 días para eliminar las ninfas que nacen de las liendres; si hay resistencia a piretroides, **dimeticona 4%** (se deja actuar varias horas y se repite a los 7 a 9 días); ivermectina oral 200 µg/kg en dos dosis en casos refractarios. Se retiran las liendres con peine fino, se lavan peines y ropa de cama a más de 60 °C o se guardan en bolsa cerrada por 48 horas, y **se examina y trata solo a los contactos infestados**. No es necesario cortar el pelo ni excluir al niño de clases tras iniciar el tratamiento, ni fumigar el ambiente. En la ladilla se usa permetrina 1% por 10 minutos, y en las pestañas, vaselina oftálmica dos a tres veces al día.

5. PITIRIASIS ROSADA DE GILBERT

Es un exantema **autolimitado** de adultos jóvenes (10 a 35 años), más frecuente en primavera y otoño, probablemente por reactivación del herpesvirus 6 y 7. Comienza con la **placa heráldica o «medallón»**: una placa oval de 2 a 5 cm, rosada, con un **collarete de fina descamación en su borde interno**, en el tronco. A los 1 a 2 semanas aparecen placas ovaladas más pequeñas, rosadas, con escama periférica, cuyo eje mayor sigue las líneas de Langer y dibuja la distribución **«en árbol de Navidad»** en la espalda; el prurito es leve a moderado. Habitualmente respeta cara, palmas y plantas. Dura 6 a 8 semanas (hasta 12) y remite sin cicatriz. Diagnóstico diferencial importante: **sífilis secundaria** (compromiso palmoplantar, adenopatías; se pide VDRL o RPR a todo paciente sexualmente activo con exantema similar), tiña corporis (KOH), psoriasis en gotas, dermatitis seborreica, exantema por fármacos (captopril, AINE, isotretinoína) y eccema numular. Tratamiento: explicar la evolución benigna, emolientes, antihistamínicos orales y corticoide tópico de potencia media para el prurito, y evitar los baños muy calientes; en casos extensos o precoces puede usarse aciclovir en dosis altas o fototerapia UVB por el especialista. Se deriva si ocurre en el primer trimestre del embarazo, por su asociación a aborto y parto prematuro. 6.01.1.022



Placa heráldica de la pitiriasis rosada: placa oval con fina descamación en el borde interno

6. PRÚRIGO INFANTIL AGUDO Y PICADURAS DE INSECTOS

El **prúrigo infantil agudo** (estrófulo, urticaria papular) es una reacción de hipersensibilidad a las picaduras de insectos (pulgas de mascotas, chinches de cama, mosquitos) en niños de 2 a 7 años. Se presenta con **pápulas y pápulo-vesículas muy pruriginosas con un punto central hemorrágico o costroso**, a veces ampollas, en brotes sobre extremidades y zonas expuestas, nalgas y tronco; en cada brote hay lesiones de distintas edades, y el rascado produce excoriaciones e **impétigo secundario**. Las chinches suelen dejar tres lesiones alineadas («desayuno, almuerzo y cena»). Desaparece hacia los 7 a 10 años por desensibilización. El diagnóstico es clínico; se diferencia de la escabiosis (surcos, pliegues, contactos familiares), la varicela (vesículas en distintos estadios con fiebre y lesiones en mucosas), el impétigo y la dermatitis atópica. Tratamiento: **control del vector** (desparasitar mascotas, lavar y aspirar ropa de cama, colchones y rincones, revisar grietas en busca de chinches), repelente con DEET en mayores de 2 meses o icaridina, mosquiteros, **corticoide tópico de potencia baja a media por 3 a 5 días** y antihistamínico oral sedante nocturno, uñas cortas y antibiótico (cefadroxilo o cloxacilina) si hay sobreinfección. Una lesión única y necrótica con dolor intenso no es prúrigo: debe pensarse en loxoscelismo (véase Tema 16.18). 6.01.1.023



A. TIÑA CORPORIS



B. TIÑA PEDIS INTERDIGITAL



C. TIÑA DE LA CABEZA

Imagen 16.16

FIGURA 16.16 · ENFRENTAMIENTO DE INFECCIONES CUTÁNEAS Y ECTOPARASITOSIS EN APS

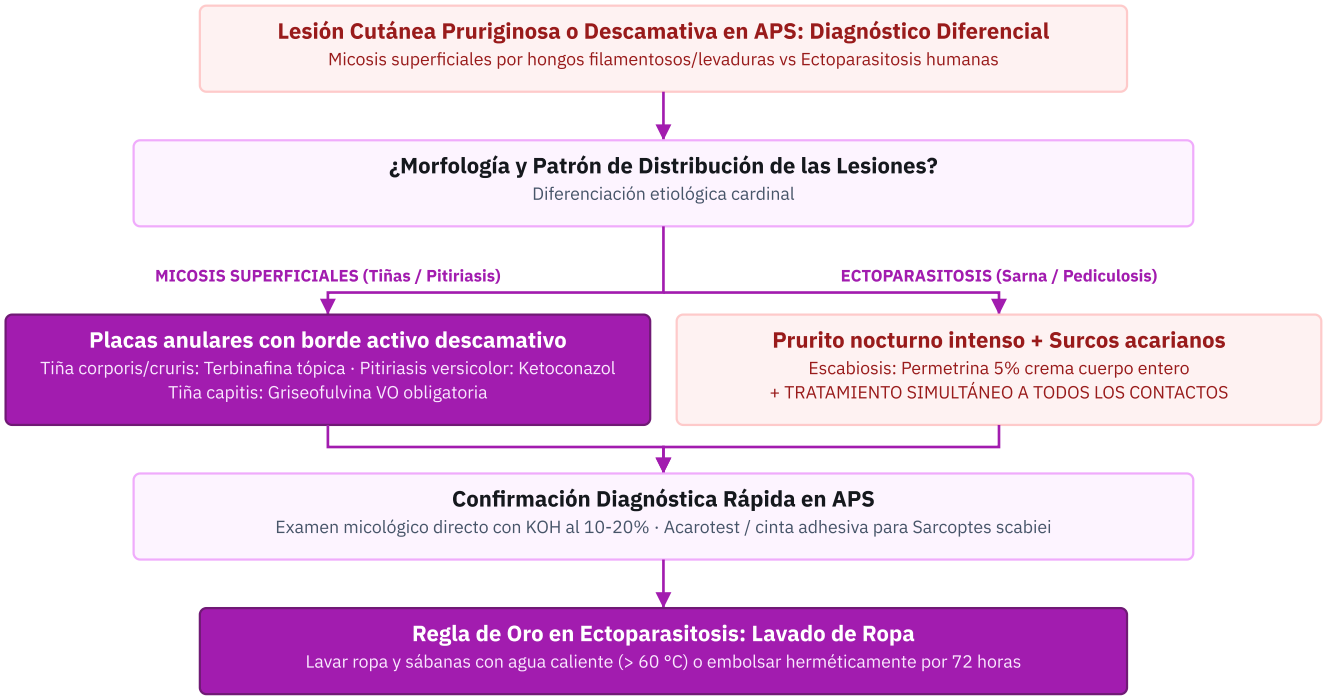


TABLA 16.16 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y TRATAMIENTO DE INFECCIONES CUTÁNEAS COMUNES

6.01.1.018, 6.01.1.027, 6.01.1.019, 6.01.4.004, 2.01.1.109, 2.01.1.110, 1.04.4.003, 6.01.1.022, 6.01.1.023, 6.01.4.001

INFECCIÓN	AGENTE CAUSAL	CLÍNICA CARDINAL	DIAGNÓSTICO DE ELECCIÓN	TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA
Tiña del Cuerpo / Pie	Trichophyton rubrum / mentagrophytes	Placa anular borde activo descamativo	Clínica + Examen directo KOH	Terbinafina tópica 1% c/12h x 2-3 sem
Tiña de la Cabeza	Microsporum canis / Trichophyton	Placa alopécica con pelos rotos en niños	Examen con lámpara de Wood + KOH/cultivo	GRISEOFULVINA ORAL x 6-8 semanas (No tópicos)
Pitiriasis Versicolor	Malassezia furfur / globosa	Máculas hipo/hipercrómicas descamativas	Signo de la uñada + KOH (espaguetis)	Ketoconazol shampoo 2% tópico x 2 semanas
Escabiosis (Sarna)	Sarcoptes scabiei hominis	Prurito nocturno, surcos interdigitales	Clínica + Acarotest directo	PERMETRINA 5% crema a TODOS los convivientes

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 16.16

Madre consulta con su hijo de 7 años por prurito cutáneo generalizado muy intenso de 2 semanas de evolución, que empeora marcadamente durante la noche impidiéndole dormir. Al examen físico se aprecian pápulas eritematosas escoriadas y pequeños surcos lineales en los pliegues interdigitales de ambas manos, muñecas y pliegue anterior de los codos. La madre refiere que ella y su pareja han comenzado con síntomas de picazón similar en las manos y zona genital en los últimos días.

Conducta oficial. El cuadro clínico de prurito nocturno intenso con lesiones en pliegues interdigitales y afectación de múltiples convivientes es patognomónico de escabiosis (sarna). El tratamiento de elección consiste en aplicar permetrina al 5% en crema desde el cuello hasta la punta de los pies, dejándola actuar durante 8 a 12 horas antes de lavarse, y repetir la aplicación a los 7 días. Es de vital importancia prescribir el mismo tratamiento simultáneamente a todos los miembros del hogar, sintomáticos o asintomáticos, y lavar la ropa a temperatura alta.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- La Tiña Capitis SIEMPRE requiere tratamiento antimicótico oral (Griseofulvina o Terbinafina); los antifúngicos tópicos NO curan la tiña capitis.
- La Tiña Inguinal típicamente respeta el escroto, a diferencia del intértrigo candidiásico que compromete escroto con lesiones satélites.
- La Pitiriasis Versicolor presenta el signo de la uñada positivo y en el examen con KOH se aprecian hifas y esporas ('espaguetis con albóndigas').
- El prurito nocturno intratable con surcos en espacios interdigitales y muñecas es el sello clínico de la Escabiosis.
- El tratamiento de la escabiosis es Permetrina al 5% en crema aplicada del cuello a los pies y repetida a los 7 días.
- Es una regla inaplazable tratar a TODOS los convivientes y contactos estrechos de un paciente con escabiosis de manera simultánea.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 16.16

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.1.018

1. Un escolar de 6 años es traído por su madre por presentar una placa redondeada de 4 cm en el cuero cabelludo, donde el pelo se ha caído parcialmente y los cabellos restantes se observan rotos a pocos milímetros de la superficie cutánea, con descamación superficial asociada y prurito leve. ¿Cuál es el tratamiento de elección para este paciente?

A) Ketoconazol en crema al 2% aplicado dos veces al día por 2 semanas
B) Clobetasol tópico al 0.05% por sospecha de alopecia areata
C) Griseofulvina oral a 20 mg/kg/día durante 6 a 8 semanas
D) Permetrina al 1% en loción capilar en dosis única
E) Antibioticoterapia oral con cefadroxilo por 10 días

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.1.027

2. Una mujer de 29 años consulta por intenso prurito nocturno en las manos y cuerpo de 10 días de evolución. Al examen se aprecian lesiones lineales milimétricas y pequeñas pápulas con excoriaciones en los espacios interdigitales de las manos y cara flexora de las muñecas. ¿Cuál de las siguientes medidas terapéuticas es INDISPENSABLE para lograr la erradicación del cuadro?

A) Indicar tratamiento antibiótico oral profiláctico con doxiciclina
B) Tratar simultáneamente a todos los contactos del hogar con permetrina al 5%, presenten o no síntomas
C) Indicar corticoides sistémicos a dosis altas para frenar el prurito de inmediato
D) Aplicar permetrina al 5% exclusivamente sobre las lesiones visibles de las manos
E) Desinfectar los muebles del hogar con soluciones cloradas concentradas

Más preguntas online de Infecciones Cutáneas Comunes →

16.17. Tumores Benignos de Piel, Hemangiomas Infantiles y Malformaciones Vasculares

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 6.01.1.028 6.01.1.013 2.01.1.111

¿POR QUÉ?

Las lesiones benignas de la piel son motivo frecuente de consulta y el médico general debe reconocerlas, tranquilizar al paciente y distinguir las que requieren extirpación o derivación. En el adulto dominan la queratosis seborreica, los quistes epidérmicos, el lipoma, el dermatofibroma y las cicatrices patológicas (queloide e hipertrófica). En el lactante, el hemangioma infantil es el tumor vascular más frecuente: aparece en las primeras semanas, crece durante 3 a 5 meses y luego involuciona en años; la mayoría solo se observa, pero los periorbitarios, de vía aérea, ulcerados o desfigurantes se tratan con propranolol oral y los múltiples (5 o más) obligan a descartar compromiso hepático con ecografía abdominal. Las malformaciones vasculares, en cambio, están presentes desde el nacimiento, crecen con el niño y no involucionan: la mancha salmón es benigna y desaparece, mientras la mancha en vino de Oporto de la frente y el párpado superior hace sospechar síndrome de Sturge-Weber.

1. TUMORES BENIGNOS FRECUENTES: QUERATOSIS SEBORREICA, QUISTES, LIPOMA Y DERMATOFIBROMA

Queratosis seborreica: es el tumor epitelial benigno más frecuente del adulto mayor. 6.01.1.028 Son placas o pápulas bien delimitadas, de **superficie verrugosa y untuosa, «pegadas» sobre la piel** (aspecto de stuck-on), de color café a negro, múltiples, en tronco, cara y cuero cabelludo, y respetan palmas y plantas. La dermatoscopía muestra aperturas tipo comedón, quistes tipo milia y aspecto cerebriforme. La aparición brusca de muchas lesiones con prurito (**signo de Leser-Trélat**) sugiere una neoplasia interna, sobre todo digestiva. No malignizan y no requieren tratamiento; si molestan o se inflaman se tratan con crioterapia, curetaje o shaving, y las lesiones que cambian, sangran o generan dudas con un melanoma se biopsian. **(ver Imagen 16.17A y C)**

Quistes: el **quiste epidérmico** (mal llamado «sebáceo») es un nódulo firme, móvil, con un **punctum central**, en cara, cuello y tronco, con contenido caseoso de queratina; puede inflamarse o abscedarse. El **quiste pilar** es liso, sin punctum, múltiple y familiar, y se ubica en el cuero cabelludo. El tratamiento es la **extirpación completa de la pared quística** (si queda, recidiva); durante la inflamación se indican AINE y drenaje si hay absceso, con antibiótico solo si hay celulitis, y se extirpa 4 a 6 semanas después. Los quistes epidérmicos múltiples y atípicos obligan a descartar el síndrome de Gardner (poliposis, osteomas). **(ver Imagen 16.17B)**

Lipoma: es el tumor benigno de partes blandas más frecuente: un nódulo subcutáneo **blando, lobulado, móvil, indoloro y de crecimiento lento**, de 2 a 10 cm, en tronco, cuello y extremidades. El diagnóstico es clínico y la ecografía ayuda en las dudas. Se observa o se extirpa si molesta, por estética o por incertidumbre diagnóstica. Se sospecha liposarcoma si mide más de 5 cm, es profundo (bajo la fascia), firme, fijo, doloroso o crece rápido: requiere resonancia magnética y biopsia.

Dermatofibroma: es una pápula o nódulo firme de 0,5 a 1 cm, pardo rosado, en las piernas de mujeres jóvenes, frecuentemente tras una picadura o trauma; al comprimirlo lateralmente se deprime (**signo del hoyuelo**). Es benigno y asintomático; se extirpa solo si hay duda o molestia. Otras lesiones benignas habituales son los acrocordones (fibromas blandos péndulos del cuello y las axilas, asociados a obesidad y diabetes), el angioma rubí (pápula roja brillante del adulto) y el granuloma piógeno (pápula roja friable que sangra, de crecimiento rápido tras un trauma o en el embarazo, que se trata con curetaje y electrocoagulación).

Cicatrices patológicas: la **cicatriz hipertrófica** no sobrepasa los bordes de la herida, aparece en las primeras semanas y tiende a regresar en 1 a 2 años. El **queloide sobrepasa los límites de la herida** (aspecto rojo violáceo, a veces doloroso o pruriginoso), aparece meses después, no regresa y es más frecuente en fototipos oscuros y en esternón, hombros, dorso y lóbulo de la oreja (después de perforaciones). Tratamiento: **triamcinolona intralesional** (10 a 40 mg/mL cada 4 a 6 semanas), láminas de silicona, presoterapia y crioterapia; la cirugía sola recidiva en más de la mitad de los casos y se combina con corticoide o radioterapia. Se previenen evitando cirugías electivas y perforaciones en pacientes con antecedente.

2. HEMANGIOMA INFANTIL: HISTORIA NATURAL, COMPLICACIONES Y PROPRANOLOL

El **hemangioma infantil** es el tumor vascular benigno más frecuente de la infancia (4 a 10% de los lactantes; más en prematuros, bajo peso y niñas), formado por células endoteliales **GLUT-1 positivas**. No está presente al nacer o es solo una mácula precursora pálida o telangiectásica de pocos milímetros; luego tiene una **fase de proliferación rápida durante los primeros 3 a 5 meses** (la mayor parte del tamaño se alcanza a los 3 meses), una meseta y una **involución lenta durante años** (alrededor de 50% a los 5 años y 70% a los 7). Puede dejar piel redundante, telangiectasias y tejido fibroadiposo. El hemangioma **superficial** es una placa rojo brillante «en fresa», el **profundo** un nódulo azulado bajo piel normal y el **mixto** combina ambos; el hemangioma **segmentario** sigue un territorio de desarrollo y se asocia a más complicaciones y a síndromes.



Hemangioma infantil segmentario de la hemicara derecha y el cuello en un lactante

Complicaciones y alarmas. La más frecuente es la **ulceración** (dolorosa, en pliegues, labios y zona del pañal). Los hemangiomas **periorbitarios** pueden causar ambliopía y astigmatismo; los de la «barba» o segmentarios del cuello pueden acompañar un hemangioma subglótico con estridor, tos o ronquera entre las 6 semanas y los 6 meses; los labiales dificultan la alimentación; los de la nariz o el labio pueden deformar. **Cinco o más hemangiomas cutáneos obligan a pedir una ecografía abdominal** para descartar compromiso hepático, que puede cursar con insuficiencia cardíaca de alto gasto e hipotiroidismo (se mide TSH). Un hemangioma segmentario facial grande hace sospechar el síndrome PHACE (malformación de fosa posterior, hemangioma, anomalías arteriales, cardíacas y oculares: resonancia, angiorresonancia y ecocardiograma), y uno lumbosacro en la línea media, un disrafismo espinal (ecografía o resonancia de columna).

Tratamiento. La mayoría, pequeños y sin riesgo funcional, se **observa** con fotografías seriadas y controles mensuales en la fase proliferativa. Cuando hay riesgo funcional, ulceración o desfiguración, la primera línea es **propranolol oral 2 a 3 mg/kg/día en 2 o 3 dosis** (se inicia con 1 mg/kg/día y se sube en 1 a 2 semanas), idealmente antes de los 5 meses y durante **6 a 12 meses** (suspenderlo antes produce rebote), con control de frecuencia cardíaca, presión arterial y glicemia: se da con alimentación y se suspende si el lactante tiene ayuno o vómitos por el riesgo de hipoglicemia. Está contraindicado en asma o broncoespasmo, bradicardia, bloqueo auriculoventricular, hipotensión y shock. Los hemangiomas superficiales pequeños pueden tratarse con **timolol tópico 0,5%**; el láser de colorante pulsado se usa para telangiectasias y ulceraciones, y la cirugía para las secuelas. Los corticoides sistémicos quedaron como alternativa ante contraindicación del propranolol. El médico general inicia el tratamiento con evaluación previa y **deriva** los hemangiomas periorbitarios, de la vía aérea, ulcerados, segmentarios faciales y múltiples.

6.01.1.013

3. MALFORMACIONES VASCULARES CUTÁNEAS: MANCHA SALMÓN, MANCHA EN VINO DE OPORTO Y SÍNDROMES ASOCIADOS

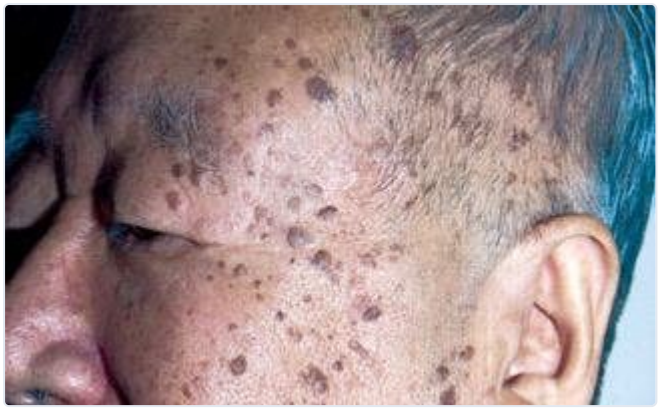
Las **malformaciones vasculares** son errores del desarrollo de los vasos **presentes desde el nacimiento** (aunque a veces se notan después), crecen proporcionalmente con el niño, **nunca involucionan** y son GLUT-1 negativas; el hemangioma, en cambio, es un tumor que aparece semanas después del parto, prolifera y luego involuciona. Se clasifican según el vaso comprometido en capilares, venosas, linfáticas, arteriovenosas y combinadas. 2.01.1.111

La **mancha salmón** (nevus simplex; «picotazo de cigüeña» en la nuca y «beso de ángel» en la frente y los párpados) es una mácula rosada mal delimitada presente en 40 a 70% de los recién nacidos, que se acentúa con el llanto; la de la frente y los párpados desaparece en 1 a 2 años y la de la nuca puede persistir. Es benigna y no requiere estudio ni tratamiento. La **mancha en vino de Oporto** (malformación capilar) es una mácula rosada a roja, bien delimitada, habitualmente unilateral en cara y cuello, que **no desaparece** y con los años se oscurece, se engruesa y puede formar nódulos, hipertrofia de partes blandas y granulomas piógenos. Su tratamiento de elección es el láser de colorante pulsado, idealmente temprano, a cargo del especialista.



Malformación capilar (mancha en vino de Oporto) de la mejilla y el cuello en un lactante de 6 meses

Síndromes asociados. La mancha en vino de Oporto que compromete la **rama oftálmica del trigémino (frente y párpado superior)** hace sospechar el **síndrome de Sturge-Weber**: malformación vascular leptomeníngea ipsilateral que produce **convulsiones**, hemiparesia y retraso del desarrollo, con calcificaciones «en vías de tren» en la imagen, y **glaucoma**; se pide resonancia con contraste y se deriva a neurología y oftalmología. En una extremidad, la combinación de malformación capilar, venosa e hipertrofia del miembro corresponde al **síndrome de Klippel-Trénaunay** (riesgo de trombosis venosa y embolia pulmonar; se estudia con Doppler). Otras malformaciones: la **venosa** es una masa azulada, blanda y compresible que aumenta al llorar o con la maniobra de Valsalva (con flebolitos); la **linfática macroquística** (higroma quístico) se asocia a síndrome de Turner y a trisomías; la **arteriovenosa** es cálida, con frémito y riesgo de sangrado. El ecodoppler o la resonancia definen si se observa, se hace escleroterapia, láser o cirugía, por lo que se derivan.



A. QUERATOSIS SEBORREICAS



B. QUISTE EPIDÉRMICO



C. LIPOMAS MÚLTIPLES

Imagen 16.17

FIGURA 16.17 · ENFRENTAMIENTO DE UNA LESIÓN VASCULAR O TUMOR BENIGNO DE PIEL

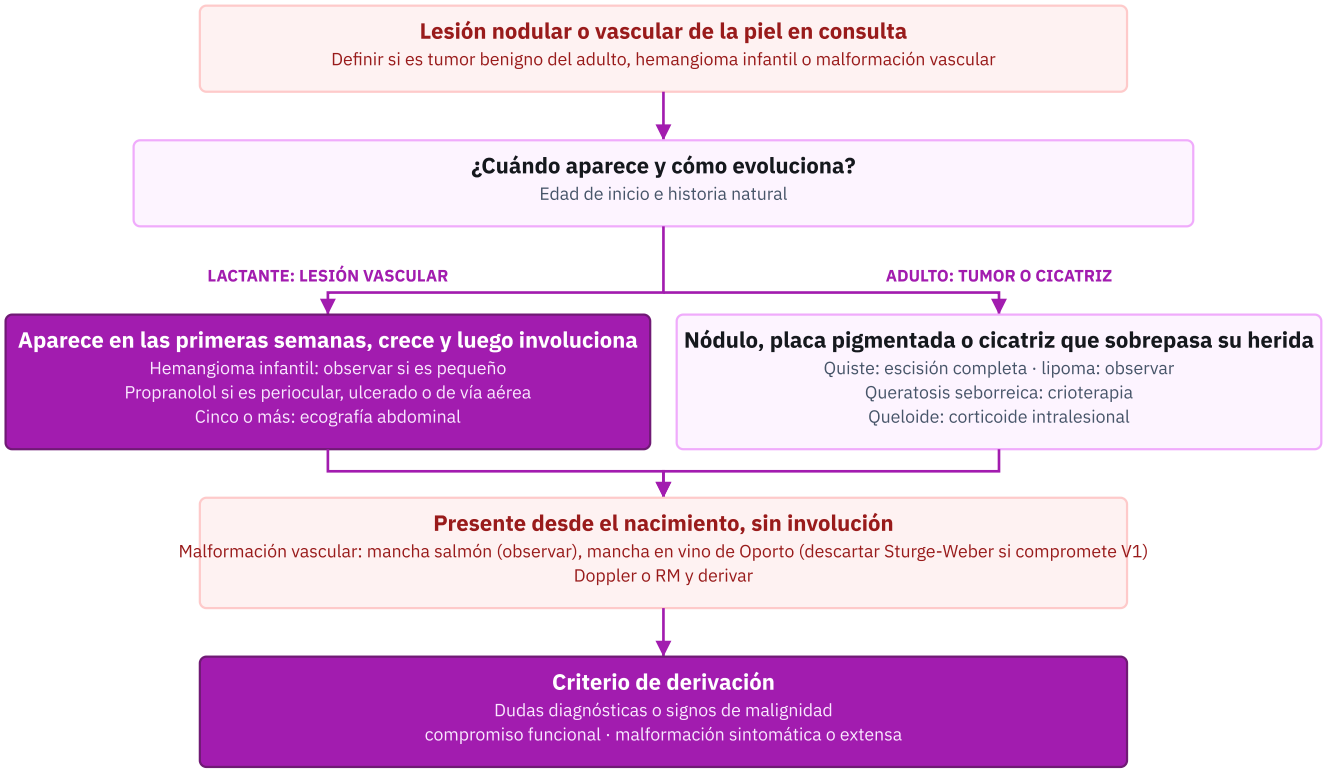


TABLA 16.17 · HEMANGIOMA INFANTIL VERSUS MALFORMACIONES VASCULARES Y LESIONES BENIGNAS FRECUENTES

6.01.1.028, 6.01.1.013, 2.01.1.111

LESIÓN	CUÁNDO APARECE / DATO CLAVE	EVOLUCIÓN	CONDUCTA EN APS
Hemangioma infantil	Semanas tras el nacimiento · GLUT-1 positivo · placa roja en fresa o nódulo azulado	Crece 3 a 5 meses y luego involuciona en años	Observar · propranolol si es periocular, ulcerado, de vía aérea o desfigurante · 5 o más: ecografía abdominal
Mancha salmón	Presente al nacer · nuca, frente y párpados · pálida con la digitopresión	Frente y párpados desaparecen en 1 a 2 años	Tranquilizar · sin estudio ni tratamiento
Mancha en vino de Oporto	Presente al nacer · unilateral en cara · no desaparece	Se oscurece y engruesa con la edad	Láser (derivar) · V1 afectado: descartar Sturge-Weber (RM, oftalmología)
Malformación venosa o linfática	Masa blanda azulada compresible o quística	Crece con el niño y no involuciona	Ecodoppler o RM · derivar
Queratosis seborreica	Adulto mayor · placa verrugosa «pegada» café a negra	Benigna, sin malignización	Observar · crioterapia si molesta · biopsia si hay duda
Quiste epidérmico	Nódulo móvil con punctum central	Puede inflamarse o abscedarse	Extirpación completa de la pared fuera de la fase inflamatoria
Lipoma	Nódulo subcutáneo blando, móvil e indoloro	Crecimiento lento	Observar o extirpar · más de 5 cm, profundo o doloroso: RM y biopsia
Queloide	Cicatriz que sobrepasa los bordes de la herida · meses después	No regresa	Triamcinolona intralesional · silicona · cirugía más corticoide

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

16.17

Madre consulta por una lesión roja y sobreelevada en la mejilla de su hija de 7 semanas, que no estaba al nacer y ha crecido rápidamente en las últimas semanas. Al examen se observa una placa rojo brillante de 2 cm, de superficie lobulada, sin ulceración, que no compromete el párpado ni la vía aérea; no hay otras lesiones cutáneas y el resto del examen es normal. La madre pregunta si debe operarse.

Conducta oficial. Se trata de un hemangioma infantil superficial: tumor vascular que aparece en las primeras semanas, crece durante los primeros meses y luego involuciona de forma espontánea. Por ser único, pequeño, sin ulceración y sin riesgo funcional (no compromete la visión ni la vía aérea), la conducta es observar con controles y fotografías seriadas y tranquilizar a la madre; no se opera. Si fuera periocular, ulcerado, de la vía aérea o desfigurante se indica propranolol oral, y si hubiera 5 o más hemangiomas se pide una ecografía abdominal para descartar compromiso hepático.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- Queratosis seborreica: placa verrugosa «pegada» del adulto mayor, benigna; la aparición brusca de muchas (Leser-Trélat) sugiere neoplasia interna.
- Quiste epidérmico: nódulo con punctum; se extirpa completo y fuera de la fase inflamatoria. Lipoma sospechoso (más de 5 cm, profundo o doloroso): resonancia y biopsia.
- Queloide sobrepasa los bordes de la herida y no regresa (triamcinolona intralesional); la cicatriz hipertrófica no los sobrepasa y tiende a regresar.
- Hemangioma infantil: no está al nacer, crece 3 a 5 meses y luego involuciona. La mayoría se observa.
- Propranolol oral (2 a 3 mg/kg/día por 6 a 12 meses) para hemangiomas periorbitarios, de vía aérea, ulcerados o desfigurantes; contraindicado en asma, bradicardia y bloqueo AV.
- Cinco o más hemangiomas cutáneos: ecografía abdominal para descartar hemangiomas hepáticos.
- Las malformaciones vasculares están presentes al nacer, no involucionan; mancha en vino de Oporto en V1 (frente y párpado superior) hace sospechar Sturge-Weber (convulsiones y glaucoma).

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 16.17

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 83

1. Una paciente de 24 años presenta una cicatriz en la zona esternal, de gran tamaño, secundaria a una cirugía torácica realizada hace 6 meses, que no ha respondido a la terapia compresiva. Al examen físico se observa una cicatriz que sobrepasa los bordes de la cirugía inicial, de aspecto rojo-violáceo y dolorosa a la palpación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Cicatriz hipertrófica en fase activa
B) Queloide
C) Cuerpo extraño
D) Úlcera de Marjolin
E) Granuloma piógeno

EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 64

2. Un paciente de 17 años consulta por un nódulo blanquecino que apareció hace 3 semanas, en una zona donde se había puesto un arete, y que ha ido aumentando de tamaño. El diagnóstico más probable es:

A) Dermatofibroma
B) Quiste dermoide
C) Neurofibroma
D) Dermatitis de contacto
E) Queloide

EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 83

3. Un recién nacido de 10 días presenta un hemangioma en el párpado derecho, de 3 cm de diámetro, que cubre parcialmente la visión. ¿Cuál es la conducta más adecuada en este momento?

A) Administrar propranolol
B) Administrar betametasona
C) Realizar embolización
D) Derivar a cirujano plástico
E) Observar evolución

EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 125

4. Un lactante de 6 meses presenta ocho hemangiomas infantiles localizados en el tronco, principalmente en la espalda. ¿Cuál es la conducta más adecuada para el manejo de este paciente?

A) Solicitar ecografía abdominal
B) Iniciar propranolol oral
C) Iniciar corticoides intralesionales
D) Solicitar una resonancia magnética de cerebro
E) Solicitar estudio de neurofibromatosis

Más preguntas online de Tumores Benignos de Piel, Hemangiomas Infantiles y Malformaciones Vasculares →

16.18. Loxoscelismo (Loxosceles laeta): Cuadro Cutáneo y Cutáneo-Visceral, Manejo y Prevención en la Vivienda

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA CÓDIGO PERFIL V3 6.01.2.008 6.01.3.002

¿POR QUÉ?

El loxoscelismo es el cuadro producido por la mordedura de la araña de rincón (Loxosceles laeta), la única araña de importancia médica que causa necrosis cutánea en Chile. Vive dentro de las casas, en rincones oscuros, tras muebles, ropa y calzado, y muerde cuando se la comprime contra la piel, de noche o al vestirse. En la mayoría de los casos produce la forma cutánea: una mordedura casi indolora que, en horas, evoluciona a una placa livedoide dolorosa con ampollas hemorrágicas y una escara negra que se desprende dejando una úlcera de cicatrización lenta. En una minoría, sobre todo niños, aparece la forma cutáneo-visceral, con hemólisis intravascular, coagulación intravascular e insuficiencia renal, que exige hospitalización. La prevención descansa en el orden, la limpieza de la vivienda y la revisión de ropa y calzado.

1. LOXOSCELES LAETA (ARAÑA DE RINCÓN): BIOLOGÍA, EPIDEMIOLOGÍA Y MECANISMO

Loxosceles laeta es una araña pardo amarillenta de cuerpo 6.01.2.008
de 8 a 15 mm y patas largas y finas, con una marca en forma de violín en el cefalotórax y seis ojos agrupados en tres pares. Es **nocturna, sedentaria y no agresiva**: vive en rincones oscuros y poco perturbados de la vivienda (tras cuadros y muebles, en closets, ropa, zapatos y grietas) y muerde solo cuando es aplastada contra la piel, de noche en la cama o al vestirse y calzarse. La mayoría de los accidentes ocurre dentro del domicilio, en la zona central del país y con mayor frecuencia entre el verano y el otoño; la picadura se ubica con frecuencia en tronco, muslos y brazos. **(ver Imagen 16.18A)**

El veneno contiene **esfingomielinasa D**, una enzima dermonecrótica que activa el complemento, los neutrófilos y las plaquetas y daña el endotelio: produce **trombosis microvascular con necrosis isquémica** de la piel y el tejido subcutáneo. En la forma sistémica la misma toxina provoca hemólisis intravascular, coagulación intravascular diseminada y daño renal.

2. LOXOSCELISMO CUTÁNEO (80 A 90% DE LOS CASOS)

La mordedura es **casi indolora** o produce un leve escozor; en- 6.01.2.008
tre 2 y 8 horas después aparecen dolor quemante creciente, eritema y edema. A las 6 a 12 horas se forma la **placa livedoide**: una placa de bordes geográficos con zonas **eritematosas, violáceas y pálidas isquémicas**, a menudo con ampollas hemorrágicas. En 24 a 72 horas la lesión se extiende, por gravedad, hacia abajo, y evoluciona a una **escara negra seca** que se demarca en 7 a 14 días y se desprende dejando una **úlcera de cicatrización lenta** (semanas a meses) con cicatriz atrófica. En la cara, los muslos y los glúteos predomina el edema extenso. El diagnóstico es clínico y se apoya en la captura de la araña. Hay que diferenciarlo del pioderma gangrenoso, el ectima, la fasceítis necrotizante, la celulitis, la necrosis grasa y el herpes zóster. **(ver Imagen 16.18B y C)**

3. LOXOSCELISMO CUTÁNEO-VISCERAL (SISTÉMICO)

Afecta a una minoría (1 a 15%), más a niños y tras morde- 6.01.2.008
duras en zonas con tejido graso. Los síntomas sistémicos aparecen en las primeras **6 a 72 horas**: fiebre, cefalea, mialgias, náuseas y un exantema morbiliforme o petequial; luego **hemólisis intravascular** con anemia, ictericia, **hemoglobinuria (orina oscura)** y aumento de LDH y bilirrubina indirecta, **coagulación intravascular diseminada** con trombocitopenia y alteración de la coagulación, **insuficiencia renal aguda** y rabdomiólisis; puede llegar al shock y la muerte. El estudio inicial, que se repite en las primeras 48 horas en toda mordedura sospechosa, incluye hemograma con plaquetas y reticulocitos, LDH, bilirrubina, creatinina, nitrógeno ureico, creatinquinasa, pruebas de coagulación y orina completa.

4. TRATAMIENTO Y CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN

Forma cutánea: reposo con la zona elevada, **frío local** (no ca- 6.01.2.008
lor), analgesia, profilaxis antitetánica, aseo y curaciones; el antibiótico solo se usa si hay infección secundaria. Muchos centros indican un corticoide sistémico en las primeras 24 a 48 horas. **No se hace escisión quirúrgica precoz**, que empeora la lesión: la escara se debrida tardíamente, a las 2 a 4 semanas, cuando está demarcada, y la úlcera se maneja como herida crónica con eventual injerto. Control diario las primeras 48 a 72 horas para detectar la evolución sistémica.

Forma cutáneo-visceral: se **hospitaliza** en unidad de monitoreo. Se hidrata por vía endovenosa de forma forzada para proteger el riñón y se mantiene la diuresis, se indica corticoide endovenoso precoz, se transfunde si hay anemia grave, se corrige la coagulopatía y se dializa si hay falla renal. El **suero antiloxosceles** (antiveneno de producción nacional) se usa en las primeras 24 a 48 horas, por indicación del toxicólogo o del especialista (consulta al CITUC), porque su eficacia disminuye con el tiempo. El pronóstico es bueno si se reconoce y trata de forma precoz.

5. HIGIENE DE LA VIVIENDA Y PROFILAXIS DEL LOXOSCELISMO

Como la araña vive en la casa, la prevención es doméstica: **or- 6.01.3.002
denar y aspirar semanalmente** los rincones, zócalos, detrás de muebles y cuadros, bajo las camas y dentro de closets y cajones, retirando telas y ootecas (sacos de huevos) y cerrando la bolsa de la aspiradora; **separar la cama de la pared** (al menos 20 cm), sin que la ropa de cama cuelgue hasta el piso, y no guardar cajas ni ropa bajo ella; **sacudir y revisar la ropa, los zapatos, las toallas y las sábanas** antes de usarlos, sobre todo si estuvieron guardados o en el piso; guardar ropa y calzado en bolsas cerradas; **sellar grietas** en muros, zócalos y marcos de puertas y ventanas; evitar acumular escombros, leña, cartones y papeles; y no manipular la araña con la mano, sino capturarla con un vaso y llevarla para su identificación. La fumigación profesional solo complementa estas medidas. Se educa a la familia para consultar de inmediato ante una mordedura con dolor o cambio de color de la piel.



A. ARAÑA DE RINCÓN



B. PLACA VIOLÁCEA NECRÓTICA



C. ESCARA NEGRA

Imagen 16.18

FIGURA 16.18 · ENFRENTAMIENTO DEL LOXOSCELISMO EN URGENCIA



TABLA 16.18 · LOXOSCELISMO CUTÁNEO VERSUS CUTÁNEO-VISCERAL 6.01.2.008, 6.01.3.002

PARÁMETRO	CUTÁNEO (80-90%)	CUTÁNEO-VISCERAL (1-15%)
Inicio de los síntomas	Dolor y eritema en 2 a 8 horas	Síntomas sistémicos en las primeras 6 a 72 horas
Lesión	Placa livedoide, ampolla hemorrágica y escara	Igual, con o sin lesión cutánea llamativa
Clínica sistémica	Ausente	Fiebre, exantema, ictericia, orina oscura
Laboratorio	Normal	Anemia hemolítica, LDH elevada, trombocitopenia, coagulopatía, creatinina elevada
Manejo	Reposo, frío, analgesia, curaciones; debridar la escara tardíamente	Hospitalizar · hidratación · corticoide endovenoso · suero antiloxosceles · diálisis si hay falla renal
Pronóstico	Úlcera de cicatrización lenta con cicatriz	Riesgo vital, mayor en niños

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

16.18

Niño de 6 años es llevado a urgencia por fiebre de 38,5 °C, decaimiento y orina de color oscuro, 36 horas después de despertar con dolor en el muslo derecho. En esa zona se observa una placa violácea de bordes geográficos con ampolla hemorrágica y áreas pálidas. Los exámenes muestran hemoglobina de 7,5 g/dL, bilirrubina indirecta elevada, LDH elevada, plaquetas de 60.000 por microlitro y creatinina de 1,6 mg/dL; la orina tiene hemoglobina sin glóbulos rojos.

Conducta oficial. Es un loxoscelismo cutáneo-visceral por Loxosceles laeta: placa livedoide con ampolla hemorrágica en el muslo y, dentro de las primeras 72 horas, hemólisis intravascular (anemia, LDH elevada, hemoglobinuria), coagulación intravascular (trombocitopenia) y daño renal. Requiere hospitalización con hidratación endovenosa forzada, corticoide endovenoso, monitoreo y soporte transfusional y renal; el suero antiloxosceles se indica en las primeras 24 a 48 horas con asesoría del toxicólogo. No se hace cirugía precoz de la lesión cutánea.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- La araña de rincón (Loxosceles laeta) vive dentro de las casas, es nocturna y muerde al ser aplastada contra la piel, al dormir o vestirse.
- Mordedura casi indolora; a las 6 a 12 horas, placa livedoide con ampolla hemorrágica; luego escara negra y úlcera de cicatrización lenta.
- Forma cutánea (80 a 90%): reposo, frío local, elevación, analgesia, aseo y profilaxis antitetánica; no escisión precoz, debridar la escara tardíamente.
- Forma cutáneo-visceral (hasta 72 horas): fiebre, exantema, hemólisis con orina oscura, trombocitopenia y falla renal; hospitalizar con hidratación y corticoide endovenoso.
- Suero antiloxosceles solo en las primeras 24 a 48 horas y con criterio del toxicólogo; el CITUC asesora las 24 horas.
- Prevención: aspirar rincones, cama separada del muro, revisar ropa y calzado antes de usarlos, sellar grietas y evitar acumular objetos.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 16.18

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 89

1. Una paciente consulta por una lesión en el antebrazo, que inicialmente era dolorosa y eritematosa, pero que a las 6 horas se volvió más oscura y más grande. Al examen físico se observa una placa livedoide típica, con zonas violáceas, pálidas y eritematosas de bordes geográficos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Loxoscelismo cutáneo
B) Necrosis grasa
C) Ectima
D) Pioderma gangrenoso
E) Fasceítis necrotizante

EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 149

2. Paciente con dolor en zona escapular izquierda y lesión ulcerada con halo violáceo. ¿Cuál es el agente causal más probable?

A) Latrodectus mactans (araña del trigo)
B) Paederus irritans (bicho candela)
C) Miasis cutánea
D) Loxosceles laeta (araña de rincón)
E) Picadura de abeja con reacción local

Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.3.002

3. Una madre consulta porque su hijo de 5 años fue mordido ayer por una araña de rincón en el muslo. El niño se encuentra afebril y la lesión es una placa eritematosa dolorosa de 4 cm con centro pálido. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Escisión quirúrgica inmediata de la lesión
B) Medidas de sostén, frío local, analgesia, estudio de laboratorio y control en 24 a 48 horas
C) Alta sin control, porque la forma cutánea es siempre benigna
D) Calor local y antibióticos endovenosos
E) Hospitalización con suero antiloxosceles de rutina

Más preguntas online de Loxoscelismo →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 4.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 16.13 A 16.18

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Melanoma Maligno: Regla ABCDE, Biopsia Excisional, Índice de Breslow y Márgenes Quirúrgicos	La regla del ABCDE (Asimetría, Bordes, Color heterogéneo, Diámetro > 6 mm, Evolución)...	**La biopsia de elección de toda lesión sospechosa de melanoma es la BIOPSIA EXCISIONAL...**	Las biopsias por rasurado (shave) o punch están contraindicadas porque mutilan la...
Carcinomas Cutáneos No Melanoma: Carcinoma Basocelular (CBC) vs Carcinoma Espinocelular (CEC)	El Carcinoma Basocelular (CBC) es el cáncer cutáneo más frecuente de todos; se...	**El CBC tiene un riesgo de metástasis prácticamente nulo (<0.01%), pero gran poder de...**	—
Lesiones Cutáneas Premalignas: Queratosis Actínica, Cuerno Cutáneo y Nevos Displásicos	La queratosis actínica es la lesión premaligna cutánea más común y es precursora...	**Clínicamente se caracteriza por máculas eritematosas con escamas secas adherentes que...**	—
Infecciones Cutáneas Comunes: Micosis Superficiales (Dermatofitosis, Pitiriasis Versicolor), Escabiosis & Pediculosis	La Tiña Capitis SIEMPRE requiere tratamiento antimicótico oral (Griseofulvina o...	**La Tiña Inguinal típicamente respeta el escroto, a diferencia del intértrigo...**	—
Tumores Benignos de Piel, Hemangiomas Infantiles y Malformaciones Vasculares	Queratosis seborreica: placa verrugosa «pegada» del adulto mayor, benigna; la aparición...	**Quiste epidérmico: nódulo con punctum; se extirpa completo y fuera de la fase...**	Propranolol oral (2 a 3 mg/kg/día por 6 a 12 meses) para hemangiomas periorbitarios, de...
Loxoscelismo (Loxosceles laeta): Cuadro Cutáneo y Cutáneo-Visceral, Manejo y Prevención en la Vivienda	La araña de rincón (Loxosceles laeta) vive dentro de las casas, es nocturna y muerde al...	**Mordedura casi indolora; a las 6 a 12 horas, placa livedoide con ampolla hemorrágica...**	Prevención: aspirar rincones, cama separada del muro, revisar ropa y calzado antes de...

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

La regla del ABCDE (Asimetría, Bordes, Color heterogéneo, Diámetro > 6 mm, Evolución) es la herramienta clínica de tamizaje...

La biopsia de elección de toda lesión sospechosa de melanoma es la BIOPSIA EXCISIONAL COMPLETA con margen estrecho de 1 a 2 mm...

Las biopsias por rasurado (shave) o punch están contraindicadas porque mutilan la muestra e impiden medir con exactitud el...

El Índice de Breslow (espesor tumoral en milímetros) es el factor pronóstico individual más importante para el melanoma...

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

- La biopsia de elección de toda lesión sospechosa de melanoma es la BIOPSIA EXCISIONAL COMPLETA con margen estrecho de 1 a 2 mm e hipodermis.
- Las biopsias por rasurado (shave) o punch están contraindicadas porque mutilan la muestra e impiden medir con exactitud el espesor de Breslow.
- El CBC tiene un riesgo de metástasis prácticamente nulo (<0.01%), pero gran poder de destrucción local invasiva.
- El Carcinoma Espinocelular (CEC) se manifiesta como nódulo o placa queratósica descamativa indurada sobre queratosis actínica previa.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

La regla del ABCDE (Asimetría, Bordes, Color heterogéneo, Diámetro > 6 mm, Evolución) es la herramienta clínica de...	Tema 16.13 →
El Carcinoma Basocelular (CBC) es el cáncer cutáneo más frecuente de todos; se caracteriza por pápula perlada con...	Tema 16.14 →
La queratosis actínica es la lesión premaligna cutánea más común y es precursora directa del Carcinoma...	Tema 16.15 →
La Tiña Capitis SIEMPRE requiere tratamiento antimicótico oral (Griseofulvina o Terbinafina); los antifúngicos...	Tema 16.16 →
Queratosis seborreica: placa verrugosa «pegada» del adulto mayor, benigna; la aparición brusca de muchas...	Tema 16.17 →
La araña de rincón (Loxosceles laeta) vive dentro de las casas, es nocturna y muerde al ser aplastada contra la...	Tema 16.18 →

Solucionario & Justificaciones Razonadas EUNACOM

Clave oficial y justificación clínica de cada reconstrucción. Las preguntas se presentan sin clave en la página del tema; aquí se resuelven con la perla de examen correspondiente.

TEMA 16.1 · PREGUNTA 1 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.3.003

Una paciente de 25 años consulta por una erupción cutánea diseminada. El médico describe lesiones circunscritas de...

CLAVE B **Vesícula**

Una colección circunscrita de líquido seroso, claro o hemático ubicada en la epidermis, cuyo diámetro es menor a 0.5 centímetros (en este caso 2 a 3 mm), corresponde por definición semiológica estricta a una Vesícula. Las ampollas o flictenas (C) tienen un tamaño mayor a 0.5 o 1 cm. Las pústulas (A) contienen material purulento desde su origen. Las pápulas (D) son lesiones sólidas sin líquido. Las erosiones (E) son lesiones secundarias por pérdida de sustancia. Perla.

Perla. Colección líquida serosa menor a 0.5 cm es siempre una vesícula.

TEMA 16.1 · PREGUNTA 2 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.3.003

¿Cuál es la diferencia semiológica e histológica fundamental entre una erosión y una úlcera cutánea?

CLAVE A **La erosión compromete solo la epidermis y cura sin dejar cicatriz, mientras que la úlcera compromete la dermis o hipodermis y cura dejando cicatriz**

La diferencia patognomónica entre erosión y úlcera radica en la profundidad anatómica del daño tisular y su capacidad regenerativa. La erosión (o excoriación) es una pérdida de sustancia superficial circunscrita que afecta exclusivamente a la epidermis, respetando la membrana basal; dado que la capa basal de queratinocitos puede regenerar el epitelio por mitosis, la erosión cura restitutio ad integrum SIN DEJAR NINGUNA CICATRIZ. En cambio, la úlcera es una pérdida de sustancia profunda que destruye la membrana basal y penetra hacia la dermis reticular o tejido celular subcutáneo; como la dermis no puede regenerarse mediante mitosis epitelial, el defecto se repara mediante tejido de granulación y síntesis de colágeno fibrótico, dejando SIEMPRE UNA CICATRIZ PERMANENTE. Perla.

Perla. Erosión = solo epidermis y sin cicatriz; Úlcera = llega a dermis y deja cicatriz.

TEMA 16.2 · PREGUNTA 3 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.1.001

Un joven de 16 años presenta acné moderado con abundantes pápulas y pústulas en rostro y tercio superior del tórax. El...

CLAVE B **Combinar siempre el antibiótico tópico con peróxido de benzoilo o un retinoide tópico, evitando la monoterapia**

El uso de antibióticos tópicos en monoterapia (como clindamicina al 1% o eritromicina sola) induce de forma extraordinariamente rápida la selección y proliferación de cepas mutantes resistentes de Cutibacterium acnes, perdiendo toda su eficacia clínica en menos de 4 a 8 semanas. Las guías de práctica clínica internacionales y del MINSAL establecen como regla de oro mandatoria que los antibióticos tópicos NUNCA deben prescribirse solos, sino formulados en combinación con Peróxido de Benzoilo (el cual es un agente oxidante queratolítico frente al cual las bacterias no pueden desarrollar resistencia) o con un retinoide tópico. Perla.

Trampa. El antibiótico tópico en acné jamás se da solo: siempre con peróxido de benzoilo.

TEMA 16.2 · PREGUNTA 4 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.1.001

Una mujer de 22 años con acné nódulo-quístico severo y cicatrizal refractario a múltiples ciclos de doxiciclina oral es...

CLAVE B **Doble método anticonceptivo eficaz, dos pruebas de embarazo negativas previas y monitorización mensual del perfil lipídico y pruebas hepáticas**

La isotretinoína oral es uno de los teratógenos farmacológicos humanos más potentes conocidos, induciendo la embriopatía por retinoides (microtia, anomalías del SNC, defectos cardíacos conotruncales e hidrocefalia en > 30% de los fetos expuestos). Su prescripción en mujeres con potencial de fertilidad exige un programa de prevención de embarazo estricto: dos métodos anticonceptivos complementarios iniciados 1 mes antes de empezar el fármaco, dos pruebas de embarazo negativas previas y test de embarazo mensual durante y hasta 1 mes después del cese del tratamiento. Además, debido a sus efectos sistémicos, se deben controlar basal y periódicamente el perfil lipídico (riesgo de hipertrigliceridemia y pancreatitis) y las transaminasas hepáticas (hepatotoxicidad). Está contraindicado combinar con tetraciclinas (D) por riesgo de pseudotumor cerebri. Perla.

Perla. Isotretinoína exige doble anticoncepción, test de embarazo y control lipídico/hepático.

TEMA 16.3 · PREGUNTA 5 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.1.026

Una mujer de 44 años consulta por un cuadro de 8 meses de evolución caracterizado por enrojecimiento de mejillas y...

CLAVE B **Metronidazol en gel al 0.75% o ivermectina tópica al 1%**

El cuadro de eritema centrofacial persistente con telangiectasias y pápulo-pústulas en ausencia de comedones en una mujer adulta de 44 años corresponde a una Rosácea Pápulo-pustulosa. El tratamiento tópico de primera línea de elección avalado por la evidencia clínica es el Metronidazol tópico al 0.75% o la Ivermectina tópica al 1% en crema (que actúa contra el ácaro Demodex y reduce la inflamación). El clobetasol (A) es un corticoide ultrapotente que está terminantemente contraindicado en rosácea porque provoca una rosácea esteroidea de rebote catastrófico. El adapaleno (C) es para acné y produciría excesiva irritación en la piel sensible con rosácea. Perla.

Perla. Metronidazol o ivermectina tópica son la primera línea en rosácea pápulo-pustulosa.

TEMA 16.3 · PREGUNTA 6 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.1.026

¿Cuál de los siguientes hallazgos al examen físico cutáneo permite DESCARTAR con mayor certeza el diagnóstico de...

CLAVE B **Presencia de comedones abiertos ("puntos negros") o cerrados**

El criterio semiológico cardinal para el diagnóstico diferencial entre acné vulgar y rosácea es la presencia o ausencia de comedones. El comedón (abierto o cerrado) es la lesión elemental primaria y patognomónica del acné vulgar (originado por la hiperqueratinización infundibular folicular). En cambio, la rosácea es una enfermedad con disregulación vascular e inflamatoria que NUNCA cursa con formación de comedones. Si un paciente presenta pápulas, pústulas y eritema facial pero se constatan comedones al examen físico, el diagnóstico es Acné Vulgar y no Rosácea. Trampa.

Trampa. La rosácea puede tener pápulas, pústulas y eritema idénticos al acné, pero NUNCA comedones.

TEMA 16.4 · PREGUNTA 7 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.1.002

Un hombre de 24 años consulta por caída progresiva de cabello en las regiones temporales y en la coronilla desde hace 2...

CLAVE B **Finasteride oral; inhibición de la enzima 5-alfa reductasa tipo 2 disminuyendo la síntesis de dihidrotestosterona**

El cuadro corresponde a una Alopecia Androgenética masculina (calvicie común en patrón de Hamilton-Norwood). Su fisiopatología radica en la acción de la dihidrotestosterona (DHT) sobre receptores androgénicos de folículos susceptibles, provocando su miniaturización progresiva. El fármaco oral de primera línea de elección es el Finasteride (1 mg/día), un inhibidor competitivo selectivo de la enzima 5-alfa reductasa tipo 2, que reduce los niveles tisulares y séricos de DHT en aproximadamente un 70%, deteniendo la caída en más del 85% de los pacientes y estimulando el engrosamiento del cabello miniaturizado. Perla.

Perla. Finasteride oral inhibe la 5-alfa reductasa y frena la alopecia androgenética.

TEMA 16.4 · PREGUNTA 8 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.1.002

Una mujer de 30 años consulta muy angustiada porque desde hace 3 semanas se le cae el cabello en forma masiva cada vez...

CLAVE B **Efluvio telógeno agudo puerperal; tranquilizar a la paciente y explicar que el cuadro es transitorio y se recuperará espontáneamente**

El efluvio telógeno agudo (específicamente el efluvio postparto o telogen effluvium) se produce por la caída brusca de los niveles de estrógenos placentarios que mantenían a los cabellos artificialmente en fase de anágeno durante el embarazo. Esto precipita el paso masivo y sincronizado de gran porcentaje de folículos a la fase de telógeno (fase de reposo y caída), manifestándose clínicamente 2 a 3 meses después del parto como una caída difusa y alarmante pero sin pérdida de orificios foliculares ni formación de placas circunscritas. El cuadro es enteramente benigno y autolimitado: el ciclo capilar se normaliza y el cabello se repuebla de forma completa y espontánea en los siguientes 6 meses. La conducta correcta es descartar ferropenia, tranquilizar a la madre y no indicar tratamientos invasivos. Perla.

Perla. Caída difusa masiva de pelo 2-3 meses postparto es efluvio telógeno fisiológico.

TEMA 16.5 · PREGUNTA 9 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.1.024

Un hombre de 36 años con antecedente de psoriasis en placas bien controlada sufre una herida cortante lineal en el...

CLAVE B **Fenómeno isomórfico de Koebner**

El desarrollo de lesiones cutáneas características de una dermatosis previa sobre áreas de piel sana que han sufrido un traumatismo físico, mecánico, químico o quirúrgico (como una herida, incisión, quemadura o rascado) se denomina Fenómeno Isomórfico de Koebner. Es un sello semiológico característico de la Psoriasis, del Liquen Plano y del Vitíligo. El signo de Darier (A) ocurre en mastocitosis (habón al frotar). El signo de Nikolsky (C) es el despegamiento epidérmico por presión en pénfigo o NET. La patergia (D) es la formación de una pústula estéril tras un pinchazo en enfermedad de Behçet o pioderma gangrenoso. Perla.

Perla. Aparición de lesiones sobre cicatriz o trauma es el fenómeno de Koebner.

TEMA 16.5 · PREGUNTA 10 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.1.024

Un escolar de 10 años, que presentó una faringoamigdalitis purulenta tratada con paracetamol hace dos semanas, es...

CLAVE B **Psoriasis en gotas (guttata)**

El brote eruptivo agudo de pápulas descamativas pequeñas ("en gotas de lluvia") en tronco y extremidades en un paciente pediátrico o adolescente, precedido 1 a 2 semanas antes por una infección faringoamigdalina estreptocócica por Streptococcus pyogenes, es la presentación arquetípica de la Psoriasis en Gotas o Guttata. Las toxinas superantigénicas estreptocócicas activan de forma masiva a los linfocitos T cutáneos. Tiene un excelente pronóstico, respondiendo muy bien a la erradicación del estreptococo con antibióticos (amoxicilina) y fototerapia natural o UVB. Perla.

Perla. Erupción en gotas tras amigdalitis estreptocócica es psoriasis guttata.

TEMA 16.5 · PREGUNTA 11 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.1.024

¿Cuál de los siguientes tratamientos está FORMALMENTE CONTRAINDICADO en un paciente con psoriasis vulgar debido al...

CLAVE B **Corticoides orales o sistémicos (como prednisona o betametasona parenteral)**

Una de las contraindicaciones farmacológicas más universales y estrictas de la dermatología es el uso de corticosteroides por vía sistémica (oral, intramuscular o endovenosa) en pacientes con psoriasis vulgar. Aunque los corticoides orales provocan una mejoría clínica espectacular y rápida durante los primeros días de administración, su reducción o suspensión desencadena invariablemente un fenómeno de rebote severo y catastrófico, induciendo la transformación de la psoriasis vulgar en una Psoriasis Pustulosa Generalizada de von Zumbusch o una Eritrodermia Psoriásica, entidades graves con riesgo de descompensación hemodinámica, hipotermia, sobreinfección bacteriana y muerte. Trampa.

Trampa. NUNCA indicar prednisona oral en un brote de psoriasis vulgar.

TEMA 16.5 · PREGUNTA 12 Banco Oficial AEE · Perfil V3 1.11.1.001

Un hombre de 45 años con psoriasis en placas severa que compromete el 25% de su superficie corporal consulta además por...

CLAVE B **Dactilitis o "dedo en salchicha"**

La inflamación simultánea y difusa de toda la estructura de un dedo (que involucra las articulaciones interfalángicas, tendones flexores y partes blandas periarticulares), dándole un aspecto tumefacto cilíndrico homogéneo semejante a un embutido, se denomina Dactilitis o "dedo en salchicha". Es un signo patognomónico característico de las espondiloartropatías seronegativas asociadas a HLA-B27, particularmente de la Artritis Psoriásica (afectando a un 30% de estos pacientes). Se acompaña frecuentemente de compromiso de articulaciones interfalángicas distales (IFD), entesitis aquiliana y onicopatía psoriásica. Perla.

Perla. Dedo en salchicha (dactilitis) en paciente psoriásico confirma artritis psoriásica.

TEMA 16.6 · PREGUNTA 13 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.1.004

Un lactante de 8 meses presenta lesiones eccematosas eritematosas, exudativas y muy pruriginosas en ambas mejillas y...

CLAVE B **Dermatitis atópica del lactante**

El cuadro de lesiones eccematosas exudativas bilaterales intensamente pruriginosas en las mejillas y superficies extensoras de las extremidades en un lactante, con preservación estricta y absoluta de la región cubierta por el pañal, es la presentación semiológica clásica y definitoria de la Dermatitis Atópica en su fase del lactante. La dermatitis del pañal (A) comprometería precisamente el área del pañal. La dermatitis seborreica (D) afecta cuero cabelludo ("costra láctea"), pliegues y área del pañal con escamas untuosas y NO respeta el pañal ni causa prurito tan intenso. La acrodermatitis enteropática (E) por déficit de zinc produce placas erosivas periorificiales y diarrea. Perla.

> **Perla.** Eccema en mejillas que respeta el pañal es dermatitis atópica del lactante.

TEMA 16.6 · PREGUNTA 14 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.1.004

Un niño de 5 años con antecedentes de dermatitis atópica severa presenta bruscamente un empeoramiento clínico con...

CLAVE B **Eccema herpético de Kaposi (erupción variceliforme); hospitalizar e iniciar aciclovir endovenoso**

La sobreinfección diseminada por el Virus Herpes Simple (VHS-1 o VHS-2) sobre una piel con dermatitis atópica con barrera epidérmica dañada se denomina Eccema Herpético de Kaposi (o erupción variceliforme de Kaposi). Se caracteriza por un brote agudo y masivo de vesículas umbilicadas agrupadas, dolorosas y confluentes que evolucionan a erosiones en sacabocados con costras hemáticas, acompañadas de fiebre alta y adenopatías. Constituye una verdadera emergencia dermatológica y pediátrica por el alto riesgo de diseminación visceral herpética, queratitis herpética y sobreinfección bacteriana secundaria. Requiere hospitalización urgente y tratamiento antiviral sistémico inmediato con Aciclovir endovenoso. Perla.

> **Perla.** Niño atópico con brote agudo de vesículas umbilicadas y fiebre tiene eccema herpético (Aciclovir EV).

TEMA 16.7 · PREGUNTA 15 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.1.007

Un trabajador de la construcción de 40 años consulta por eccema subagudo en ambas manos de 2 meses de evolución...

CLAVE B **Dicromato de potasio (cromo); pruebas epicutáneas del parche (Patch test)**

El dicromato de potasio (sales de cromo hexavalente) es el alérgeno clásico presente en el cemento húmedo y constituye la causa profesional más frecuente de dermatitis de contacto alérgica grave e incapacitante en trabajadores de la construcción y albañiles. Dado que es una reacción de hipersensibilidad celular tipo IV mediada por linfocitos T, el método confirmatorio de certeza son las pruebas epicutáneas del parche (Patch test) con lectura a las 48 y 96 horas. El níquel (A) es típico de bisutería. El látex (C) produce hipersensibilidad inmediata tipo I con habones. Perla.

> **Perla.** Eccema de manos en trabajador de la construcción con cemento es alergia al cromo (dicromato de potasio).

TEMA 16.7 · PREGUNTA 16 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.1.006

Un hombre de 34 años consulta por eritema marcado y descamación grasosa amarillenta muy abundante que compromete de...

CLAVE B **Solicitar prueba de ELISA para VIH con consentimiento informado**

La presencia de una Dermatitis Seborreica extensa, atípica, severa y refractaria a tratamiento convencional en un adulto joven, especialmente cuando se acompaña de signos de inmunodepresión celular como candidiasis orofaríngea recurrente o baja de peso, es un marcador clínico centinela de Primoinfección o infección avanzada por Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). La prevalencia de dermatitis seborreica alcanza entre el 40% y el 80% en pacientes seropositivos, con una severidad que se correlaciona inversamente con el recuento de linfocitos CD4. La conducta médica inmediata e inexcusable en atención primaria es ofrecer y solicitar el test de ELISA para VIH. Perla.

> **Perla.** Dermatitis seborreica severa o explosiva en adulto joven exige solicitar test de VIH.

TEMA 16.8 · PREGUNTA 17 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.1.030

Un hombre de 28 años presenta ronchas eritematosas pruriginosas diseminadas en el cuerpo desde hace 2 meses. El médico...

CLAVE B **¿Las ronchas desaparecen en menos de 24 horas sin dejar marca, apareciendo otras en sitios distintos?**

La propiedad semiológica definitoria y sine qua non del habón de la urticaria es su carácter evanescente o fugaz: debido a que el edema vasomotor de la dermis papilar se reabsorbe con rapidez, cada lesión individual tiene una duración efímera, desapareciendo por completo en menos de 24 horas sin dejar ninguna mancha, hematoma ni cicatriz en la piel afectada, mientras brotan nuevas lesiones en otras localizaciones anatómicas. Si la lesión permanece fija por más de 24-48 horas o deja una pigmentación purpúrica hemosiderótica al resolverse (A, C, E), orienta a una vasculitis urticariana. Perla.

> **Perla.** El habón de la urticaria dura menos de 24 horas y desaparece sin dejar rastro.

TEMA 16.8 · PREGUNTA 18 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.1.030

Una paciente de 35 años con diagnóstico de urticaria crónica espontánea continúa presentando brotes diarios de habones...

CLAVE B **Aumentar la dosis del antihistamínico H1 de segunda generación hasta cuatro veces la dosis estándar (cetirizina hasta 40 mg/día)**

El algoritmo internacional estandarizado de las guías EAACI/GA²LEN/EDF/WAO para el tratamiento de la urticaria crónica refractaria establece claramente que, ante el fracaso terapéutico de un antihistamínico H1 de segunda generación a dosis estándar transcurridas 2 a 4 semanas, el segundo escalón mandatorio es incrementar la dosis del mismo antihistamínico H1 de segunda generación hasta dos, tres o cuatro veces la dosis habitual (hasta 4 veces la dosis convencional, ej. cetirizina 40 mg/día o levocetirizina 20 mg/día). Esta estrategia logra el control en más del 60-70% de los pacientes refractarios con un excelente perfil de seguridad. Los corticoides orales a largo plazo (A) están contraindicados. Los antihistamínicos de primera generación como clorfenamina (C) ya no se recomiendan por sus efectos sedantes y anticolinérgicos. Perla.

> **Perla.** En urticaria refractaria a dosis estándar, se cuadruplica el antihistamínico de 2.ª generación.

TEMA 16.9 · PREGUNTA 19 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.2.009

Una mujer de 38 años consulta en urgencias por un cuadro febril de 48 horas de evolución acompañado de odinofagia...

CLAVE B **Síndrome de Stevens-Johnson y Signo de Nikolsky**

El cuadro corresponde a un Síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) y el signo semiológico descrito es el Signo de Nikolsky positivo. El SSJ se define por el desprendimiento epidérmico en menos del 10% de la superficie corporal total con compromiso severo de al menos dos mucosas (oral y ocular en este caso). El Signo de Nikolsky consiste en el despegamiento o desprendimiento de la epidermis al aplicar una suave fricción tangencial sobre la piel eritematosa o perilesional, lo que traduce necrosis epidérmica aguda o acantolisis. Si el compromiso fuera > 30% sería NET (C). El eritema multiforme menor (A) respeta mucosas o afecta una sola de forma leve y Nikolsky es negativo.

Perla. Auspitz (D) es rocío sangrante en psoriasis.

TEMA 16.9 · PREGUNTA 20 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.2.009

¿Cuál es el porcentaje de superficie corporal total (BSA) desprendida que define y distingue formalmente a la...

CLAVE D **Mayor al 30% de superficie corporal total**

La clasificación internacional del consenso dermatológico estratifica el espectro SSJ/NET según el porcentaje de superficie corporal total (BSA) desprendida con necrosis epidérmica de espesor total: 1) Síndrome de Stevens-Johnson: afectación menor al 10% de la BSA; 2) Síndrome de Superposición SSJ/NET: afectación entre 10% y 30% de la BSA; 3) Necrólisis Epidérmica Tóxica (NET o Síndrome de Lyell): desprendimiento en más del 30% de la BSA.

Perla. Recordar: corte menor al 10% es SSJ, corte mayor al 30% es NET.

TEMA 16.9 · PREGUNTA 21 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.2.009

Un hombre de 62 años es hospitalizado por una Necrólisis Epidérmica Tóxica que compromete el 45% de la superficie...

CLAVE C **Bicarbonato sérico de 16 mEq/L**

El score pronóstico SCORTEN consta de 7 variables evaluadas al ingreso (1 punto cada una): 1) Edad ≥ 40 años; 2) FC ≥ 120 lpm; 3) Neoplasia activa; 4) Superficie epidérmica desprendida inicial > 10%; 5) BUN > 28 mg/dL (> 10 mmol/L); 6) Bicarbonato sérico 252 mg/dL (> 14 mmol/L). En este paciente, el bicarbonato de 16 mEq/L es menor a 20 mEq/L, por lo que suma un punto de gravedad.

Perla. La edad de 35 años no suma punto (el corte es ≥ 40 años), la FC de 95 lpm no suma punto (el corte es ≥ 120 lpm), la glicemia de 140 mg/dL no suma (corte > 252 mg/dL) y el BUN de 15 mg/dL tampoco suma (corte > 28 mg/dL).

TEMA 16.9 · PREGUNTA 22 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.2.009

En el manejo hospitalario de un paciente diagnosticado con Necrólisis Epidérmica Tóxica severa en un Centro de...

CLAVE B **Desbridamiento quirúrgico agresivo en pabellón de toda la epidermis desprendida y flictenas**

A diferencia de las quemaduras térmicas profundas de tercer grado, en la Necrólisis Epidérmica Tóxica el desbridamiento quirúrgico agresivo de la epidermis desprendida está CONTRAINDICADO. La epidermis necrótica desprendida actúa como un apósito biológico natural que protege la dermis papilar subyacente y favorece la reepitelización sin cicatriz profunda si no se somete a tracción traumática. Las ampollas grandes pueden aspirarse con aguja estéril preservando el techo de la flictena y cubriendo con gasas no adherentes.

Perla. El ambiente térmico cálido (A), la protección ocular intensiva para prevenir simblefaron (C), la fluidoterapia controlada (D) y el retiro farmacológico precoz (E) son pilares fundamentales de la buena práctica médica.

TEMA 16.10 · PREGUNTA 23 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.2.013

Un hombre de 55 años inició tratamiento con alopurinol 300 mg/día hace un mes por gota tofácea. Consulta por fiebre de...

CLAVE B **Síndrome DRESS**

El cuadro corresponde con total precisión a un Síndrome DRESS (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms) inducido por alopurinol. Presenta todos los elementos diagnósticos clásicos: latencia de 4 semanas (1 mes), fiebre alta persistente, exantema morbiliforme confluente con edema facial prominente (sello semiológico), eosinofilia marcada (> 1.500/uL), linfocitos atípicos en sangre y compromiso hepático evidente con elevación de transaminasas. En el SSJ (A) habría ampollas, desprendimiento epidérmico, Nikolsky positivo y compromiso mucoso hemorrágico severo, sin eosinofilia prominente.

Perla. La psoriasis eritrodérmica (C) cursa con descamación laminar generalizada y no da hepatitis ni eosinofilia de este grado.

TEMA 16.10 · PREGUNTA 24 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.2.013

¿Cuál es el período de latencia típico característico que transcurre entre el inicio del medicamento causal y la...

CLAVE C **De 2 a 8 semanas**

Una de las características más importantes y preguntadas del Síndrome DRESS en el EUNACOM es su período de latencia inusualmente prolongado, que típicamente oscila entre 2 y 8 semanas (promedio 3 a 6 semanas) después de la primera dosis del fármaco responsable. Esto contrasta abiertamente con las reacciones anafilácticas o urticarias inmediatas (minutos a pocas horas), el exantema maculopapular benigno común (4 a 10 días) y el síndrome de Stevens-Johnson (1 a 3 semanas).

Perla. Esta latencia tardía con frecuencia dificulta el reconocimiento inicial si el médico no indaga fármacos iniciados el mes previo.

TEMA 16.10 · PREGUNTA 25 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.2.013

¿Cuál es el órgano interno que se compromete con mayor frecuencia en los pacientes con Síndrome DRESS y cuya afectación...

CLAVE B **Hígado (hepatitis tóxica / necrosis hepática)**

El hígado es, por amplio margen, el órgano interno más frecuentemente comprometido en el Síndrome DRESS, afectándose en el 75% al 90% de todos los casos confirmados. La presentación varía desde una elevación asintomática de transaminasas hasta una hepatitis tóxica severa con ictericia y coagulopatía, siendo la insuficiencia hepática aguda fulminante la principal causa de muerte por este síndrome (mortalidad global del 5% al 10%).

Perla. El riñón (B) se afecta en un 15-30% de los casos (nefritis tubulointersticial, especialmente por alopurinol), pero con menor frecuencia que el hígado.

TEMA 16.10 · PREGUNTA 26 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.2.013

Una mujer de 32 años es diagnosticada de Síndrome DRESS secundario a fenitoína con compromiso hepático moderado (GPT...

CLAVE C **Disminuir la dosis de prednisona de manera muy lenta y progresiva a lo largo de 2 a 3 meses**

En el síndrome DRESS, el desescalamiento de la corticoterapia sistémica debe realizarse de forma extraordinariamente lenta y paulatina, a lo largo de 8 a 12 semanas (2 a 3 meses). Esto se debe a que la respuesta inflamatoria mediada por linfocitos T y la reactivación concomitante del herpesvirus humano tipo 6 (HHV-6) persisten activas mucho después de retirado el medicamento. Una suspensión rápida (en días o semanas cortas) provoca casi invariablemente un "efecto rebote" con recurrencia de la fiebre, reaparición del exantema y hepatitis fulminante grave.

Perla. Mantenerla de por vida (D) es incorrecto y tóxico.

TEMA 16.11 · PREGUNTA 27 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.2.010

Un hombre de 76 años, con antecedentes de enfermedad de Parkinson, consulta por un cuadro de 2 meses de evolución de...

CLAVE B **Penfigoide ampollar**

El cuadro clínico es patognomónico de Penfigoide Ampollar. Los hallazgos cardinales que lo confirman son: 1) Edad avanzada (76 años con patología neurológica crónica asociada); 2) Prurito intenso prodrómico; 3) Ampollas tensas, de paredes gruesas y resistentes que no se rompen fácilmente; 4) Signo de Nikolsky negativo (la epidermis sana no se desprende con la fricción); y 5) Ausencia de compromiso en la mucosa oral. El pénfigo vulgar (A) afectaría a personas más jóvenes (40-60 años), cursaría con ampollas flácidas muy frágiles, Nikolsky positivo y compromiso oral casi universal. La NET (C) es una farmacodermia aguda grave con Nikolsky positivo y desprendimiento masivo.

Perla. La dermatitis herpetiforme (D) se asocia a celiaquía con vesículas en codos y rodillas.

TEMA 16.11 · PREGUNTA 28 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.1.020

¿Cuál es el hallazgo anatomopatológico característico en la biopsia cutánea que define la ampolla del Pénfigo Vulgar?

CLAVE B **Ampolla intraepidérmica suprabasal con acantolisis celular**

El hallazgo histopatológico diagnóstico del Pénfigo Vulgar es la ampolla intraepidérmica de localización suprabasal con acantolisis (pérdida de uniones desmosómicas entre queratinocitos mediada por anticuerpos anti-desmogleína 3). La hilera de queratinocitos de la capa basal permanece adherida a la membrana basal mediante sus hemidesmosomas indemnes, adoptando el clásico aspecto de "hilera de lápidas sepulcrales". La ampolla subepidérmica (A) es propia del penfigoide ampollar y dermatitis herpetiforme. La ampolla subcórnea (C) es del impétigo ampollar o pénfigo foliáceo. La necrosis epidérmica total (D) es de la NET.

Perla. La vacuolización basal en banda (E) es del liquen plano.

TEMA 16.11 · PREGUNTA 29 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.1.020

Una paciente de 50 años con diagnóstico confirmado de Pénfigo Vulgar extenso inicia tratamiento de inducción. ¿Cuál es...

CLAVE A **Corticoides sistémicos a dosis altas (Prednisona 1 a 1.5 mg/kg/día)**

El pilar fundamental e irremplazable de primera línea para el tratamiento del Pénfigo Vulgar agudo son los Corticoides Sistémicos en dosis altas (Prednisona oral a 1.0 a 1.5 mg/kg/día, o pulsos endovenosos de metilprednisolona en formas hiperagudas fulminantes). Debido a la alta morbimortalidad de los corticoides a largo plazo, se asocian precozmente a agentes biológicos como Rituximab (anti-CD20) o inmunosupresores como azatioprina o micofenolato como ahorradores de corticoides. La dapsona con dieta sin gluten (C) es el tratamiento de la dermatitis herpetiforme asociada a celiaquía. El aciclovir (D) trata herpes.

Perla. Los antihistamínicos (B) no frenan la acantolisis autoinmune.

TEMA 16.11 · PREGUNTA 30 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.2.010

¿Cuál es el patrón característico observado en la Inmunofluorescencia Directa (IFD) de una biopsia perilesional en un...

CLAVE C **Depósito lineal y continuo de IgG y C3 a lo largo de la membrana basal**

En el Penfigoide Ampollar, la inmunofluorescencia directa (IFD) sobre piel perilesional revela un depósito continuo y lineal de IgG y factor C3 del complemento a lo largo de la zona de la membrana basal (unión dermoepidérmica), donde se ubican los antígenos hemidesmosómicos BP180 y BP230. En contraste, el pénfigo vulgar (B) muestra un depósito intercelular de IgG en patrón de "red de pescar" o "malla" en la epidermis.

Trampa. El depósito granular de IgA en las papilas dérmicas (A) es patognomónico de la dermatitis herpetiforme de Duhring-Brocq.

TEMA 16.12 · PREGUNTA 31 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.1.010

Un adulto joven de 24 años consulta por una erupción cutánea en el dorso de ambas manos y antebrazos caracterizada por...

CLAVE B **Eritema multiforme por infección por Virus Herpes Simple**

La presencia de lesiones en diana o escarapela típica con 3 anillos concéntricos en extremidades acrales, asociadas al antecedente inmediato de herpes labial (7 a 14 días previos), es el cuadro clásico indiscutible de un Eritema Multiforme inducido por Virus Herpes Simple (VHS). El VHS es el responsable de más del 70% de todos los casos de eritema multiforme. El SSJ (A) cursa con dianas atípicas de solo dos zonas, Nikolsky positivo, flictenas con desprendimiento epidérmico y compromiso mucoso severo. La urticaria multiforme (C) produce habones evanescentes migratorios que duran menos de 24 horas cada uno.

Perla. El penfigoide (D) da ampollas tensas en ancianos.

TEMA 16.12 · PREGUNTA 32 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.1.031

Un paciente de 28 años presenta su quinto episodio en el último año de eritema multiforme con lesiones típicas en diana...

CLAVE B **Tratamiento profiláctico continuo con Aciclovir oral durante 6 meses**

En pacientes con Eritema Multiforme recurrente frecuente (más de 3 a 5 episodios al año) asociado a reactivaciones documentadas de Virus Herpes Simple (VHS), la indicación médica con mayor nivel de evidencia es la profilaxis o terapia supresiva continua con antivirales orales: Aciclovir oral (400 mg cada 12 horas) o Valaciclovir (500 mg una vez al día) durante 6 a 12 meses. Esta estrategia suprime la replicación del ADN viral del VHS en los ganglios sensitivos, previniendo el estímulo inmunológico antigénico en la piel y evitando las recidivas en más del 80% de los casos.

Trampa. Los corticoides sistémicos continuos (A) están contraindicados por su severa toxicidad acumulativa.

TEMA 16.13 · PREGUNTA 33 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.5.001

Un hombre de 46 años consulta por un nevo en la espalda que ha cambiado de color y aumentado de tamaño en los últimos 4...

CLAVE B **Biopsia excisional completa con 1 a 2 mm de margen lateral y celular subcutáneo**

Ante una lesión con sospecha clínica de melanoma maligno, el estándar de oro diagnóstico es la biopsia excisional completa con márgenes estrechos de 1 a 2 mm y en toda la profundidad del tejido celular subcutáneo.

Perla. Esta técnica permite la extirpación diagnóstica íntegra y asegura la medición histológica fidedigna del espesor de Breslow, sin desestructurar la arquitectura de la lesión.

TEMA 16.13 · PREGUNTA 34 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.1.017

El informe histopatológico de una biopsia excisional de una lesión cutánea en la pierna de una mujer de 38 años...

CLAVE B **Ampliación quirúrgica de márgenes a 1 cm de tejido sano, sin necesidad de biopsia de ganglio centinela**

En un melanoma con espesor de Breslow ≤ 1.0 mm (en este caso 0.6 mm) sin ulceración histológica (T1a), el margen quirúrgico definitivo recomendado por todas las guías internacionales es de 1.0 cm de piel sana tridimensional.

Trampa. Dado que el Breslow es < 0.8 mm y no presenta factores de mal pronóstico (sin ulceración), NO está indicada la biopsia de ganglio centinela.

TEMA 16.13 · PREGUNTA 35 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.1.017

¿Cuál de los siguientes subtipos clínico-patológicos de melanoma maligno se caracteriza por no estar relacionado con la...

CLAVE D **Melanoma lentiginoso acral**

El melanoma lentiginoso acral se localiza en palmas, plantas y lechos ungueales (subungueal). A diferencia de los otros subtipos, su patogenia no depende de la exposición a la radiación solar ultravioleta.

> **Perla.** Aunque en personas caucásicas solo representa el 5% de los melanomas, en poblaciones chilenas, hispanoamericanas, asiáticas y afrodescendientes constituye entre el 40% y el 60% de los casos.

TEMA 16.13 · PREGUNTA 36 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.1.017

En el informe histológico de un melanoma maligno, ¿cuál es el factor pronóstico individual más importante para...

CLAVE C **El espesor tumoral microtumoral medido en milímetros según el Índice de Breslow**

El espesor tumoral según el Índice de Breslow (medido micrométricamente en milímetros desde la capa granulosa de la epidermis hasta la célula tumoral más profunda) es el factor pronóstico independiente más potente y validado en el melanoma primario.

> **Perla.** Ha sustituido completamente a los niveles de Clark en la etapificación oficial AJCC.

TEMA 16.14 · PREGUNTA 37 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.1.003

Un hombre de 68 años presenta en la punta nasal una lesión papular de 6 mm de diámetro, de coloración blanquecina...

CLAVE A **Carcinoma basocelular nódulo-ulcerativo**

La tríada semiológica de pápula translúcida con brillo perlado, telangiectasias arboriformes superficiales y ulceración central ("úlcera de Rodent") en una zona fotoexpuesta facial (nariz) es patognomónica del Carcinoma Basocelular, el tumor maligno cutáneo más frecuente.

TEMA 16.14 · PREGUNTA 38 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.1.003

Una mujer de 72 años consulta por una lesión en el labio inferior que no cicatriza desde hace 6 meses. Al examen se...

CLAVE B **Carcinoma espinocelular infiltrante**

Toda úlcera o placa costrosa indurada en el labio inferior que no cicatriza en más de 2 a 4 semanas debe considerarse un Carcinoma Espinocelular (CEC) hasta demostrar lo contrario.

> **Perla.** El labio inferior es una localización de alto riesgo para CEC (precedido comúnmente por queilitis actínica) y tiene un riesgo significativo de metástasis a ganglios submentonianos y submandibulares.

TEMA 16.15 · PREGUNTA 39 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.1.029

Un hombre de 65 años presenta en la frente y dorso de manos varias máculas eritematosas milimétricas cubiertas por...

CLAVE A **Queratosis actínicas**

Las máculas eritematosas poco delimitadas con escamas adherentes ásperas al tacto (signo de la lija) en zonas fotoexpuestas crónicas son patognomónicas de las Queratosis Actínicas, lesiones premalignas inducidas por daño solar ultravioleta acumulativo.

TEMA 16.15 · PREGUNTA 40 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.1.029

¿Cuál de los siguientes fármacos tópicos está indicado para el tratamiento del "campo de cancerización" en pacientes...

CLAVE B **Imiquimod al 5% en crema**

El Imiquimod al 5% en crema es un inmunomodulador tópico aprobado y ampliamente utilizado para tratar el campo de cancerización en queratosis actínicas múltiples, ya que estimula la respuesta inmune innata y adaptativa local eliminando queratinocitos atípicos subclínicos en toda el área fotoexpuesta.

TEMA 16.16 · PREGUNTA 41 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.1.018

Un escolar de 6 años es traído por su madre por presentar una placa redondeada de 4 cm en el cuero cabelludo, donde el...

CLAVE C **Griseofulvina oral a 20 mg/kg/día durante 6 a 8 semanas**

El cuadro corresponde a una Tiña de la Cabeza (Tinea capitis), producida comúnmente por Microsporum canis.

> **Perla.** La regla de oro en dermatología pediátrica es que la tiña capitis requiere SIEMPRE tratamiento antimicótico por vía oral (Griseofulvina oral durante 6 a 8 semanas, administrada idealmente con alimentos grasos para mejorar su absorción), ya que los antimicóticos tópicos no logran penetrar la raíz del folículo piloso afectado.

TEMA 16.16 · PREGUNTA 42 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.1.027

Una mujer de 29 años consulta por intenso prurito nocturno en las manos y cuerpo de 10 días de evolución. Al examen se...

CLAVE B **Tratar simultáneamente a todos los contactos del hogar con permetrina al 5%, presenten o no síntomas**

En la escabiosis, el pilar más crítico para evitar el fracaso terapéutico y las reinfecciones continuas en "ping-pong" es tratar de forma simultánea a TODOS los convivientes y contactos estrechos del paciente con permetrina al 5% en crema (o ivermectina oral), independientemente de si presentan síntomas clínicos o no, ya que el período de incubación asintomático puede durar hasta 4 a 6 semanas.

TEMA 16.17 · PREGUNTA 43 EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 83

Una paciente de 24 años presenta una cicatriz en la zona esternal, de gran tamaño, secundaria a una cirugía torácica...

CLAVE B **Queloide**

Una cicatriz que sobrepasa los bordes de la herida original, de aspecto rojo-violáceo, dolorosa y que aparece meses después de la cirugía, en el esternón (zona de riesgo), corresponde a un queloide. La cicatriz hipertrófica no sobrepasa los límites de la herida y tiende a regresar sola.

> **Perla.** La úlcera de Marjolin es un carcinoma sobre una cicatriz crónica y el granuloma piógeno es una pápula roja friable que sangra.

TEMA 16.17 · PREGUNTA 44 EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 64

Un paciente de 17 años consulta por un nódulo blanquecino que apareció hace 3 semanas, en una zona donde se había...

CLAVE E **Queloide**

La perforación del lóbulo de la oreja es una causa clásica de queloide: un nódulo firme que crece de forma progresiva y sobrepasa el sitio del trauma. El dermatofibroma es pequeño, pardo, de las piernas y con signo del hoyuelo.

> **Perla.** El tratamiento inicial es la infiltración con triamcinolona intralesional.

TEMA 16.17 · PREGUNTA 45 EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 83

Un recién nacido de 10 días presenta un hemangioma en el párpado derecho, de 3 cm de diámetro, que cubre parcialmente...

CLAVE A **Administrar propranolol**

Un hemangioma periocular que obstruye el eje visual pone en riesgo la visión (ambliopía y astigmatismo), por lo que no se observa: la primera línea es el propranolol oral, con evaluación previa y control de frecuencia cardíaca, presión y glicemia, junto a derivación a oftalmología y dermatología.

> **Perla.** La cirugía queda para los que no responden y deja cicatriz.

TEMA 16.17 · PREGUNTA 46 EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 125

Un lactante de 6 meses presenta ocho hemangiomas infantiles localizados en el tronco, principalmente en la espalda...

CLAVE A **Solicitar ecografía abdominal**

Cinco o más hemangiomas cutáneos obligan a descartar hemangiomas viscerales, sobre todo hepáticos, con una ecografía abdominal (y TSH si hay compromiso hepático).

> **Perla.** El propranolol se reserva para los hemangiomas complicados o desfigurantes, y no hay indicación de resonancia cerebral ni de estudio de neurofibromatosis.

TEMA 16.18 · PREGUNTA 47 EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 89

Una paciente consulta por una lesión en el antebrazo, que inicialmente era dolorosa y eritematosa, pero que a las 6...

CLAVE A **Loxoscelismo cutáneo**

Una lesión que inicia con dolor y eritema y en pocas horas se vuelve violácea, con zonas pálidas isquémicas y bordes geográficos (placa livedoide), es la presentación clásica del loxoscelismo cutáneo por mordedura de araña de rincón.

> **Perla.** El ectima aparece en días, el pioderma gangrenoso es una úlcera de borde socavado en un paciente con enfermedad de base y la fasceítis necrotizante cursa con toxicidad sistémica marcada y dolor desproporcionado.

TEMA 16.18 · PREGUNTA 48 EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 149

Paciente con dolor en zona escapular izquierda y lesión ulcerada con halo violáceo. ¿Cuál es el agente causal más...

CLAVE D **Loxosceles laeta (araña de rincón)**

Una lesión dolorosa, ulcerada o necrótica con halo violáceo en el tronco, en una persona que muerde al vestirse o dormir, corresponde a una mordedura de Loxosceles laeta (araña de rincón).

> **Perla.** Latrodectus produce un cuadro neurotóxico con dolor muscular y contracturas sin necrosis cutánea; Paederus causa dermatitis lineal ampollar y la miasis, un nódulo con larva.

TEMA 16.18 · PREGUNTA 49 Banco Oficial AEE · Perfil V3 6.01.3.002

Una madre consulta porque su hijo de 5 años fue mordido ayer por una araña de rincón en el muslo. El niño se encuentra...

CLAVE B **Medidas de sostén, frío local, analgesia, estudio de laboratorio y control en 24 a 48 horas**

Si no hay signos sistémicos se maneja como loxoscelismo cutáneo con reposo, frío local, analgesia, profilaxis antitetánica y curaciones, pero se deben controlar en las primeras 48 a 72 horas los parámetros de hemólisis y función renal (hemograma, LDH, bilirrubina, creatinina, orina) porque en los niños puede aparecer la forma cutáneo-visceral.

> **Perla.** La escisión precoz y el calor empeoran la lesión, y el suero se reserva para casos sistémicos.